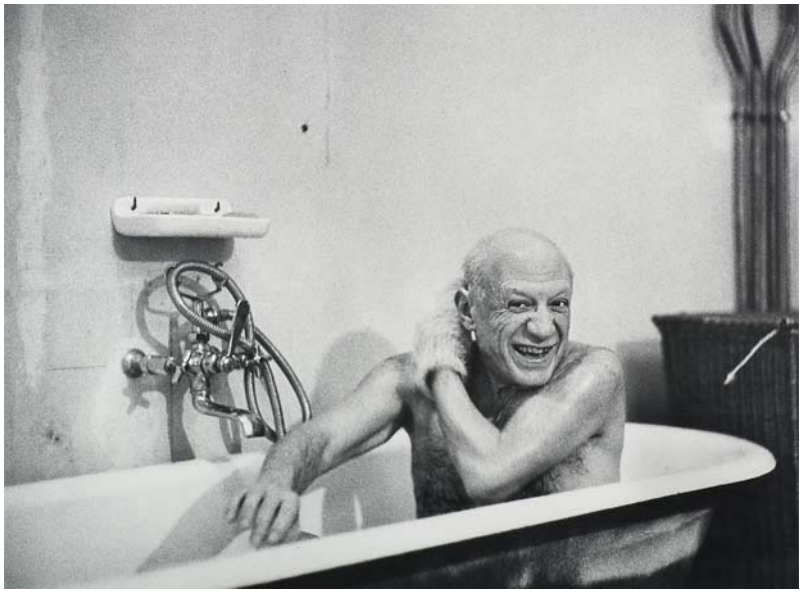
SOPORTE DE AYUDA PARA EL ESTUDIO MF1017_2

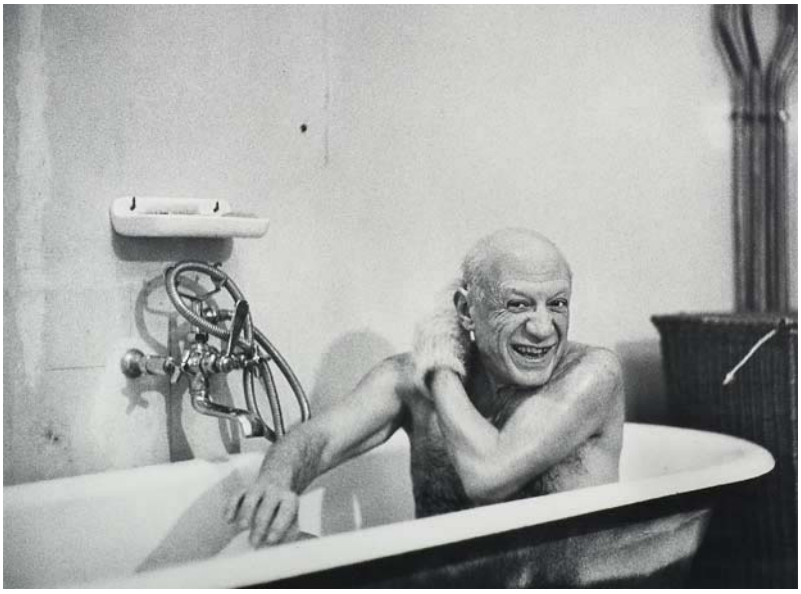


M.F. 1017_2:

Intervención en la atención Higiénico-alimentaria en instituciones.

MÓDULO FORMATIVO 2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES (MF1017_2; 70 horas)

Asociado a la UC 1017, desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas dependientes en el ámbito Institucional



Capacidades y criterios de evaluación

C1: Adaptar y aplicar las técnicas de higiene personal, analizando las características de los usuarios, e identificando las condiciones higiénicas que debe cumplir el entorno de los mismos.

CE1.1 Identificar las características psicofísicas de los colectivos de usuarios, con atención especial a las necesidades de atención física que se derivan del proceso de envejecimiento y/o de la discapacidad.

CE1.2 Describir las principales características anatomofisiológicas y la patología más frecuente del órgano cutáneo.

CE1.3 Determinar los cuidados higiénicos requeridos por el usuario en función de su estado de salud y nivel de dependencia.

CE1.4 Indicar los procedimientos de aseo personal, precisando los productos, materiales y ayudas técnicas para su realización en función del estado y necesidades del usuario.

CE1.5 Describir los mecanismos de producción de las úlceras por presión, los lugares anatómicos de aparición más frecuentes, así como las principales medidas y productos existentes para su prevención.

CE1.6 Señalar los procedimientos de recogida de heces y orina, precisando los materiales en función del estado y las necesidades del usuario.

CE1.7 Describir las técnicas de limpieza y conservación de prótesis.

CE1.8 Describir los procedimientos de amortajamiento de cadáveres, precisando los materiales y productos para su utilización.

CE1.9 En un supuesto práctico de atención a la higiene personal del usuario, debidamente caracterizado:

- Identificar y seleccionar los medios materiales que se van a utilizar en función del supuesto.
- Realizar técnicas de aseo personal.
- Efectuar la recogida de heces y orina con utilización de cuña y/o botella, así como la recogida de las mismas en persona usuarias incontinentes y/o colostomizados.

C2: Adaptar y aplicar las técnicas de mantenimiento del orden y de las condiciones higiénico-sanitarias del entorno del usuario.

CE2.1 Enumerar y caracterizar las condiciones higiénico-sanitarias que debe reunir el entorno habitual de la persona en la Institución.

CE2.2 Indicar las técnicas de realización y/o limpieza de la cama del usuario, así como los accesorios de uso más frecuente y criterios de sustitución de los mismos en situaciones especiales, atendiendo al mayor "confort" en función de las necesidades del usuario.

CE2.3 Describir los distintos tipos de colchones, de ropa de cama y de técnicas de doblaje y preparación para su posterior utilización.

CE2.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: realizar técnicas de preparación y apertura de la cama libre en sus distintas modalidades, ordenando, así mismo, la habitación del usuario.

C3: Aplicar la técnica de apoyo a la ingesta al usuario, siguiendo las indicaciones de administración prescritas.

CE3.1 Describir las principales características anatómofisiológicas y patológicas del aparato endocrino y del digestivo.

CE3.2 Describir las técnicas de administración de alimentos por vía oral, enumerando los materiales.

CE3.3 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, de situaciones de apoyo a la ingesta:

1) Indicar la postura anatómica más adecuada en función de la vía de administración del alimento.
2) Simular las técnicas de ayuda a la ingesta, en función del grado de dependencia del usuario.
3) Cumplimentar con datos supuestos los registros de su competencia en el formato y soporte correspondiente, así como las plantillas de dietas según las necesidades de cada persona usuaria.

Al margen de la consecución de los contenidos de este modulo formativo hay capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno real de trabajo y son:

1) C1 respecto a CE1.9; C2 respecto a CE2.4; C3 respecto a CE3.3.
2) Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos.
3) Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
4) Tratar al cliente o usuario con cortesía, respeto y discreción.
5) Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los usuarios.
6) Participar y colaborar activamente en el equipo, habituándose al ritmo de trabajo.
7) Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización.
8) Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
9) Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.

Contenidos

1. Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de su entorno en instituciones

1.1.- Principios anatomofisiológicos del órgano cutáneo y fundamentos de higiene corporal. Patología más frecuente.

EL ÓRGANO CUTÁNEO

La piel es el órgano más extenso del organismo y el que nos separa del mundo exterior a la vez que nos relaciona con él.

La piel cumple con funciones fundamentales para la vida. Entre estas podemos destacar:

1. Órgano sensorial de extraordinaria importancia
2. La protección (microorganismos, traumatismos, cambios externos)
3. La síntesis de sustancias (queratina, melanina, sudor…)
4. El balance hídrico.
5. La regulación de la temperatura.
6. La eliminación de desechos.

Está constituida por tres capas principales. Desde el exterior al interior, podemos distinguir:

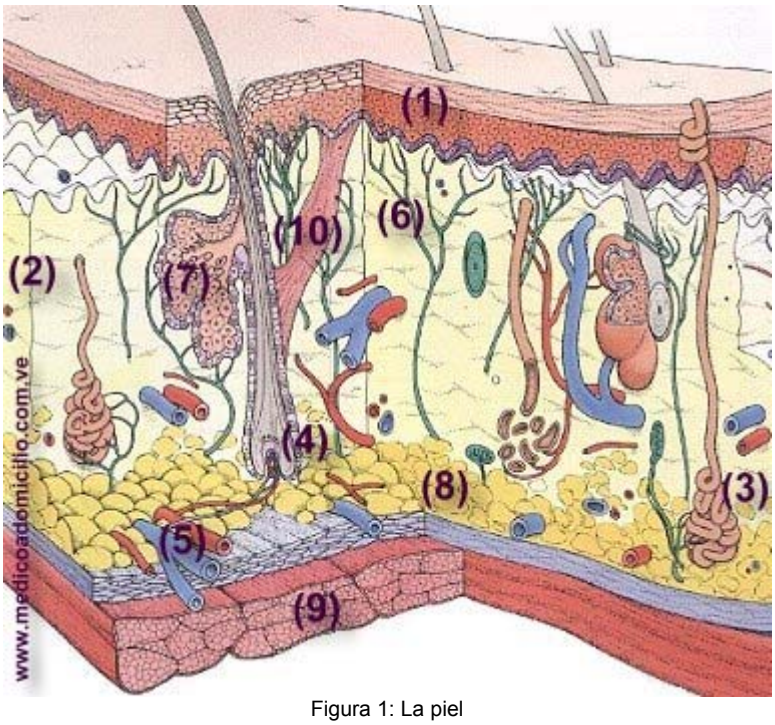


Figura 1: La piel

LA EPIDERMIS. (1 de la figura 1)

La epidermis es la capa más externa de la piel de entre 0'4 y 1'5 mm de grosor. A su vez está constituida por otras 4 capas que constantemente se van renovando desde el interior hacia el exterior.

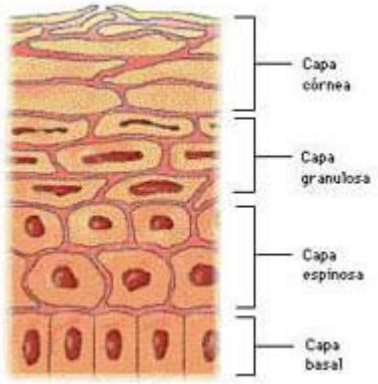
Las células más superficiales van siendo sustituidas por las que desde el interior migran. En el proceso de migración sufren cambios, se van volviendo más rígidas hasta que al final mueren. Este proceso se llama queratinización.

La epidermis no tiene vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas.

En ella podemos encontrar 4 tipos de células:

- Los *queratinocitos* sintetizan la queratina. Nacen en la capa más interna de la epidermis y migran hacia el exterior. En el viaje van sintetizando cada vez más queratina hasta que en el cuando llegan al exterior son todo queratina y mueren.
- Los *melanocitos* sintetizan la melanina. Esta nos protege de los rayos nocivos del sol (los ultravioleta) y es la causante de nuestro color moreno cuando la estimulamos con el sol. También interviene en la termorregulación.
- Las células de Langerhans: estas células están involucradas en gran cantidad de respuestas inmunes. La respuesta inmune es un sistema de defensa frente al los agentes extraños.

- Las células de Merkel participan en el sentido del tacto. Son especialmente abundantes en el pulpejo de los dedos y es por eso que tenemos ahí más sensibilidad que en otras zonas.



Capas de la epidermis

LA DERMIS (2 de la figura 1)

Es la capa intermedia y presenta muchísimas más estructuras anatómicas que la anterior. En la dermis podemos encontrar fibras (colágeno, elásticas,...), células, vasos sanguíneos (5 de la figura 1), terminaciones nerviosas (6 de la figura 1) y los anejos cutáneos.

Los *anejos cutáneos* son los siguientes:

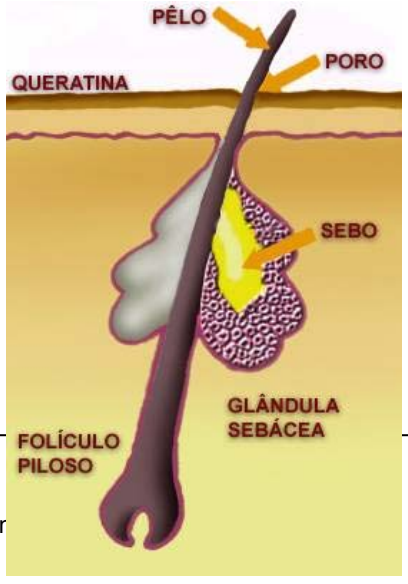
1. Pelo

Nace en el folículo piloso (4 de la figura1) y se distribuye por toda la superficie corporal excepto en las mucosas, las palmas y las plantas.

Son estructuras flexibles y resistentes constituidas por queratina dura.

El proceso de crecimiento del pelo está regulado por factores hormonales; por término medio, un cabello crece unos 0.3mm al día.

Junto al folículo se encuentra el músculo encargado de erizar el cabello y da lugar a la piel de gallina. Se llama músculo piloerector (10 de la figura1)



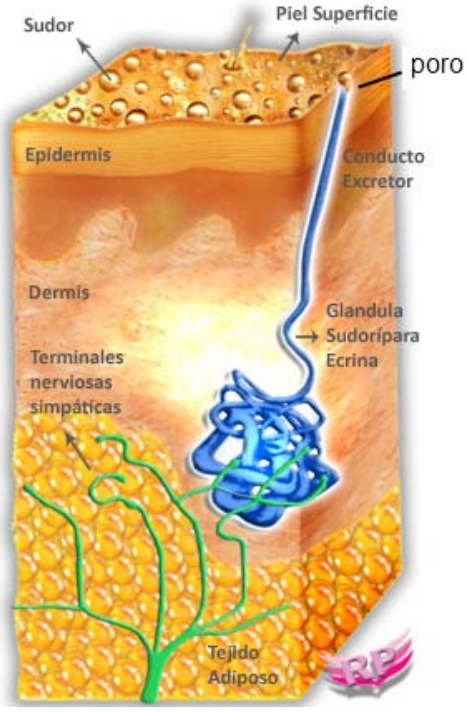
2. Uñas

Son placas córneas transparentes constituidas también por queratina dura. Tienen un crecimiento aproximado de 3mm al mes.

3. Glándulas sebáceas (7 de la figura 1):

Producen el sebo, sustancia con la que se engrasa la piel y el cabello como mecanismo de protección. El sebo se vierte al folículo piloso y de el sale al exterior de la piel.

4. Glándulas sudoríparas:



Las hay de dos tipos

Ecrinas: (3 de la figura1)

Son las encargadas de producir el sudor.

Se encuentran distribuidas por toda la piel, excepto en los labios, glande y prepucio y abundan en la frente, la espalda, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Tienen una parte profunda en la dermis donde se enrolla para atravesar la dermis en forma de conducto. El conducto termina en un orificio llamado poro desde donde drena el sudor.

Apocrinas:

Secretan un líquido relacionado con la atracción sexual.

Se localizan fundamentalmente en la axila, el área genital, la aureola y el pezón.

Son parecidas a la ecrinas pero en lugar de drenar el exterior desde un poro lo hacen al folículo piloso

El producto de secreción es un líquido, cuya función pudiera estar relacionada con la atracción sexual y comienzan a secretar lo en la pubertad.

LA HIPODERMIS.

Es la capa más profunda de la piel y está constituida por adipositos cuya misión es la de acumular grasa

Está en contacto con el tejido celular subcutáneo (8 de la figura 1) y la capa muscular que no pertenece a la piel (9 de la figura 1).

FUNDAMENTOS DE HIGIENE CORPORAL

La piel es la principal defensa frente a las agresiones del exterior, nos protege de los cambios de temperatura (frío/calor), de los traumatismos (heridas, golpes, etc.) y de las infecciones entre otras cosas.

Es evidente que resulta de vital importancia mantenerla en buen estado para lo que tenemos que mantenerla limpia e hidratada. Alimentarnos correctamente y realizar ejercicio físico también colaboran en que nuestra piel se mantenga en estado óptimo.

Una correcta higiene y aseo de la persona usuaria aporta una serie de beneficios al mismo tanto a nivel físico como a nivel psicológico.

Entre los beneficios físicos tenemos:

- Mantener en buen estado e íntegra la piel para que cumpla su función de barrera.
- Preservar su integridad, una falta de higiene acelera la formación de úlceras por ejemplo como se verá en el apartado 1.3 de este módulo.
- Mantener el manto ácido generado por las diferentes secreciones de la piel citadas en el estudio de la anatomía de la misma. El manto ácido actúa como antiséptico frente a los microorganismos.
- Facilitar la descamación de células muertas de la última capa de la epidermis.
- Facilitar la eliminación de sustancias de desecho liberadas por el sudor y que se depositan en el exterior.
- Es el momento utilizado para efectuar la inspección del estado de la piel en lo referente al aspecto (coloración, turgencia, etc.), la aparición de indicios de úlceras y/o evaluar su evolución y descubrir precozmente lesiones cutáneas.
- Controlar la temperatura corporal, controlando la temperatura desagua.
- Masajear mientras se asea a la persona usuaria, activa la circulación y facilita el drenaje de líquidos impidiendo que estos se acumulen (edemas)
- Movilización de articulaciones.

Entre los beneficios psicológicos tenemos:

- Mejorar la autoestima de la persona usuaria al evitar el mal olor.
- Aumentar la sensación de bienestar.
- Favorecer la relación y comunicación de la persona usuaria y el equipo de profesionales sociosanitarios.
- Trasmitir técnicas de auto-cuidado, permitiendo que la persona usuaria participe en su higiene en la medida de lo posible.

LESIONES Y PATOLOGÍAS DE LAPIEL MÁS FRECUENTES

Las lesiones de la piel pueden ser primarias y secundarias, siendo estas últimas modificaciones de las primarias. Las lesiones pueden ser además signo de patología cutánea.

Las lesiones primarias más habituales son:

- *Mácula*: lesión de pequeño tamaño (menor a 1 cm de diámetro) caracterizada por ser plana y presentar un color diferente al de la piel que la rodea (rojizo o violácea).
- *Pápula*: lesión cutánea bien delimitada que se caracteriza por su elevación y por no contener líquido; es sólida, de color variable y de tamaño *menor* a 1 cm de diámetro.
- *Vesícula*: ampolla o vejiga de reducido tamaño y de paredes finas, con *elevación y contenido líquido transparente.*
- *Pústula*: vesícula que contiene líquido purulento.
- *Ampolla*: vesícula de más de 1 cm de diámetro rellena de un fluido claro. También se conoce con el nombre de *flictena*.
- *Petequias*: manchas pequeñas (generalmente, menores a 0.5 cm) de color rojo o púrpura con extravasación de sangre.
- *Nódulo*: elevación sólida mayor a 1 cm que presenta infiltración.

Las lesiones secundarias más habituales son:

- *Escama*: fragmento de la epidermis, con células queratinizadas, fácilmente exfoliable en pequeñas láminas blanquecinas o grisáceas.
- *Placa*: elevación de más de 1 cm de diámetro. Suele ser rugosa y dura.
- *Costra*: placa rugosa y seca, de color marrón, rojo o negro. Se forma por acumulación de sangre y exudados secos en procesos de evolución de otras lesiones.
- *Erosión*: excavación en la epidermis húmeda, lisa y brillante.
- *Cicatriz*: tejido duro que aparece en el lugar en el que hubo una herida.
- *Quiste*: lesión redondeada, elevada y palpable de consistencia elástica que contiene material fluido o semisólido.

- *Úlcera*: Afecta a la epidermis y a la dermis pero que puede seguir avanzando hasta capas más profundas formando un cráter, de tamaño variable, exudativa o supurativa y de color rojo a rojizo azulado. Se tratan con especial atención y hablaremos más de ellas en el apartado 1.3 de este módulo.

- *Equimosis:* coloración rojo-azulada que aparece tras la agresión mecánica y evoluciona a un color amarillo-verdoso. Se produce por extravasación sanguínea.

- *Hematoma*: abultamiento de varios centímetros que implica extravasación de sangre mayor que la equimosis.

- *Fisura*: solución de continuidad en la piel de aspecto lineal.

Patologías cutáneas más frecuentes.

- *Prurito*: sensación desagradable de picor u hormigueo en la piel que produce el deseo de rascarse. Su principal causa es la sequedad, aunque puede ser síntoma de otras enfermedades.

- *Foliculitis* y *forúnculos* de uno o más folículos pilosos: Aparecen nódulos eritematosos y endurecidos alrededor del folículo piloso y luego evoluciona a pústula y costra. Se produce por infección bacteriana.

- *Impétigo*: infección bacteriana que comienza por un eritema que evoluciona a vesícula, pústula y costra.

- *Dermatitis*: inflamación de la piel causada por agentes alergénicos o irritantes. Cursa con prurito, edema, pápulas y vesículas. Con la evolución aparecen costras y descamación.

- *Herpes simple*: infección vírica (producida por virus) que suele localizarse en labios y boca, caracterizada por la aparición de eritema y vesículas, con prurito y quemazón.

- *Herpes Zoster*: infección vírica caracterizada por eritema y dolor intenso. Se produce por una reactivación del virus de la varicela en situaciones de déficit inmunitario. La lesión es similar a la del herpes simple, pero es más dolorosa, y se extiende a lo largo del recorrido de un nervio.

- *Tiña o pie de atleta*: infección superficial por hongos que cursa con vesículas, descamación y agrietamiento en la planta del pie y pliegues interdigitales (entre los dedos).

- *Pediculosis*: infestación producida por piojos en cuero cabelludo, párpados, pestañas o vello púbico. Produce prurito y lesiones erosivas por rascado, que pueden llegar a infectarse. Se contagia por contacto directo.

- *Sarna o escabiosis*: enfermedad contagiosa producida por el ácaro Sarcoptes Scabiei, que excava un túnel en la epidermis, donde deposita sus huevos. Cursa con un aumento de prurito por la noche y erosiones en la piel debido al rascado.

- *Candidiasis* mucocutánea: infección producida por el hongo Cándida Albicans, cuyo desarrollo se ve favorecido por la existencia de humedad en la zona. Es muy frecuente la afectación de los pliegues submamarios y genitales.

- *Alopecia*: caída del cabello que suele ser gradual, difusa o en placas. Está relacionada con la edad, pero también algunos tratamientos y afecciones pueden precipitarla.

- *Hipertricosis*: aumento del número de pelos de forma difusa o localizada.

- *Tumores cutáneos*: se producen por un crecimiento anormal de las células de la piel. Pueden ser benignos o malignos.

Entre los benignos encontramos:

- *Verruga*: lesión cutánea con superficie rugosa y papilomatosa de origen vírico. . Angioma: tumor benigno constituido por vasos sanguíneos (hemangioma) o vasos linfáticos (linfagioma). La mayoría son congénitos.

- *Nevus* o lunares: pápulas o máculas hiperpigmentadas por cúmulo de melanocitos.

Entre los malignos:

- . *Melanoma*: neoplasia maligna de la piel constituida por melanocitos. La mayoría se desarrollan sobre nevus pigmentados. Cualquier mancha negra o marrón de borde irregular que haya presentado cambios de tamaño, forma o consistencia se debe biopsiar.

- . *Epitelioma basocelular*: es el más común de todos los tumores cutáneos malignos. Son muy raras las metástasis.

- . *Epitelioma espinocelular*: presenta una base infiltrada y superficie hiperqueratósica. Se localiza en áreas expuestas al sol. Es responsable de metástasis a distancia.

1.2.- Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal:

Hay que asear además de la piel, las mucosas, uñas, el cabello y la boca y la dentadura (propia o prótesis). Es importante aprovechar la intimidad creada para Impulsar la comunicación y la inspección del estado general de la piel, siempre teniendo en cuenta la edad y estado físico y psíquico de la persona usuaria.

Consideraciones generales para cualquier técnica de higiene:

1. Valorar el tipo de técnica a realizar en función de: grado de dependencia, necesidades higiénicas y estado de salud de la persona usuaria,

2. Mantener la intimad de la persona usuaria utilizando

   - cortinas o bimbos para separarlo visualmente de su compañero si lo tuviere.
   - manteniendo las puertas y ventanas cerradas. A la vez evitamos corrientes de aire
   - invitando a abandonar la habitación al restote personas.
   - preparar todo el material antes de empezar, para no tener que salir y dejar solo a la persona usuaria durante el aseo.
   - descubrir únicamente la parte de la persona usuaria sobre la que estamos actuando, manteniendo el resto del cuerpo cubierto con una toalla o sabana para evitar que se enfrié y mantener su intimidad.

3. Realizar siempre que sea necesario y como mínimo una vez al día.

4. Proporcionar seguridad realizando la higiene entre dos personas si es posible y utilizando barandillas de seguridad.

5. Evitar corrientes de aire y mantener una Tª adecuada en la habitación (entre 22- 24º C).

6. Utilizar jabones neutros adecuados para mantener el ph. (5,5) de la piel.

7. Mantener la Tª del agua entre 1-2º por encima de la Tª corporal (38º C).

8. Seguir un orden establecido, salvo contraindicación será DE LIMPIO A SUCIO y DE ARRIBA A BAJO.

9. Cuidar especialmente las sondas o sueros que pueda tener puesto la persona usuaria para evitar su desinserción.

En función de las condiciones, deseos y necesidades de la persona usuaria y de los recursos tenemos diferentes opciones que a continuación iremos comentando.

Baño en bañera o ducha.



Para la persona usuaria autónomo o aquel que necesita ayuda pero que no está encamado, la labor del profesional sociosanitario es la de AYUDAR en función a sus necesidades. Es parte de vuestra labor realizar un seguimiento mientras dura el procedimiento.

Para el baño en ducha o bañera existen una serie de recursos materiales que facilitan el aseo tales como sillas, grúas, duchas adaptadas, bañeras adaptadas…









Hay que cuidar las condiciones ambientales, ambiente a 25ºC, el agua a 36-37ºC, evitar las corrientes de aire y los suelos resbaladizos

La persona usuaria debe disponer de los recursos materiales que le facilitará el profesional sanitario antes de efectuar el baño si este fuera autónomo y si el aseo se lo efectúa el profesional, nunca comenzar sin tener a mano todos los recursos.

Los materiales necesarios son:

- Toalla (1 o 2)
- Esponjas (diferentes para la cara y el cuerpo)
- Jabón líquido (si las esponjas no son prejabonadas)
- Peine
- Cepillo dental, pasta y colutorio
- Material para el rasurado de la barba
- Pijama limpio, bata y zapatillas

Si la persona usuaria no puede realizar su higiene de forma independiente, se le prestará la ayuda necesaria para desvestirse, bañarse, aplicarse crema, volver a vestirse y acomodarse.

Se vigilaran las medidas de seguridad, sobre todo si el suelo está mojado.

La higiene se puede realizar de pie o sentado en una silla de baño si la persona usuaria lo necesita.

Baño en la cama.

El baño en cama puede ser completo, todo el cuerpo, o parcial, solo algunas partes.

ASEO DE LA PERSONA USUARIA ENCAMADO

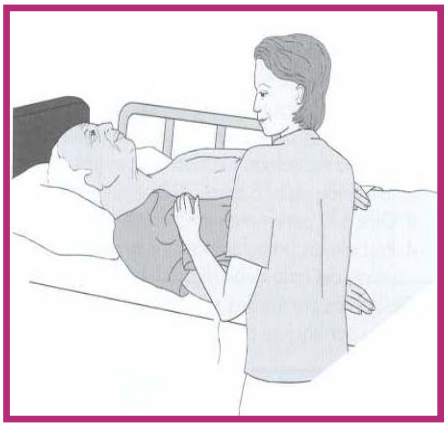
Se realiza en aquellas personas usuarias que por su estado no se pueden levantar de la cama aunque conserven su movilidad.

Material necesario:

- Guantes.
- 2 palanganas con agua caliente.
- Esponjas desechables.
- Toalla de baño y de cara (Pueden ser de celulosa).
- Gasas.
- Pijama o camisón.
- Crema hidratante.
- Ropa de cama.
- Bolsa para ropa sucia.
- Peine.

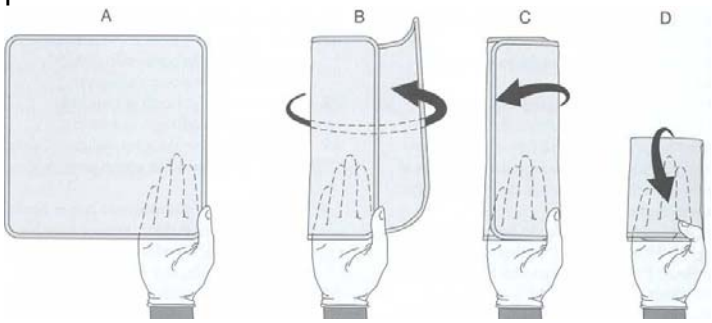
Procedimiento:

1. Explicar a la persona usuaria que es la hora del baño y pedir su colaboración.
2. Ofrecer la cuña o botella antes de iniciar el aseo.
3. Situar el material necesario de manera que esté a nuestro alcance.
4. Llenar las palanganas con agua caliente. En una de ellas echar jabón líquido. En el momento en el que el agua de cualquier palangana esté sucia o la de enjuagar se llene de jabón, se debe cambiar por agua limpia
5. Lavarse las manos y ponerse los guantes.
6. Colocar a la persona usuaria en decúbito supino, retirándole la almohada si es posible.
7. Situarse a un lado de la persona.
8. Desvestir a la persona usuaria y cubrirlo con la sabana o con una toalla (grande) para preservar su intimidad.
9. Iniciar el lavado por la cara con agua SIN USAR JABÓN





- Los ojos se lavan con gasa húmeda, del borde interno al extremo para evitar contaminar el conducto lacrimal y usando una distinta para cada ojo. En el apartado higiene de zonas de riesgo se amplia el procedimiento.
- Para la higiene de los oídos, se empleará una gasa, no bastoncillos de algodón.
- Si no se dispone de manoplas o esponjas exclusivas para la cara, se puede elaborar una utilizando una toalla.



10. Continuar con orden descendente: cuello, hombros, axilas, manos, tórax, abdomen, piernas y pies

- Levantar el brazo más cercano a nosotros y poner la toalla pequeña debajo de él. Esta toalla servirá para evitar humedecer la cama a lo largo del aseo. Sosteniendo el brazo por encima de la muñeca, lavar el hombro, la axila y el brazo; enjabonando, enjuagando y secando.



- Poner la palangana de jabón sobre la cama e introducir la mano de la persona en ella. Enjabonar muy bien, haciendo hincapié en las uñas y entre los dedos. Enjuagar y secar. Realizar la misma maniobra con el otro brazo.

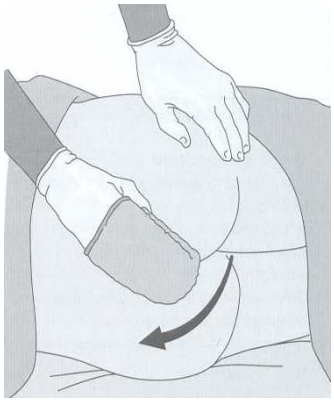
- Descubrir la zona del pecho doblando por la mitad la toalla grande que cubría a la persona, enjabonar y enjuagar esa zona. Secar muy bien, sobre todo debajo de las mamas de la mujer.



- Tapar el pecho y descubrir el abdomen doblando la toalla ahora sobre el pecho. Enjabonar, enjuagar y secar con movimientos circulares para estimular los movimientos intestinales, hacer hincapié en el ombligo.
- Descubrir totalmente la pierna más cercana a nosotros y colocar la toalla protectora debajo de ella. Enjabonar, enjuagar y secar muslo y pierna.



- Pedir a la persona que se vuelva sobre un lado de tal forma que nos muestre la espalda. Asegurarse de que está estable y no se puede caer. Colocar la toalla protectora, sobre la cama, a lo largo de la espalda de la persona usuaria. Enjabonar, enjuagar y secar la espalda y las nalgas utilizando movimientos largos y circulares.



11. Posicionar de nuevo en decúbito supino y lavar la zona genital tal y como indicamos más adelante.
12. Vestir a la persona usuaria con pijama y camisón.
13. Cambiar la ropa de la cama.

14. Peinarlo y dejar a la persona usuaria en una posición cómoda.

Observaciones:

- Descubrir únicamente la zona sobre la que se está actuando.
- Cambiar el agua y la esponja tantas veces como sea necesario.
- Ofrecer a la persona usuaria la posibilidad de lavar él mismo la zona genital si puede hacerlo.
- Se pueden realizar aseos parciales de diversas zonas del cuerpo si se necesita.
- Escurrir bien la esponja para no mojar la cama innecesariamente.
- Secar muy bien las zonas entre los dedos de manos y pies, el ombligo, las axilas, los pliegues mamarios de la mujer, las ingles y el debajo del escroto de los hombres.
- Procurar que el baño no dure más de quince minutos.
- Observar cuidadosamente la piel.
- Aprovechar este momento de intimidad para dialogar con la persona que está cuidando

En los siguientes videos se puede ver aseos de persona usuarias encamados con diferentes grados de dependencia:

- si la persona usuaria colabora: http://www.youtube.com/watch?v=nzz4WmqnW84&feature=related
- si no colabora tenéis el video en dos partes: http://www.youtube.com/watch?v=L1oXwHhWyco&feature=related (parte 1) y http://www.youtube.com/watch?v=Jlm3SvguPFc&feature=related (parte 2)

Por partes vamos a lavar: cabello, barba y uñas. También la higiene perineal y bucal son aseos parciales pero les dedicaremos un apartado aparte.

ASEO DEL CABELLO



1) Lavarse las manos y utilizar guantes desechables.
2) Preparar el material necesario: bañera hinchable para el aseo (en su defecto una palangana, un hule y una pinza para sujetarlo) , jarras con suficiente agua tibia (± 37ºC), champú de Ph neutro, toallas, peine, secador de pelo y torundas.
3) Saludar a la persona usuaria y explicarle qué se va a hacer, lograrás una mejor colaboración.
4) Comprobar la tª ambiente y la ausencia de corrientes de aire

5) Cuidar en todo momento la intimidad de la persona usuaria aunque no os ve nadie
6) Vigilar su seguridad.
7) Colocar la cama horizontal
8) Colocar el dispositivo bajo la cabeza (la cabeza debe quedar en hiperextensión la cabeza de la persona usuaria (posición de Roser)
9) Proteger los ojos con la mano.
10) Mojar el cabello y aplicar champú.
11) Frotar y dar un masaje realizando movimientos circulares y suaves con las yemas de los dedos en todo el cuero cabelludo.
12) Aclarar el cabello a fondo protegiendo los ojos. Repetir dos veces la técnica.
13) Secar el cabello con una toalla, suavemente.
14) Una vez finalizado el aseo retirar el dispositivo
15) Peinar y secar con el secador eléctrico el cabello

RASURADO DE LA BARBA



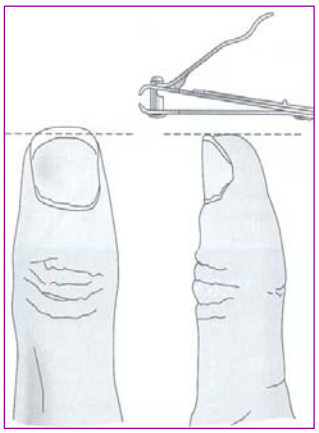
Hay que afeitar en la dirección del crecimiento del pelo, aplicando pasadas más largas en las zonas más amplias de la cara. Las pasadas más cortas se aplican alrededor de la barbilla y de los labios.

CUIDADO DE LAS UÑAS

La higiene y corte de la uña puede realizarse junto al aseo general o independiente de él.

Se necesita empapador, palangana, jabón adecuado y esponjas desechables, cepillo de uñas, tijera de punta roma o cortaúñas de manos y pies y limas de uña.

Procedimiento:



1) Explicar el procedimiento a la persona usuaria y pedir su colaboración.
2) Lavarse las manos y ponerse los guantes.
3) Proteger la cama con un empapador bajo la mano o el pie, según la zona de que se trate.
4) Lavar la mano o el pie con la esponja. Las uñas con la edad se endurecen mucho por eso es conveniente dejarlas a remoja unos minutos.
5) Pasar el cepillo de uñas sin lesionar la piel.
6) Secar, insistiendo en los pliegues interdigitales.
7) Si la uña es muy gruesa, se puede limar por encima, para disminuir el grosor, antes del corte

8) Cortar las uñas de las manos siguiendo la forma del dedo y rectas las de los pies, asegurándonos que la tijera o el cortaúñas sobresale por el lecho ungueal antes de iniciar el corte, para evitar la formación de picos que darían lugar a una onicocriptosis o uñas encarnadas.
9) Si, tras el corte en recto de las uñas de los pies, las esquinas de las mismas sobresalen, se pueden limar ligeramente, siempre dejando la uña al aire sin apoyar en la falange.
10) Acomodar a la persona usuaria, lavarse las manos y registrar las incidencias si las hubiera.

Baño de personas con alzhéimer.

A algunas personas con la enfermedad de Alzheimer no les supone ningún problema el asearse o bañarse; sin embargo, a otras les puede provocar confusión y miedo. Por ello, es importante preparar este momento, debiendo seguir una serie de recomendaciones que permitirán a la persona usuaria asimilar el procedimiento más fácilmente:

- Planear el baño a una hora que la persona usuaria se encuentre tranquilo y hacer de esta hora una rutina.
- Preparar todo el material antes de comenzar el aseo.
- Ser amable y respetuoso con la persona usuaria, para transmitirle confianza.
- Explicarle el procedimiento con paciencia y repetirle aquellos puntos que le produzcan mayor ansiedad.
- Reducir el miedo de la persona usuaria haciendo uso de ayudas tales como asiento en la ducha, barras para el agarre o alfombras antideslizantes.
- NUNCA dejar a la persona sola en el baño. Mantenernos vigilantes y prestarle toda la ayuda que necesite.

Una vez iniciado el proceso del baño, se intentarán aplicar los procedimientos explicados más arriba, si bien en muchos casos es posible que el enfermo de Alzheimer requiera para realizar esta tarea mayor tiempo que en persona usuarias que padezcan otra discapacidad.

Cuidado de los pies de personas con diabetes.

La diabetes mellitus (DM) es un trastorno metabólico del proceso que convierte el alimento que ingerimos en energía y que se manifiesta por unos niveles de glucosa en sangre que se sitúan por encima de los límites normales. La insulina, hormona segregada por el páncreas, es el factor más importante en la regulación de los niveles de azúcar. En las personas diabéticas, el páncreas no produce insulina o las células no responden a ella.

Las personas que sufren diabetes mellitus son más propensas a tener problemas en los pies. La diabetes puede ocasionar daño a los nervios (neuropatía diabética), lo que puede hacer que la persona usuaria sea menos capaz de percibir una lesión o presión en los pies, siendo posible que no note dicha lesión hasta que se presente un daño o infección grave.

La diabetes, además, cambia la capacidad del cuerpo para luchar contra las infecciones. El daño producido en los vasos sanguíneos, secundario a la diabetes, provoca que llegue menos sangre y oxígeno a los pies. Debido a esto, pequeñas llagas o heridas de la piel pueden convertirse en úlceras cutáneas más grandes y profundas que provocan problemas a nivel muscular u óseo. En estos casos más graves incluso puede llegar a ser necesaria la amputación del miembro afectado como última medida.

Como medida preventiva, se pueden llevar a cabo los siguientes cuidados en el pie de la persona diabética:

- Revisar los pies todos los días. Inspeccionar el empeine, las plantas, los talones y los espacios interdigitales. Controlar la aparición de durezas, heridas, ampollas, uñas encarnadas, etc.
- Lavar los pies todos los días con agua tibia y jabón suave. Para ello:

1. Si la persona usuaria es autónomo, hacer que pruebe la temperatura del agua con los dedos de las manos o el codo antes de sumergir los pies en ella. Como hemos apuntado más arriba, la persona usuaria con diabetes puede tener una sensibilidad menor en los pies y no percibir si el agua está demasiado caliente, produciéndose quemaduras con facilidad.
2. Secar suavemente y por completo los pies, en particular entre los dedos, ya que hay más riesgo de infección en las áreas húmedas.
3. La piel de los pies puede resecarse y resquebrajarse, causando heridas que pueden infectarse. Después del baño, aplicar loción hidratante, vaselina o aceites.

- Una vez realizado el baño de pies, es el momento adecuado para cortar las uñas, ya que el agua las ablanda. Procederemos a cortarlas siguiendo una línea recta, intentando evitar que la uña pueda encarnarse, lo cual es un mayor problema en los persona usuarias diabéticos, debido a la mala evolución de sus heridas.
- Las medias y los calcetines deben ser de algodón, transpirables y muy holgados, de forma que no compriman la pierna ni presionen ninguna zona del pie, ya que ello haría que disminuyera la circulación.
- El calzado elegido debe ser cómodo, de tacón bajo, puntera ancha y de material transpirable para evitar la humedad excesiva.
- La persona usuaria debe evitar sentarse con las piernas cruzadas o pararse en una misma posición durante un tiempo prolongado.

Los persona usuarias diabéticos o con problemas circulatorios no deben de cortarse las uñas. En su lugar, deben limárselas para controlar su crecimiento, pues cualquier herida, por pequeña que sea, puede producir graves problemas debido a

la deficiente cicatrización que presentan estas patologías. Debido al enorme riesgo que ello entraña, el cortado de uñas en el pie diabético SOLAMENTE se realizará cuando el médico lo haya autorizado expresamente

Higiene bucal.

La higiene bucal tiene como objetivos mantener una limpieza apropiada en la cavidad oral; evitar caries, sequedad, malos olores, o grietas en lengua y labios; y prevenir la aparición de infecciones.

Se deberá estimular a la persona usuaria a que la realice él mismo. Según el nivel de dependencia, vamos a diferenciar tres grados de intervención del profesional en este proceso: en persona usuaria consciente, en persona usuaria inconsciente y en persona usuaria usuario de dentadura postiza.

PERSONA USUARIA ENCAMADO CONSCIENTE.

El material necesario es:

- Cepillo de dientes.
- Pasta de dientes.
- Vaso con agua
- Antiséptico bucal.
- Batea
- Toalla.
- Vaselina.



Procedimiento de actuación

1) Prepararemos el material, nos lavaremos las manos y nos pondremos los guantes.
2) Explicaremos a la persona usuaria el procedimiento.
3) Incorporaremos a la persona usuaria y lo pondremos en posición de Fowler (sentado en la cama).
4) Ofreceremos agua para enjuagarse la boca.
5) Cogeremos el cepillo y pondremos pasta de dientes.
6) Frotaremos todas las piezas dentarias y la lengua si él no es válido y si lo es será él mismo quien efectúe la maniobra.
7) Después ofreceremos agua con antiséptico para enjuagarse la boca y tirara el agua en la batea.
8) Se secará o le secaremos los labios y ofreceremos un poco de vaselina para los labios.
9) Recogeremos el material, colocaremos a la persona usuaria, nos quitaremos los guantes, nos lavaremos las manos.

En el siguiente video tenéis un resumen junto a la higiene de ojos y oídos http://www.youtube.com/watch?v=UfQibarzXmU

PERSONA USUARIA ENCAMADO INCONSCIENTE.

El material necesario es:

- Guantes.
- Un vaso con agua y antiséptico.
- Gasas
- Pinzas de sujeción.
- Toalla
- Batea
- Vaselina.

Procedimiento de actuación

1) Prepararemos el material, nos lavaremos las manos, nos pondremos los guantes y explicaremos la persona usuaria el procedimiento.
2) Incorporaremos a la persona usuaria en posición de Fowler.
3) Colocaremos la toalla debajo de la barbilla.
4) Haremos una torunda y la mojaremos en el agua con antiséptico.
5) Limpiaremos toda la boca.
6) Secaremos la boca y pondremos vaselina en los labios.
7) Recogeremos el material, colocaremos a la persona usuaria, nos quitaremos los guantes, nos lavaremos las manos y registraremos la técnica en la historia clínica.

PERSONA USUARIA CON PRÓTESIS

El material necesario es:

- Guantes
- Toalla
- Batea
- Gasas
- cepillo dental o cepillo para limpieza de prótesis.
- Dentífrico y solución antiséptica.

Procedimiento de actuación

a. Lavarse las manos y ponerse guantes.
b. Proteger el tórax del usuario con una toalla.
c. Pedir al usuario que se quite la prótesis. Si no puede, la retirará el técnico sociosanitario con una gasa estéril y la colocará en una batea.
d. Cepillar la prótesis con el cepillo y pasta dentífrica o solución antiséptica.

e. Aclarar con abundante agua fría, pues el agua caliente puede alterar algunos materiales de las prótesis.
f. Proporcionar un vaso con agua o antiséptico al usuario para que se enjuague la boca y pañuelos desechables para secarse.
g. Recoger el material.
h. Acomodar al usuario, quitarse los guantes, lavarse las manos y registrar las posibles incidencias.

Si después de la higiene bucal el usuario no desea ponerse su prótesis, se depositará en recipientes especiales para ello o bien en vasos tapados con una gasa, convenientemente identificados, en el cuarto de baño del usuario

Limpieza de pliegues corporales.

A la hora de realizar la higiene diaria, debemos prestar especial atención a la limpieza de los pliegues corporales, así como a su posterior secado, para evitar que la humedad se acumule en esas zonas y lleguen a irritarse o macerarse.

Los grupos de personas en los que vamos a encontrar mayor incidencia de pliegues corporales son los ancianos y las personas obesas.

Limpieza de zonas de riesgo.

HIGIENE GENITAL

El objetivo de esta técnica es evitar infecciones urinarias y ulceraciones, así como proporcionar a la persona usuaria una sensación de bienestar y comodidad. Se realiza siempre al final del aseo general, después de las deposiciones y cada vez que sea necesario.

Se necesitará: guantes desechables, toallas, cuña, palangana con agua caliente (aproximadamente 37º C), empapadores, gasas o torundas, esponjas desechables, jabón líquido y una jarra o/y vaso.

Procedimiento general:

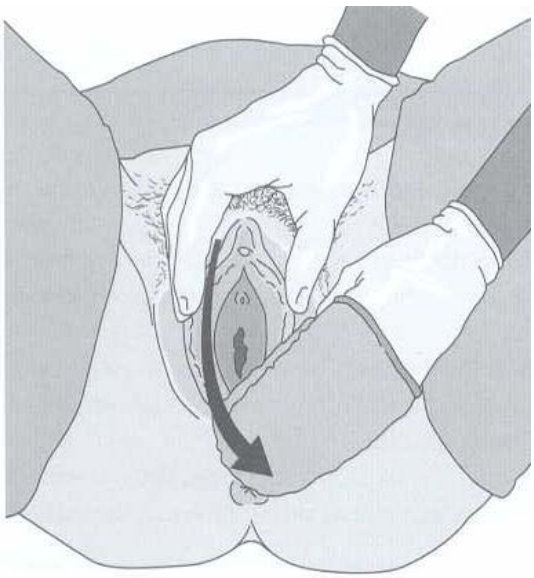
2. Explicarle a la persona usuaria la técnica que vamos a realizar y pedir su colaboración.
3. Preparar y acercar todo el material necesario
4. Lavarse las manos y ponerse los guantes.
5. Colocar a la persona usuaria en posición ginecológica de encamado si es mujer y en decúbito supino con piernas separadas si es hombre.
6. Dejar al descubierto la zona genital, cubriendo en resto del cuerpo.
7. Colocar un empapador debajo de los glúteos y colocar la cuña.
8. Verter el agua templada sobre los genitales.

Higiene genital masculina:

9. Enjabonar el pene y los testículos.
10. Si la persona usuaria no está circuncidado, retroceder el prepucio y limpiar el glande realizando movimientos circulares desde el meato hacia fuera. Utilizar una esponja o torundas exclusivamente para ello.
11. Aclarar con abundante agua y secar suavemente. Colocar el prepucio en su posición original.
12. Si no se ha hecho la higiene general, colocar a la persona usuaria en posición decúbito lateral y proceder al lavado y secado de la zona peri-anal: ano y pliegue Inter.-glúteo.

Higiene genital femenina:

1. Enjabonar y lavar la zona genital en el siguiente orden: pubis, zona interna de los muslos, meato urinario, labios menores, labios mayores, hendidura vulvar, ano. Y terminar con el pliegue interglúteo.



2. Separar los labios mayores con una mano y con la otra lavar de arriba abajo y de dentro hacia fuera, utilizando esponja o torundas para cada maniobra. Prestar especial atención a los pliegues que hay entre los labios mayores y menores.
3. Aclarar con abundante agua y secar suavemente.
4. Si no se ha hecho la higiene general, colocar a la persona usuaria en posición de decúbito lateral y proceder al lavado y secado de la zona peri-anal: desde la hendidura vulvar hasta el ano y pliegue interglúteo.

En los siguientes videos tenéis un resumen de ambos procedimientos

Higiene genital masculina:
http://www.youtube.com/watch?v=mhcJ4oXZ4mE&feature=related

Higiene genital femenina:
http://www.youtube.com/watch?v=e3ICptWiH2s&feature=related

Observar el flujo excesivo de los orificios perineales genitales y la existencia de olores que nos puedan indicar presencia de infecciones.

LAVADO de OJOS

El material necesario es:

- Gasas estériles.
- Suero fisiológico.
- Dos jeringas de 10 cc. o solución salina en monodosis.
- Guantes no estériles.

Procedimiento de actuación

- Lavarse las manos y colocarse los guantes
- Si la persona usuaria está consciente, explicarle el procedimiento que vamos a realizar y pedir su colaboración.
- Si la persona usuaria está encamado, y no está contraindicado, elevar la cabecera de la cama hasta una posición de sentado o semi-incorporado (posición Fowler o semi-Fowler).
- Humedecer una gasa con solución salina y limpiar desde el lagrimal al ángulo externo de cada ojo, hasta que quede limpio de secreciones. Utilizar una gasa distinta para cada ojo. Durante este proceso la persona usuaria permanecerá con los ojos cerrados.
- Cargar dos jeringas con 10 cc. de suero fisiológico (una para cada ojo) o utilizar solución salina en monodosis.
- Mantener la cabeza ladeada en relación con el ojo que vamos a lavar.
- Abrir los párpados de la persona usuaria con los dedos índice y pulgar de una mano y con la otra aplicar suero fisiológico desde el lagrimal a su zona externa, utilizando una jeringa para cada ojo y evitando tocar los párpados o la córnea.
- Secar con una gasa estéril cada ojo.
- Administrar tratamiento si estuviese prescrito.
- Cerrar suavemente los párpados.
- Colocar a la persona usuaria en una posición cómoda.
- Recoger el equipo y ordenar el cuarto.
- Retirar los guantes y lavar las manos.
- Anotar observaciones en la historia de la persona usuaria si fuese preciso.

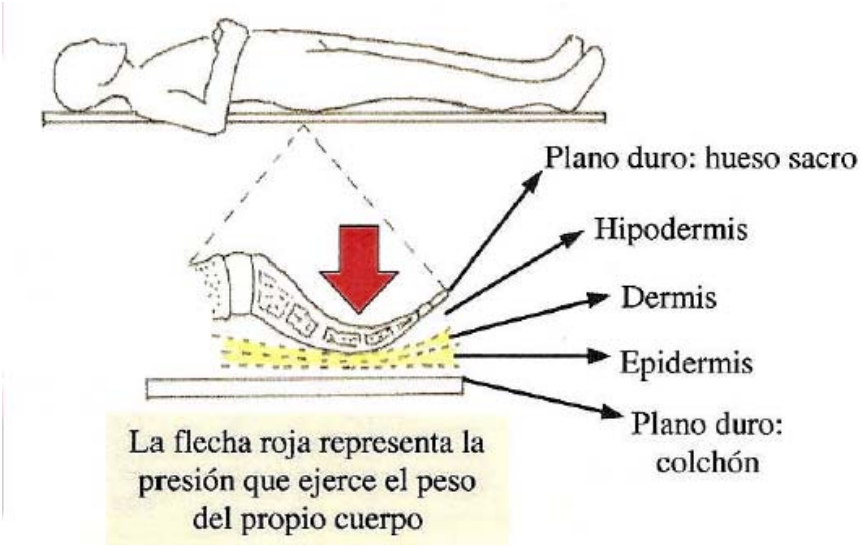
Si la persona usuaria está inconsciente, mantendremos sus ojos siempre cerrados para favorecer el nivel adecuado de humedad de la córnea y dejar los ojos tapados con gasas impregnadas en suero fisiológico, que serán cambiadas cada dos horas.

Siempre se utilizará una gasa distinta para cada ojo.

Las ayudas técnicas existentes para facilitar el aseo y la higiene del paciente se verán en el apartado 1.3 del MF 3 (1018) de este manual

1.3. - Prevención y tratamiento de las úlceras por presión:

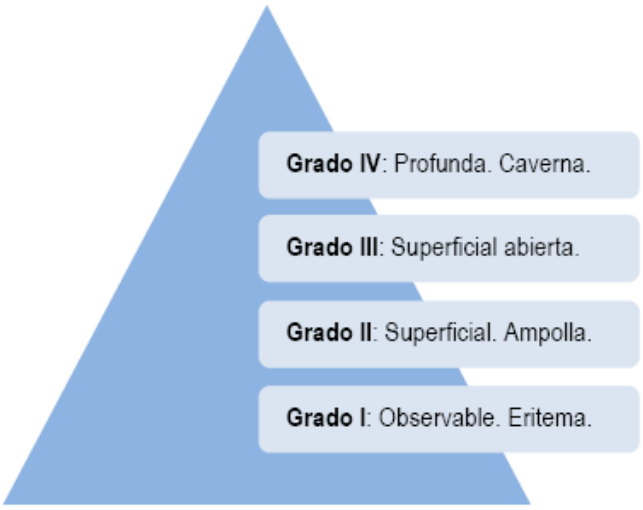
Las úlceras son lesiones de origen isquémico[3] causadas en la piel y tejidos subyacentes, que se producen por presión anormal y sostenida, en general sobre planos óseos.



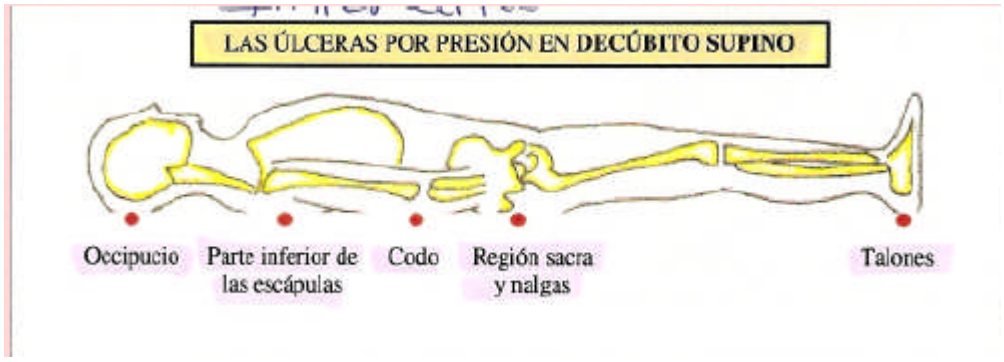
La evolución de una úlcera da 4 tipos clasificados como ESTADIOS.

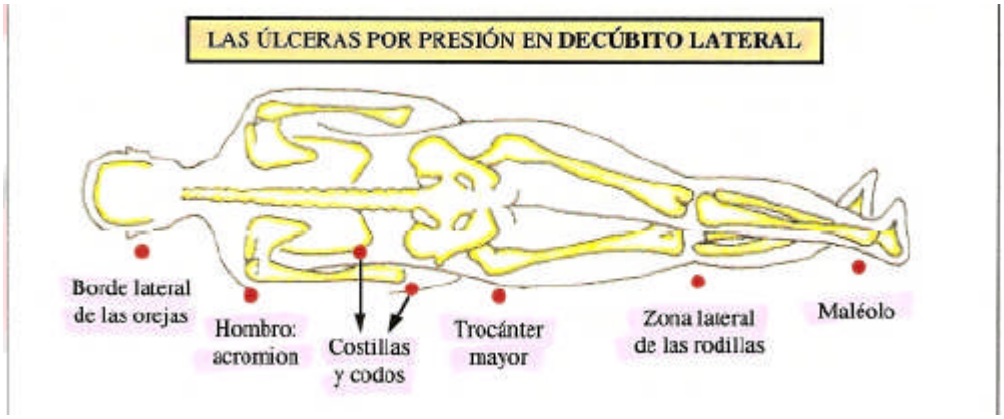
- Estadio I.- Afecta a epidermis (piel intacta). Eritema (piel rosada) que no recupera el color normal después de retirar la presión.
- Estadio II.- Afecta a epidermis y dermis. Piel con pérdida de continuidad, vesículas o flictenas.
- Estadio III.- Pérdida de tejido que se extiende en profundidad afectando a nivel subcutáneo. Puede haber tejido necrosado.
- Estadio IV.- Pérdida total del grosor de la piel, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén. Presenta lesiones con cavernas o trayectos sinuosos.

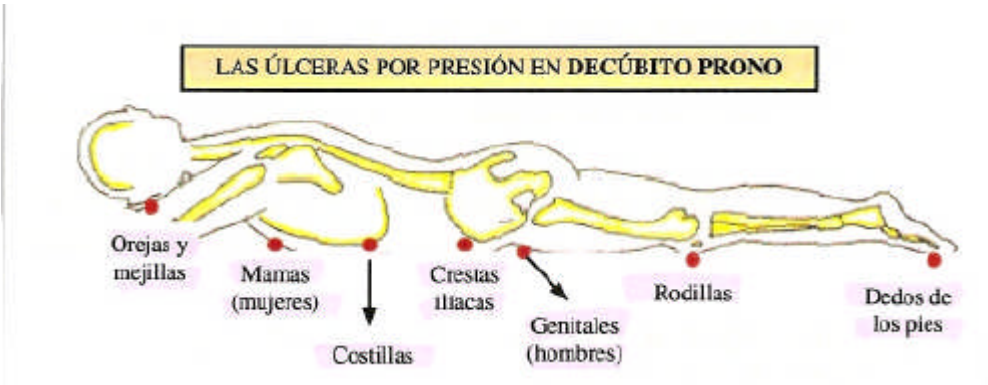
3 Isquemia es la disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo de una parte del cuerpo



La LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE está condicionada por la posición más habitual de la persona usuaria, tal y como se indica en las imágenes.







No todas las personas usuarias tienen la misma probabilidad de ulceración. Hay FACTORES PREDISPONENTES como son:

- Factores extrínsecos (evitables)
    - *Rozamiento*: La fricción entre la piel y cualquier superficie como puede ser la ropa de cama, produce el deterioro de la piel.
    - *Efecto cizalla*: Se produce cuando la piel permanece fija y el esqueleto se desplaza. Esta situación se produce frecuentemente cuando el cabecero de la cama está elevado y la persona usuaria se desliza por efecto de su peso.
    - *Presión prolongada*: cuando la presión sobre el tejido es superior a la presión del flujo capilar ocurre un proceso en cascada, que va desde la hipoxia hasta la muerte celular, necrosis y rotura del tejido.
    - *Piel húmeda*: la piel es más vulnerable cuando está húmeda a la fricción y a la presión. Además si existe una úlcera, esta en contacto con la orina y las heces incrementa la probabilidad de infección.

- Factores intrínsecos (inevitables)
    - *Edad*: La aparición de úlceras por presión aumenta de forma muy importante en personas de edad avanzada. Se considera que el 70 ó 90% de las úlceras aparecen en persona usuarias mayores de 75 años. Esto es debido a la pérdida de elasticidad y mala circulación.
    - *Inmovilidad*: La inmovilidad impuesta por enfermedad hace que la persona usuaria mantenga una presión prolongada en los mismos puntos de apoyo durante largos espacios de tiempo. Además la inmovilidad no favorece el riego sanguíneo.
    - *Incontinencia*: La piel en contacto con la orina y heces se humedece y, es más vulnerable a la aparición de UPP.
    - *Estado nutricional*: los estados de desnutrición no permiten mantener ni regenerar los tejidos, más aún cuando ya existe una lesión ulcerosa que precisa de proteína para regenerarse.
    - *Enfermedades*: Ciertas enfermedades pueden interferir en el proceso de curación de las UPP, como por ejemplo la diabetes mellitas, la insuficiencia renal, pérdidas sensitivas…….

Es por lo tanto fundamental realizar una VALORACIÓN INICIAL DE LA PERSONA USUARIA.

En el momento del ingreso, se realiza la historia de enfermería incluyendo en la misma, un estudio detallado del estado general de la persona usuaria prestando especial atención a:

- Factores de riesgo de las úlceras por presión (inmovilidad, incontinencia, nutrición, nivel de conciencia...).
- Identificación de enfermedades que pueden interferir en el proceso de curación (alteraciones vasculares, respiratorias, metabólicas, inmunológicas, procesos neoplásicos...).
- Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol...
- Hábitos y estado de higiene.
- Tratamientos farmacológicos (corticoides, AINEs, inmunodepresores...).
- Valoración nutricional.
- Dentro de este estudio se realizará una valoración del riesgo de úlceras que tiene dicho persona usuaria. Para esto utilizamos la Escala de Valoración de Norton.

Los ASPECTOS VALORADOS EN LA ESCALA DE NORTON son:

ESTADO FÍSICO GENERAL	Bueno	Mediano	Regular	Muy malo
ESTADO MENTAL	Alerta	Apático	Confuso	Estuporoso Comatoso
ACTIVIDAD	Ambulante	Disminuida	Muy limitada	Inmóvil
MOVILIDAD	Total	Camina con ayuda	Sentado	Encamado
INCONTINENCIA	Ninguna	Ocasional	Urinaria o Fecal	Urinaria y Fecal
PUNTUACIÓN	**4**	**3**	**2**	**1**

Cada uno de los aspectos se valora en 4 categorías con una puntuación va de 1 a 4, donde 1 indica mayor deterioro y 4 menor deterioro. La puntuación oscila entre “5” (máximo riesgo) y y “20” (mínimo riesgo). Se considera que una puntuación por debajo de “14” supone una situación de riesgo.

- De 5 a 11 → muy alto riesgo.
- De 12 a 14 → riesgo evidente.
- > 14 → riesgo mínimo /no riesgo.

Esta valoración se revisa periódicamente para detectar cambios en cualquiera de los apartados y poder poner en marcha las medidas preventivas.

Estas medidas se llevan a cabo, además de en los persona usuarias que tienen una puntuación menor de 14 en la escala de Norton, en cualquier persona usuaria que se prevea va a permanecer encamado durante más de 24 horas y que tenga la movilidad disminuida

Las MEDIDAS PREVENTIVAS que llevamos a cabo son las siguientes:

Higiene corporal.

Para mantener la piel limpia y seca. Es por esto que el equipo interdisciplinar ha elaborado un protocolo que es conocido y seguido por todos los cuidadores, que contempla:

- Propiciar, en lo posible, el baño o ducha completo.
- Aplicar cremas hidratantes, en lugar de lociones que contengan alcohol y que resecan la piel.
- Estimular la circulación mediante masajes suaves, utilizando aceites específicos (ácidos grasos y vitaminas).
- Detectar precozmente la úlcera inminente con una rigurosa y minuciosa exploración de la piel.

Protección de la piel.

Para lo que habrá que:

- Examinar el estado de la piel a diario.
- Mantener la piel en todo momento limpia y seca.
- Utilizar para la higiene jabones o sustancias limpiadoras poco irritantes.
- La higiene se deberá realizar con agua tibia.
- Secado meticuloso y sin fricción.
- No usar sobre la piel ni alcoholes ni colonias.
- Aplicar cremas hidratantes, hasta su completa absorción.
- No realizar masajes sobre las prominencias óseas.
- Utilizar apósitos protectores para reducir la fricción.
- Valoración de la piel y posibles alteraciones en su integridad.
- Además utilizar superficies de apoyo como: cojines de agua, cojines de silicona., protectores locales (vendajes...), módulos de agua para cama, colchones de aire (hinchado alternante), colchones de espuma, camas de cambios automáticos, aseo de la piel, evitando humedades,

Cambios posturales.

Los cambios posturales no son únicamente de un cambio de posición, sino que, en cada cambio hay que tener en cuenta los siguientes puntos.

Cuando se realiza el cambio postural hay que evitar el arrastre a lo largo de la cama y en cada posición evitar las zonas de presión y rozamiento.

Cuando se efectúa el cambio además de inspeccionar la piel también hay que confirmar que no quedan objetos (sondas atrapadas por ejemplo), restos de comida, ni siquiera las migas, arrugas, etc. en la cama que puedan ser causa de traumatismos

Para la vigilancia y control de los cambios posturales, en las instituciones se elabora una gráfica que se coloca en la pared, en la cabecera de la cama de la persona usuaria, donde se especifica la posición y el horario del cambio; de esta forma la persona que va a realizar el cambio, conoce la posición en que se debe colocar al residente encamado y además, de esta forma, vigilar que el cambio anterior ha sido realizado.

El responsable una vez constatado que el cambio postural ha sido realizado, lo refleja en una hoja con su firma por ejemplo; en esta hoja de registro, se reflejan las posiciones y horarios del cambio, coincidiendo exactamente con la gráfica que tiene la persona usuaria en su habitación.

De esta forma se lleva un control riguroso de los cambios y se crean hábitos en la realización de los mismos.

Es importante dejar a los persona usuarias encamados únicamente en las situaciones que sea imprescindible.

Para evitar la presión continúa sobre la misma zona en los persona usuarias que permanecen todo el día en silla de ruedas, se realizan movilizaciones periódicamente, y en caso de necesidad se les encama durante unas horas a mediodía para modificar la postura.

En este video os explican como son los cambios posturales http://www.youtube.com/watch?v=UhmGGa3oQ7Y

Junto a la higiene corporal, la protección de la piel y los cambios posturales, los aspectos que a continuación se comentan también son de gran importancia en la prevención de las úlceras o si estas ya han aparecido, mejoran su evolución.

Existe un dispositivo de gran ayuda para los cambios posturales: el “Cambipos”

Consiste en una funda de algodón poliéster, que cubre únicamente la parte central de la cama. En su interior dispone de dos cavidades donde se introducen dos almohadillas de plástico hinchables.

Se coloca entre el colchón y el usuario, quedando una almohadilla bajo su lado derecho y la otra bajo el lado izquierdo.

Insuflando con un hinchador especial una de las dos almohadillas, se consigue poner de lado al usuario. Por ejemplo al llenar la almohadilla izquierda, se le gira hacia la derecha, quedando éste tumbado sobre su costado derecho y viceversa.

Para facilitar el aseo y hacer la cama con el usuario en ella, dispone de un sistema de velcro que sirve para sujetar la funda a la barandilla protectora de la cama y lateralizar aún más al usuario.

Resiste pesos corporales de más de 80 kg. Contiene una válvula de seguridad para un rápido desinflado de las almohadillas internas.

Permite la movilización sin esfuerzos del paciente encamado, previene la aparición de úlceras por presión y facilita su higiene.



CONTROL DE LA INCONTINENCIA

En cada caso habrá que buscar el tratamiento más adecuado, según las características de cada persona usuaria; utilizando la sonda vesical sólo excepcionalmente y de forma temporal cuando sea imprescindible.

En el siguiente punto ampliaremos la información al respecto pero a modo general las pautas a seguir son:

- Utilizar absorbentes de incontinencia cambiándose cuando sea necesario y protocolizar los cambios de absorbentes con un horario determinado.
- Utilización de colectores de orina en aquellos persona usuarias varones que lo precisen.
- Valoración integral de la persona usuaria en silla de ruedas por si puede evitarse las sillas con cuña de incontinencia por el alto riesgo que conllevan de úlceras en glúteos.
- Valoración de la necesidad de uso de sondaje vesical en casos determinados.

UTILIZAR DISPOSITIVOS PARA ALIVIAR LA PRESIÓN:

Los dispositivos más utilizados son:

- En las sillas de ruedas durante el día utilizar cojines de agua, cojines de silicona…
- Protectores locales: vendajes...
- Módulos de agua para cama.
- Colchones de aire (hinchado alternante).
- Colchones de espuma.
- Camas de cambios automáticos. cojines de agua, silicona...).
- En determinadas personas es necesario reclinar el respaldo de la silla de ruedas para repartir la presión.
- Colocar colchones de aire de presión alternante en la cama en todos los persona usuarias que tengan la movilidad disminuida.
- En los persona usuarias con más riesgo se combinarán los colchones de aire con módulos de agua colocados en las zonas de mayor riesgo.
- Las camas de cambios automáticos son de gran efectividad.
- Proteger las zonas de riesgo de ulceración y las zonas más delicadas con protecciones de algodón, almohadas, cojines...
- Colocar apósitos hidrocoloides en zonas donde haya signos de aparición inminente de una úlcera.
- Poner protecciones en los pedales de los carros de ruedas para evitar autolesiones y lesiones a los demás al golpearse.

CUIDADOS NUTRICIONALES

Se debe procurar una dieta adecuada a las necesidades de la persona usuaria, rica en proteínas y vitaminas, para ello es importante hacer una valoración nutricional periódicamente y utilizar suplementos dietéticos en los casos que sea necesario, recurriendo a la alimentación por SNG con administración de preparados específicos con por vía oral.

HIDRATACIÓN:

Control de ingesta de líquidos y aumento de la cantidad de líquidos en los residentes que lo necesitan.

Para controlar este punto, se puede elaborar una gráfica en la que se anota, en la parte de arriba, la pauta diaria de líquidos aconsejada para un persona usuaria determinado. Cada día se sigue esta gráfica intentando que se cumpla dicha pauta, para ello en los horarios indicados, se ofrece a la persona usuaria la cantidad de líquido preferido y se anota en la gráfica la cantidad real de líquido ingerido. De esta forma se puede controlar la ingesta total de líquido que toma un persona usuaria y en el caso de que esta cantidad no sea suficiente, se adoptan las medidas supletorias adecuadas.

Durante los meses más calurosos esta medida se hace extensiva a todos los residentes que no son capaces de ingerir líquidos por sí mismos. En los persona usuarias que tienen dificultad para ingerir líquidos, la cantidad pautada, se suple con gelatinas.

TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS.

El plan básico consta de:

- Limpieza de la úlcera.
- Eliminar exudado.
- Eliminar restos cura anterior.
- Desbridar tejido necrótico.
- Secar lecho de la úlcera.
- Prevenir y tratar posibles infecciones.
- Estimular el tejido de granulación y reepitelización.
- Elegir el producto que mantenga el lecho de la úlcera en unas condiciones de humedad adecuadas. Estos productos son desde apósitos hasta geles. Elegir el producto que permita:
    - Proteger la úlcera de agresiones externas.
    - Mantenga el lecho húmedo y la piel circundante seca.
    - Que controle el exudado.
    - Deje la menor cantidad de residuos en la lesión.
    - Facilidad de aplicación y retirada.
- Además será preciso considerar:
    - Localización de la úlcera.
    - Estadio.
    - Cantidad de exudado.
    - Tunelizaciones.
    - Estado de la piel circundante.
    - Signos de infección.

El tratamiento efectivo de las úlceras por presión implica a todos los cuidadores, que deben trabajar en equipo. Ante persona usuarias de riesgo o cuando aparezca una úlcera, desarrollará un plan previamente organizado y perfectamente conocido por todos los miembros.

Se realizarán registros como herramienta de control y evaluación. Para ello se fomentará la formación continuada y el trabajo en equipo como punto fundamental en la prevención y tratamiento de las úlceras. Además es importante afianzar roles y responsabilidades compartiendo los errores y también los logros, teniendo en cuenta, siempre, que el disminuir la incidencia de las úlceras es un objetivo de calidad asistencial.

Las úlceras pueden y deben prevenirse, en gran parte, con un buen cuidado y atención a la persona usuaria por parte del personal de enfermería.

ALGORITMO DE PREVENCIÓN

PREVENCIÓN DE LAS ULCERAS POR PRESIÓN	Puntuación de riesgo ESCALA NORTON 14-16	Puntuación de riesgo ESCALA NORTON 12-13	Puntuación de riesgo ESCALA NORTON 5-11	PROCEDIMIENTO GENERAL
HIGIENE CORPORAL	DIARIO/DEMANDA	DIARIO/DEMANDA	DIARIO/DEMANDA	• Valorar y tratar incontinencia. • No masajear prominencias óseas. • Corregir déficit de nutrición. • Evitar colocar al paciente directamente sobre el trocánter femoral, cuando se encuentre en decúbito lateral. • Registrar actividades.
VIGILANCIA PUNTOS DE PRESIÓN. PROTECCIÓN DE LA PIEL	ÁC. GRASOS HIPEROXIGENADOS C/24H.	ÁC. GRASOS HIPEROXIGENAD. C/12H.	ÁC. GRASOS HIPEROXIGENAD. C/8-12H.	
SUPERFICIES PARA EL ALIVIO DE LA PRESIÓN	SISTEMAS ESTÁTICOS O COLCHONETA DE AIRE ALTERNANTE	COLCHÓN DE AIRE ALTERNANTE DE CELDAS GRANDES	COLCHÓN DE AIRE ALTERNANTE DE ALTAS PRESTACIONES	
PROTECCIÓN DE TALONES Y CODOS	SI PROCEDE, AP. HIDROCELULAR NO ADHESIVO DE TALÓN	APÓSITO HIDROCELULAR NO ADHESIVO DE TALÓN	APÓSITO HIDROCELULAR NO ADHESIVO DE TALÓN	
SEDESTACIÓN: SI LO PERMITE PATOLOGÍA	4H. MÁXIMO + COJÍN ESTÁTICO	4 H. MÁXIMO + COJÍN ESTÁTICO-ALTERNANTE	2 H. MÁXIMO + COJÍN ALTERNANTE	
CONTROL ALIMENTACIÓN	C/24 H.	C/TOMA PERFIL NUTRICIONAL	C/TOMA PERFIL NUTRICIONAL	
CAMBIOS POSTURALES	C/TURNO	C/ 4 H. 9-12-17-21-1-5 ROTATORIO	C/ 4 H. 9-13-17-21-1-5 ROTATORIO	
MEDICIÓN DE RIESGO	C/ 3 DIAS	DIARIO	DIARIO	
VIGILANCIA ESPECIAL	• ZONA DE INSERCIÓN S.N.G. • POSICIÓN S. VESICAL • MASCARLLA Y GAFAS OXÍGENO: PUNTOS DE PRESIÓN • SUJECIONES MECÁNICAS			

Para ampliar información podéis consultar la página Web del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP): www.gneaupp.org/

1.4.- Aplicación de cuidados de la persona usuaria incontinente y colostomizado.

TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA

La INCONTINENCIA URINARIA se define como la “condición en el cual se produce una pérdida involuntaria de la orina por la uretra suficiente para constituirse en un problema social/médico”.

Es uno de los grandes síndromes geriátricos por la repercusión que tienen a nivel personal.

La INCONTINENCIA URINARIA tiene distintas consecuencias para la salud:

Físicamente:

1. Puede provocar alteraciones en la piel
2. Infecciones urinarias de repetición

Psicológicamente:

3. Estrés
4. Aislamiento
5. Inseguridad
6. Dependencia

- Socialmente:
  1. Estrés para los cuidadores
  2. Predisposición a la institucionalización.
  3. Disminución de las relaciones sociales por vergüenza.

La INCONTINENCIA URINARIA puede ser reversible, también llamada transitoria

Tiene una evolución de menos de 4 semanas. Sus causas más frecuentes son: consumo de determinados fármacos, infecciones urinarias, impactación fecal y endocrinopatías, entre otras. Suele solucionarse al desaparecer el trastorno causante.

La INCONTINENCIA URINARIA permanente también llamada crónica o establecida.

Existen 5 tipos:

- *INCONTINENCIA URINARIA de urgencia o vejiga hiperactiva*. Se produce como consecuencia de contracciones involuntarias de la musculatura de la vejiga que provocan un deseo súbito e intenso de orinar que no puede ser suprimido y conduce a la pérdida involuntaria de orina. Suele tener su origen en alteraciones neurológicas y del sistema nervioso: Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, accidentes vasculocerebrales...; también, a enfermedades urológicas como la cistitis (inflamación de la vejiga, acompañada o no de infección, que cursa generalmente con dolor o escozor al orinar), la infección urinaria o hiperplasia de próstata.
- *INCONTINENCIA URINARIA de esfuerzo*. Es más frecuente en la mujer y se da por un debilitamiento en el esfínter de la uretra (normalmente, causado por partos, falta de hormonas durante la menopausia, prolapso genital,…), En este caso, la pérdida involuntaria de orina se produce como consecuencia de un esfuerzo que genera un aumento de la presión intrabdominal, como levantar peso, estornudar, reír,…
- *INCONTINENCIA URINARIA mixta*. La padecen persona usuarias que presentan INCONTINENCIA URINARIA de urgencia y de esfuerzo.

- *INCONTINENCIA URINARIA por rebosamiento*. El volumen de orina en la vejiga supera la capacidad contráctil de la uretra, por lo que se produce un vaciamiento por rebosamiento. Es más frecuente en hombres que en mujeres y más durante la noche. Se suele dar en lesiones medulares, en hiperplasia de próstata (el agrandamiento no canceroso de la glándula prostática), en estenosis uretrales (estrechamiento de la uretra), fármacos y neuropatía diabética (afectación de los nervios periféricos en persona usuarias diabéticos), etc.
- *INCONTINENCIA URINARIA funcional*. Se da como consecuencia de la imposibilidad de acudir al baño por limitaciones funcionales como, por ejemplo, persona usuaria encamado, servicios inaccesibles,…

El tratamiento y los cuidados estarán condicionados en parte por el tipo de INCONTINENCIA URINARIA, y en otra por la situación personal de la persona usuaria. Es por eso que tomaremos algunas medidas generales pero otras serán personales.

Dependiendo de su grado de dependencia, a la persona usuaria con INCONTINENCIA URINARIA se le deberán prestar diferentes cuidados:

Los *persona usuarias con un leve grado de dependencia* deben aprender diversos ejercicios para ejercitar la musculatura pélvica, así como consejos dietéticos y hábitos saludables.

En estos casos, es posible la educación para el vaciado programado de la vejiga. Con estos persona usuarias, podremos poner en práctica algunas técnicas de modificación de conducta, para lo que se podrán practicar ejercicios como los siguientes:



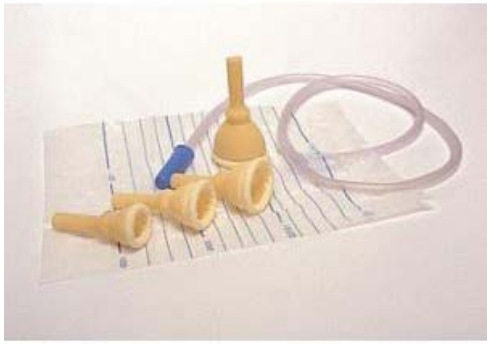
- El reentrenamiento vesical para crear un hábito miccional. Consistirá en ir aumentando el intervalo de tiempo entre una micción y la siguiente, hasta un máximo de 2-3 horas durante el día. Requiere que la persona usuaria cuente con una buena capacidad física y mental.
- Ejercicios de Kegel, consistentes en la realización de contracciones repetidas de los músculos de suelo pélvico para aumentar el tono de éstos. Se realizarán entre 25 y 30 contracciones por sesión y entre 3 y 4 sesiones diarias.
- Micciones programadas cada dos horas, con el fin de lograr un condicionamiento y evitar las pérdidas. Se utiliza en casos de mayor discapacidad.

Los *persona usuarias encamados o con grados de dependencia severa* suelen ser portadores de colectores de orina (dispositivos de goma, similares a los preservativos, de fácil colocación, que van conectados a una bolsa de orina) o

sondajes vesicales y, como mínimo, necesitan la utilización de pañales o absorbentes.

Para la colocación del colector de orina hay que preparar el material que se va a emplear, que en este caso consiste en:

- Colector de orina. En el mercado los hay de diferentes tipos (autoadhesivos o de fijación en la base del pene mediante una tira circular o un apósito) y de diferentes tamaños. Antes de proceder a su colocación hay que leer atentamente las instrucciones del fabricante (especialmente el modo de fijación a la base del pene si no es autoadhesivo). En cuanto al tamaño, puede venir especificado de varias maneras dependiendo de la casa.



- Bolsa de incontinencia urinaria con tubo de drenaje.
- Gasas.
- Útiles de aseo: jabón, toalla, jofaina con agua templada.
- Guantes desechables.

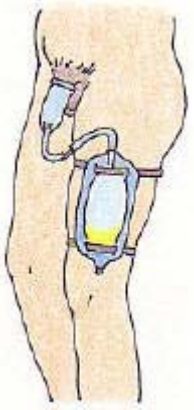
Para colocarlo hay que efectuar los siguientes pasos:

- Lavarse las manos.
- Explicar al usuario el procedimiento y solicitar su colaboración.
- Ponerse los guantes.
- Colocar a la persona usuaria en decúbito supino. Para preservar su intimidad, tapar su cuerpo, dejando expuestos solamente los genitales.
- Limpiar los genitales con y secarlos cuidadosamente (se eliminan las secreciones que puedan irritar la piel de la persona usuaria y se facilita el deslizamiento del colector).
- Sujetar la bolsa de incontinencia urinaria en el lateral de la cama, dejando la conexión accesible (se facilita su rápida conexión al colector).
- Sujetar el pene de la persona usuaria con la mano no dominante. Realice una ligera presión (disminuye la posibilidad de erección).
- Con la mano dominante, colocar la base del colector sobre el glande de la persona usuaria y deslizarlo suave y uniformemente hacia el extremo proximal del pene.
- Asegurarse de que quedan 2.5 cm entre el extremo distal del pene y el tubo de drenaje del colector (evita el exceso de presión sobre el glande)



Colector de orina

- Fijar el colector como indica el comerciante. Con la cinta específica se asegura la sujeción a la piel y se evita la constricción de la zona, ya que este material se expande con los cambios de tamaño del pene. Por ese motivo, jamás debe usarse esparadrapo para fijar el colector, ya que este material no es expansible y puede causar constricción y reducción del flujo sanguíneo del pene.
- .Conectar la bolsa de de incontinencia urinaria al extremo distal del colector. Si la persona usuaria está encamado, sujetar la bolsa a la cama y si puede andar, sujetarla a la extremidad inferior. Comprobar la ausencia de acodamientos en los sistemas de conexión y de drenaje



Colector conectado a una bolsa de incontinencia urinaria

- Quitarse los guantes y lavarse las manos.

Cuidados posteriores:

- Comprobar la integridad de la piel del pene a los 30 minutos de la colocación del colector. Verificar el adecuado drenaje de la orina.
- Cambiar el colector y evaluar el estado del pene cada 24 horas.
- Asegurar la asepsia cada vez que se realice el cambio de bolsa o cada vez que ésta se vacíe. No se deben de tocar los extremos de las conexiones: el pabellón de la sonda y la parte del tubo de drenaje que conecta con el pabellón en los sistemas abiertos y, además de estos elementos, el tubo de drenaje de la bolsa en los sistemas cerrados.

- La bolsa de incontinencia urinaria [4] debe permanecer siempre a un nivel más bajo que la vejiga para prevenir un retroceso del flujo urinario hacia la vejiga. El dispositivo de drenaje se debe vaciar por lo menos cada 8 horas o cuando esté 2/3 de capacidad.

- Con el fin de evitar el reflujo de la orina, se vigilará que el tubo y la bolsa colectora no sobrepasen el nivel de la vejiga.
- Evitar tirones que puedan provocar traumatismos o desconexiones accidentales del sistema.
- Evitar que se formen acodaduras.

En este video te explica como colocar un colector, antes os habla de la colocación del pañal: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zdNs-n-3DXM#!

Es en los pañales y absorbentes este donde se deben extremar los cuidados y mantener unas condiciones higiénicas excepcionales, vigilando siempre la integridad de la piel y la aparición de lesiones. Además del aseo diario, es recomendable realizar una higiene parcial cada vez que miccione.

Los pañales y absorbentes son de gran utilidad, al proporcionarnos un margen de tiempo entre la pérdida de la orina y nuestra intervención, aunque en ningún caso serán sustitutos de una buena higiene, ya que mantienen la humedad y, en consecuencia, deben ser cambiados con regularidad.

Para la colocación del pañal necesitamos los siguientes materiales:

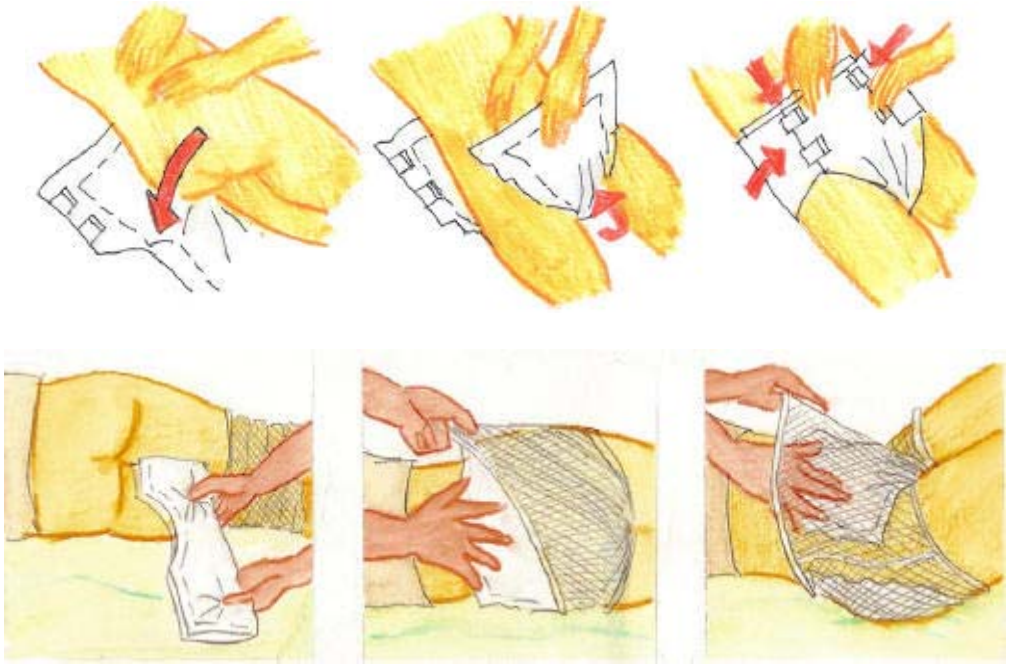
- Material para el aseo (seguir el procedimiento del apartado 1.2 en el punto Limpieza de las zonas de riesgo, higiene de genitales de este módulo).
- Pañal o absorbente.
- Lencería (por si fuese necesario cambiar la ropa de cama).

El procedimiento a seguir es el siguiente:

- Preparar el material y llevarlo a la habitación de la persona usuaria.
- Lavar las manos y colocar los guantes.
- Explicar el procedimiento a la persona usuaria y pedir su colaboración.
- Pedir ayuda del personal necesario para realizar el procedimiento, según cada caso.
- Respetar la intimidad de la persona usuaria.

4 Proceso de secreción y eliminación de la orina del riñón. La diuresis es un fenómeno regulado hormonalmente (hormona antidiurética y aldosterona) que, no obstante, varía según las condiciones del individuo, y se debe a un equilibrio entre la cantidad de líquidos ingeridos, las necesidades fisiológicas del organismo y la cantidad de líquidos eliminados por vías como la sudoración, las heces, etcétera. Se considera una diuresis normal cuando se expulsan entre 1000 y 1500 ml de orina diarios

- Realizar una correcta higiene con agua tibia y jabón neutro de la zona genital, perianal y glúteos, colocando a la persona usuaria en posición de decúbito lateral.
- Secar bien la zona sin friccionar.
- Aplicar cremas o pomadas si fuese necesario.
- Cambiar la ropa de cama si se hubiese mojado o ensuciado, según la técnica de realización de cama abierta ocupada (ver apartado 2.3 de este módulo)
- Cambiar el pañal: colocarlo abierto, situando la zona de los adhesivos sobre la cama a la altura de la cintura del individuo y ajustarlo correctamente. comprobando su correcta colocación, cuidando muy bien que no marque arrugas y sin producir daño a la persona usuaria.
- Acomodar a la persona usuaria en postura adecuada.
- Recoger y reordenar el cuarto.
- Retirar los guantes y lavarse las manos.



¿Cuándo hay que cambiar el pañal?

Los avances en este campo permiten espaciar el cambio del pañal en el tiempo más que antes porque mantienen la piel seca durante más tiempo. Por otro lado según los líquidos ingeridos y la alimentación la frecuencia de la micción varía, por lo tanto no se pueden dar pautas horarias. La mayoría de los pañales tienen un dispositivo que cambia de color, mas intenso cuanto mas humada ha absorbido.

Aun así y todo, los pañales permiten soltar y volver a pegar los adhesivos de sujeción más de una sola vez, por lo que si se percibe que la persona usuaria va a miccionar o el lo nota pueda soltar el pañal y volver a sujetarlo

En el siguiente video podéis ver un resumen:
http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/6/zKuaj7hzCZU

Otra solución a la incontinencia es el sondaje vesical con sonda urinaria. Este tratamiento es la última opción por los riesgos colaterales que conlleva (traumatismos, infecciones, mantenimiento…)

Un catéter, sonda urinaria, sonda uretral o sonda de Foley es un tubo blando de plástico o de goma que se inserta en la vejiga a través de la uretra para vaciar la orina.

La sonda debe de conectarse a una bolsa que permita recoger la orina:



- Si el usuario no puede caminar, utilizar una bolsa para recogida de orina con grifo en la parte inferior. Proceder a su vaciado por la parte inferior en un orinal o en una cuña. No se necesita desconectarla ni cambiarla, solamente cuando esté sucia.
- Si el usuario camina, hace vida normal, durante el día puede utilizar una bolsa con una capacidad de 750 ml sujeta a la pierna y durante la noche puede utilizar una de mayor tamaño y ésta se podrá sujetar a la cama mediante un soporte.
- Los catéteres son de una gran variedad de tamaños (12 Fr., 14 Fr., 30 Fr.), materiales (látex, silicona, Teflón) y tipos (catéter de Foley,...). Se recomienda utilizar el catéter más pequeño, en la medida de lo posible; normalmente se emplea el 14 Fr. o el 16 Fr. Algunas personas necesitan catéteres más grandes para controlar los escapes de orina alrededor del catéter.

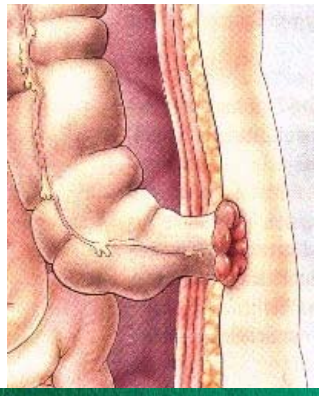
Consejos prácticos

- Beber al menos de 1,5 a 2 litros de líquidos al día (agua, zumos, caldo, infusiones, etc.) para provocar abundante orina y evitar que se formen residuos en la vejiga y que se tapone la sonda.
- Cuando se manipule la sonda o la bolsa se deberán lavar antes las manos con agua y jabón par evitar las infecciones.
- Diariamente se lavará con agua y jabón el pene o la zona genital para que no se le forme barrillo alrededor de la sonda, evitando infecciones.
- Asegurar que la bolsa esté bien conectada a la sonda para evitar pérdidas de orina.

- Vigilar que el tubo de la sonda o de la bolsa no estén doblados para que no se impida el paso de orina a la bolsa.
- Si el usuario se levanta, la sonda la llevará sujeta a la pierna con un esparadrapo, o con una pinza al calzoncillo para evitar que esté tirante y le produzca "ganas de orinar".
- Cuando no lleve la bolsa deberá desconectar el tapón de la sonda cada dos o tres horas para vaciar la vejiga aunque por la noche debe tenerla conectada a la bolsa para no tener que levantarse y que la vejiga se vacíe bien.
- La bolsa de drenaje debe permanecer siempre a un nivel más bajo que la vejiga para prevenir un retroceso del flujo urinario hacia la vejiga. El dispositivo de drenaje se debe vaciar por lo menos cada 8 horas o cuando esté 2/3 de capacidad.
- No tirar de la sonda, podría ocasionar serios traumatismos.
- La sonda vesical no debe impedir que el usuario realice una vida social, familiar y de ocio de manera normal.

En el siguiente video podéis ver un resumen:
http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/4/e5UdRtEfIFc

APLICACIÓN DE CUIDADOS DE LA PERSONA USUARIA COLOSTOMIZADA



Una colostomía es un estoma (orificio) efectuado en el colon cuyo objetivo es la eliminación de las deposiciones.

La colostomía pude ser hecha en el colon ascendente, en el transverso, en el descendente o en el sigmoideo. Cuanto más cerca del recto esté hecha las heces serán mas consistentes (la anatomía del colon la tienes descrita en el apartado 3.2 de este módulo)



La colostomía puede ser permanente o transitoria y a su vez, continente o incontinente.

Para las colostomías incontinentes se utilizan bolsas de recogida adheridas al cuerpo. Cuando se adhieren directamente se llaman de una pieza y cuando la hacen a través de un dispositivo se llamas de dos piezas.



En el mercado existen multitud de productos relacionados con las colostomías, Bolsas c/Filtro, barreras, cinturones de

sujeción, pastas, polvos, productos para el cuidado de la piel, manejo de heridas., material de c, etc.

Para las colostomía continentes basta con utilizar un obturados y limpiar el estoma tal y como se explica para el procedimiento de cambio de las bolsas de colostomía a continuación.

A una persona colostomizada habrá que realizarle una serie de cuidados para los que recopilaremos el siguiente material:



- Guantes no estériles
- Empapador
- Gasas
- Antiséptico
- suero fisiológico
- pinzas kocher
- tijeras
- bolsa de colostomía.
- plantillas para medir el estoma



El procedimiento a seguir es el siguiente:

- Lavarse las manso y preparar el material
- Explicar a la persona usuaria el procedimiento. Siempre es importante porque le da seguridad y permite su colaboración, pero en este caso en fundamental porque si es autónomo puede él mismo realizar el procedimiento.
- Colocarse los guantes
- Preservar la intimidad de la persona usuaria en todo momento. Para ello como ya se ha indicado procederemos a invitar a las visitas a abandonar la habitación, eliminaremos el contacto visual con su compañero (si lo hubiere) y desnudaremos solo la parte anatómica estrictamente necesaria.
- Colocar el empapador bajo la parte anatómica donde se sitúa la colostomía

- Tirando de arriba hacia abajo desprenderemos la bolsa de colostomía.
- Si así se hubiera prescrito observar y medir el contenido.
- Quitarse los guantes, lavarse las manos y colocarse unos guantes nuevos para continuar con el procedimiento. Los guantes han estado en contacto con las heces y pueden haberse contaminado.
- Limpiar el estoma con agua y jabón. Las primeras dos semanas, cuando el estoma aún no se ha asentado además habrá que:
    - Preservando escrupulosamente la asepsia (hay quien incluso recomienda usar guantes y material estéril), limpiar el contorno con gasas estériles empapadas en suero sin arrastrar, golpeando suavemente.
    - Pintar con antiséptico en contorno del estoma.
    - Utilizando la plantilla medir el estoma (luego no cambia de tamaño)

- Recortar la conexión al cuerpo a la medida (hasta que se asiente a al medida que nos da la plantilla)
- Pegar al cuerpo de abajo hacia arriba
- Acomodar a la persona usuaria en postura adecuada.
- Recoger y reordenar el cuarto.
- Retirar los guantes y lavarse las manos.

En este video encontréis un resumen de los cuidados de una colostomía: http://www.youtube.com/GobiernoAragon#p/u/9/MMhsHu25Mg0

1.5.- Prevención y control de infecciones. Procedimientos de aislamiento y prevención de enfermedades transmisibles.

Las enfermedades transmisibles son aquellas en las que existe un agente causal, vivo, único, exógeno, capaz de reproducirse y de desencadenar la enfermedad. Además, puede pasar de un individuo a otro por contagio.

Se denomina infección a al entrada de un microorganismo o agente infeccioso en un huésped (el enfermo en potencia), que crea una relación de parasitismo[5], ocasionando en él una respuesta orgánica.

Se caracterizan por la aparición de distintos síntomas entre los que podemos mencionar la fiebre, malestar general y decaimiento, toda enfermedad infecciosa

Pasa por 3 etapas:

1. Periodo de incubación. Tiempo comprendido entre la entrada del agente hasta la aparición de sus primeros síntomas. Varía el tiempo dependiendo de la enfermedad.

5 El parasitismo es una interacción biológica entre organismos de diferentes especies, en la que una de las especies (el "hospedador") lo da todo y no recibe nada por la otra parte.

2. Periodo de desarrollo. Aparecen los síntomas característicos.
3. Convalecencia. Se vence a la enfermedad y el organismo se recupera.

El conjunto de eslabones o factores que determinan la transmisión se llama CADENA EPIDEMIOLÓGICA. La forman 3 eslabones que se van repitiendo constantemente:



En los centros e instituciones sanitarias nos encontramos numerosas personas usuarias con diversas infecciones y enfermedades que transmiten gran cantidad de agentes patógenos. Cuando este microorganismo entra en el huésped que no lo tenía, entonces hablamos de INFECCIÓN NOSOCOMIAL.

Factores que influyen en la manifestación de una infección nosocomial son:

- Evidentemente a presencia del agente microbiano. La fortaleza del propio agente condicionara la intensidad de su transmisión
- La propia vulnerabilidad de los persona usuarias. Es obvio que un persona usuaria debilitado por otras patologías será blanco mas fácil de un ataque microbiano que otro más saludable.
- Factores ambientales. Hay áreas que son más proclives a las infecciones nosocomiales, por ejemplo si hay un número alto de personas con afecciones respiratorias.

Actualmente las medidas de prevención y control van encaminadas hacia los 3 eslabones:

  - Modificar la fuente de infección o reservorio por ejemplo control de los alimentos, uso de cámaras frigoríficas, cocerlos, lavarlos, etc.
  - Interrumpir la transmisión: por ejemplo lavándose las manos, utilizando guantes y cambiándolos entre distintos procedimientos, gorros, manipular los alimentos adecuadamente, etc.
  - Proteger al huésped, por ejemplo con vacunas, usando dosis de antibióticos adecuadas, etc.

Todos los centros e instituciones sanitarias deberían tener perfectamente establecidas y en funcionamiento aquellas actividades que, según los

conocimientos actuales y las mejores evidencias científicas disponibles, son efectivas y eficientes para lograr la mejor vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales

Las medidas pueden ser de dos tipos: programas de prevención y acciones de control.

Los programas de prevención incluyen la elaboración, aplicación, desarrollo y evaluación de normas, programas, protocolos, guías y recomendaciones encaminadas a prevenir la aparición de enfermedades infecciosas en el hospital; todo ello basado en la máxima evidencia científica disponible. En este apartado se incluyen los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización, la política de antisépticos, la normativa de lavado de manos, las recomendaciones de preparación de alimentos, etc.

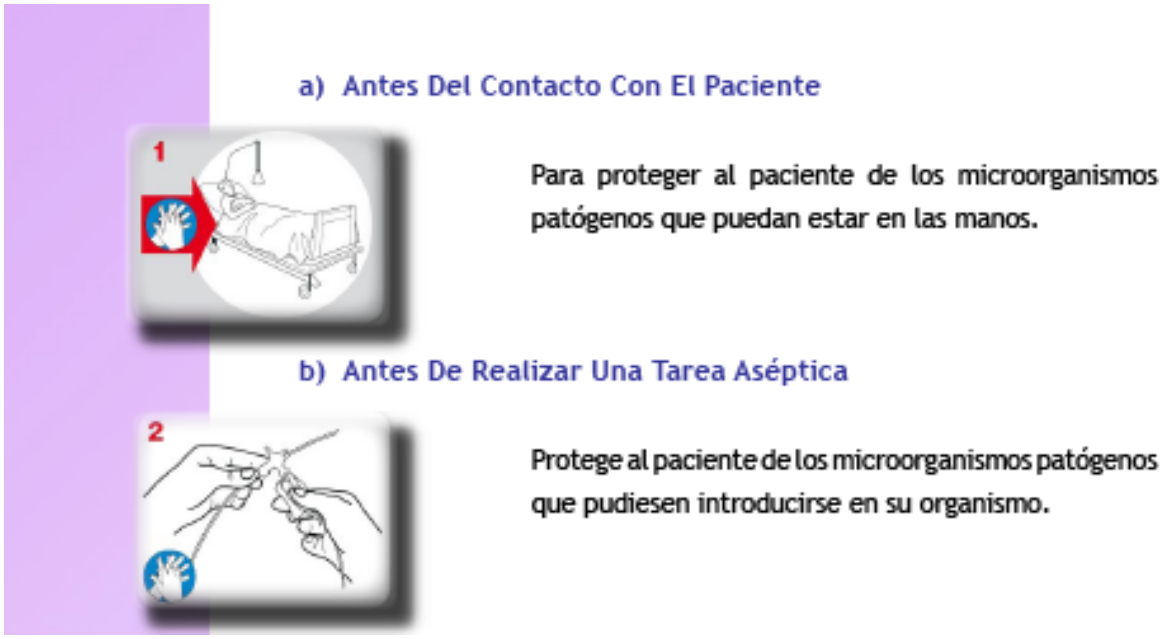
Las acciones de control representan la aplicación continuada de las acciones preventivas.

Las PRECAUCIONES ESTÁNDAR o también llamadas UNIVERSALES se basan en medidas simples, de fácil aprendizaje y manejo, que van a disminuir gran parte de las infecciones.

Dichas medidas son:

Lavado de manos

Es la medida de higiene más eficaz para limitar la transmisión de enfermedades en la institución. Loas 5 momentos clave para hacerlo son:



c) Después Del Riesgo De Exposición A Fluidos Orgánicos



Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria, de los microorganismos patógenos que pudiera tener el paciente.

d) Después Del Contacto Con El Paciente



Para protegerse de los microorganismos patógenos que pueda tener el paciente.

e) Después Del Contacto Con El Entorno Del Paciente



Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los microorganismos patógenos que puede tener el paciente.

El lavado de manos consta de mojado, enjabonado, fricción, aclarado y secado. El modo correcto de realizarlo se describe en estos pasos:



En este video podéis ver un resumen donde muestran cómo realizar un correcto lavado de manos y los errores más frecuentes a la hora de realizar esta técnica: http://www.youtube.com/watch?v=My6iEYqUqPY&feature=fvwrel

Esta también se puede realizar con solución hidroalcohólica de la siguiente manera:

En este video podéis ver un resumen:
http://www.youtube.com/watch?v=9SgF9Y1f_ac&feature=related

Objetos punzantes y cortantes

Es necesario tomar precauciones para evitar lesiones cuando se utilizan agujas, bisturís, y escalpelos u otro objeto cortante, o cuando se manipule este material para limpiarlo o desecharlo. No se han de tocar las agujas con las manos ni encapucharlas, sino eliminarlas en contenedores rígidos, colocados en lugares de fácil acceso.

Guantes

El hecho de utilizar guantes no reemplaza la necesidad del lavado de manos, porque los guantes pueden tener defectos pequeños o inaparentes o incluso pueden producirse durante el uso; de esta forma, las manos quedarían contaminadas al quitárselos. El error de no cambiarse los guantes entre contactos con persona usuarias es un riesgo para el control de la infección. Los guantes se ponen cuando se va a entrar en contacto con los fluidos orgánicos.

Los guantes serán estériles si se manipulan espacios estériles; de exploración en los otros casos (piel no intacta y mucosas); de tipo doméstico para efectuar la limpieza. Se procederá al cambio de guantes tras cambio de persona usuaria o de actividad.



Mascarilla, bata, lentes protectoras

Se han de utilizar cuando previsiblemente se hagan maniobras que pueden originar la formación de gotitas de sangre o de los líquidos orgánicos mencionados. Existen diferentes tipos de mascarilla, batas, gafas y mascaras para cada situación.

Material recuperable

Limpieza de material recuperable: instrumental, aparatos, etc. se realizará con agua y jabón con la mínima manipulación, para una posterior desinfección, secado completo del material y esterilización.

Ropa

El colchón se protegerá con funda plastificada. Al retirar no sacudir la ropa. Depositarla directamente en la bolsa para ser enviada a lavandería, tal como se señala en la Normativa específica.

Limpieza de superficies

Limpieza con agua y jabón, y desinfección con desinfectante de superficies o lejía diluida 1/10, excepto en superficies metálicas.

Residuos

Se seguirán las indicaciones generales de retirada de residuos y material desechable.



Ubicación y transporte de los persona usuarias

La habitación individual es importante para el control de la transmisión en usuarios de alto riesgo bien de ser contagiados o de contagiar. Si no se dispone de ésta se ubicará con un compañero adecuado (misma infección, baja susceptibilidad, etc).

Hay que limitar al máximo los movimientos de los persona usuarias-fuente. Para su traslado, se deberán realizar las medidas apropiadas para reducir la transmisión, e informar de la patología y de la posibilidad de transmisión de la infección al personal de la unidad a la que va a ser conducido. Del mismo modo, la persona usuaria debe conocer las medidas que debe tomar o se le van a imponer.

PRECAUCIONES POR MECANISMO DE TRANSMISION

Precauciones respiratorias

Estas mecidas pretenden reducir el riesgo de transmisión aérea de agentes infecciosos, que puede producirse a través de dos mecanismos:

- Por partículas de gotas evaporadas que, debido a su diámetro inferior o igual a 5 micras, permanecen en suspensión aérea durante periodos prolongados de tiempo. El aerosol que las contiene se origina con la tos, el estornudo o el habla de la persona usuaria, y durante ciertos procedimientos como el aspirado de secreciones respiratorias.
- Por partículas de polvo que contengan el agente infeccioso. Los gérmenes así transportados pueden ser inhalados o depositados en un huésped, a una distancia variable de la fuente en dependencia de factores ambientales.

Para ambos tipos de transmisión, la medida precautoria más extendida es interponer una barrera física entre fuente y huésped mediante el uso de mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, no debemos olvidar que las mascarillas convencionales fueron diseñadas para proteger al enfermo de las partículas provenientes del cirujano; es decir, son eficaces para impedir la exhalación de partículas pero no tanto para prevenir la inhalación de las mismas. Recordemos que la protección respiratoria comienza con la educación de la persona usuaria, para que tosa o expectore sobre un pañuelo desechable colocado lo más cerca posible de su boca, y lo deposite luego en una bolsa roja doble situada a su alcance.

Precauciones comunes además de las estándares o universales

- En habitación individual y, cuando no se disponga de ésta, podrá compartir habitación con otro persona usuaria que tenga la misma infección activa por el mismo microorganismo.
- Para el transporte de la persona usuaria (limitar al máximo), debe informarse al servicio receptor. Se realizará siempre colocándole mascarilla antes de abandonar la habitación. El trabajador que le traslada no necesita llevar mascarilla.
- Visitas: restringidas, colocando aviso en la puerta y en el control de enfermería, donde se explicarán las normas de acceso.

- Si hubiera que tomar muestras, el esputo debe ser enviado en envase doble.
- Apósitos y pañuelos: de un solo uso y desechados en bolsa roja.

Precauciones para la transmisión aérea

Infecciones susceptibles son: tuberculosis pulmonar y laríngea, sarampión, meningitis meningocócica, rubéola, varicela y tosferina.



- Mantener siempre la puerta cerrada.
- Aireación máxima con puerta cerrada.
- Restricción de entradas en la habitación (personal sanitario y visitantes).
- Mascarilla antes de entrar en la habitación si se sospecha tuberculosis. En caso de varicela o sarampión, las personas inmunes no precisan protección.

Precauciones para la transmisión por gotas

Infecciones susceptibles: infección invasiva por H. Influenzae tipo B o Neisseria meningitidis, infecciones respiratorias víricas (adenovirus, rubéola, influenza, parotiditis, parvovirus B-19) o bacterianas (C. diphteriae, B. pertusis, M. pneumoniae, Y. pestis, estreptococo productor de faringoamigdalitis, neumonía y escarlatina en niños).

- No se necesitan sistemas especiales de ventilación. La puerta puede permanecer abierta.
- La mascarilla debe usarse cuando se esté trabajando a menos de un metro de la persona usuaria.

Precauciones de contacto

Para evitar la transmisión de infecciones por contacto directo o indirecto, con secreciones o exudados.

- No requieren habitación individual, excepto las infectadas por S. aureus meticilin-resistente y Streptococcus del grupo A. Debe elegirse el compañero de habitación (no portarán sondas urinarias, ni herida quirúrgica ni tubo endotraqueal).
- Batas cuando se esté en contacto directo con la persona usuaria.
- La ropa debe seguir la normativa específica de lavandería.
- Las visitas serán restringidas, colocando aviso en la puerta y en el control de enfermería, donde se explicarán las normas de acceso.
- Para el trasporte de las muestras, los exudados se colocarán en envase doble.

Persona usuarias que deben ser protegidos

- Heridas y quemaduras con drenaje o secreción profusa o infección.
- Gangrena gaseosa.
- Herpes zoster localizado.
- Melioidosis y peste bubónica.
- Sepsis puerperal.

Aislamiento protector (precauciones inversas)

Esta categoría especial trata de proteger a los persona usuarias gravemente inmunodeprimidos y no infectados, de un posible contacto con microorganismos patógenos.

Se contempla:

- Habitación individual con la puerta cerrada. Las habitaciones en que se ubican este tipo de persona usuarias deben estar dotadas de sistema de ventilación a presión positiva respecto al entorno, con sistema de filtración del aire mediante filtros HEPA (filtros absolutos).
- El lavado de manos es obligatorio al entrar y salir de la habitación.
- Mascarilla para todas las personas que entran en la habitación. Se desecharán después de cada uso.
- Se utilizarán batas: sí, aunque no es preciso que sean estériles.
- El personal de limpieza se protegerá de forma similar al personal sanitario (mascarilla, bata y guantes). Se procurará que la limpieza de la habitación de aislamiento protector sea la primera.

Los persona usuarias que deben ser protegidos son aquellos persona usuarias con rotura extensa de la piel, como grandes quemados, persona usuarias con terapia inmunosupresora, persona usuarias con neutropenia severa (menos de 1.000 neutrófilos/cc) esto es, con las defensas bajas.

Para ampliar información podéis consultar:

- el documento elaborado por la comisión INOZ sobre los sistemas de limpieza, desinfección y esterilización: http://www.sempsph.com/sempsph/attachments/087_Guia_Gestion_%20esterilizacion_Osakidetza.pdf

- el documento de la OMS[6] en su capítulo Programas de Control de infecciones que se encuentra en la siguiente dirección Web: http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf

1.6.- Asistencia al usuario para vestirse:

Manejo de la ropa y calzado de la persona usuaria.

Es importante para la persona dependiente seguir vistiéndose bien y a su gusto, para así mantener su imagen personal y aumentar su autoestima.



La elección de la ropa y el calzado debemos de hacerla de acuerdo con el estado funcional de la persona, sus gustos personales y la época del año.

En la vestimenta debemos elegir ropa cómoda, son preferibles los tejidos de fibras naturales, que necesiten poco planchado y fácil lavado. La ropa interior debe ser de algodón porque evitan reacciones alérgicas y absorbe el sudor.

Conviene evitar las compresiones perjudiciales para la circulación, tanto en la cintura como en las piernas (calcetines, medias ajustadas, ligas, fajas, etc.).

En caso de incontinencia urinaria o fecal debe evitarse la humedad excesiva, cambiar las prendas tantas veces como sea necesario y extremar la limpieza.

Además, es un factor importante el vestirse solo siempre que la persona pueda, porque así continúa valiéndose por sí misma y aumenta su autonomía, y con ello su satisfacción, porque se siente más útil. Por eso debemos facilitarle esta tarea y adecuar la ropa a las características de la persona mayor.

Cuando tengan dificultad para vestirse se recomienda que:

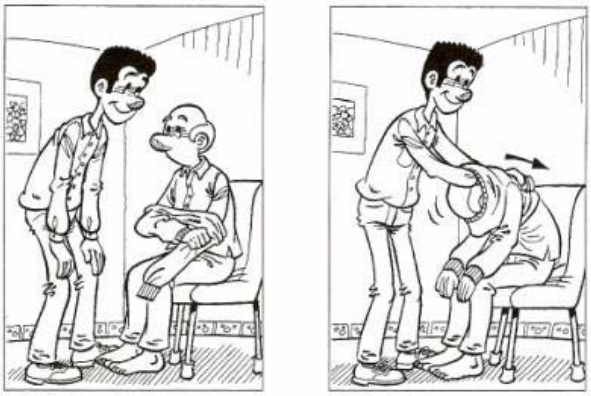
- Se eviten los botones, dejándolos de adorno y se use velcro (es aconsejable tener en cuenta que la parte más suave del velcro se pegue a la parte de la prenda que tiene más posibilidad de tocar la piel).

6 OMS Organización Mundial de la Salud

- Las cremalleras y cinturones se sustituya por elásticos y/o velcro.
- La ropa tenga abertura por delante.
- Los corchetes o cierre del sujetador se coloquen en la parte delantera o también pueden ir unido con velcro.
- Los trajes tengan las cremalleras en lugar visible y de fácil acceso.
- Si existen cremalleras en lugares difíciles se puede atar un cordel a las cremalleras para tirar de ella.
- Se usen cremalleras en la parte inferior del pantalón, si utiliza sistemas de recolección de orina ubicados en esta zona.

En el caso de personas con hemiplejías se aconseja:

- Vestirse primero el lado afecto.
- Vestirse sentado.
- Si es una chaqueta puede utilizar un bastón para atraer hacia sí la manga del lado que puede movilizar cuando ya se ha metido la del lado inmóvil.



- Los pantalones y las faldas se colocan también sentados. Comenzar por la pierna afectada



- Existen ayudas técnicas que facilitan la colocación de medias, calcetines y zapatos. Se explicarán en el siguiente apartado



- El calzado debe ser flexible y suave, preferente de piel natural. Elegir zapatos de una sola pieza con pocas costuras, tiene que ser cómodos y sujetar bien el pie, evitando materiales sintéticos. El tacón debe ser de unos 3 cm., siendo perjudiciales los tacones excesivamente altos porque aumenta la inestabilidad (riesgo de caídas) y desliza el pie hacia delante y pueden aparecer problemas como callos y juanetes.
  Se aconseja probar antes de comprar si es fácil de calzar y comprar a última hora de la tarde porque los pies están más hinchados.
  Las plantillas deben ser blandas y las plantillas almohadilladas ayudan a acoplar el pie al zapato.
  Al pisar el tacón debe apoyar totalmente en el suelo, al retorcer el zapato no debe perder su forma original y al doblarlo la suela no debe arrugarse. La suela ha de ser antideslizante, si es posible de goma en invierno y de cuero en verano

Vestido de la persona usuaria encamada

Dependiendo de la autonomía de la persona usuaria será necesaria la participación de uno o dos profesionales sociosanitarios.

Antes de comenzar debemos preparar la ropa necesaria y una bolsa de plástico para la ropa sucia. Explicarle la atención que se le va a prestar y si este colabora realizar los siguientes pasos:

- Mientras la persona usuaria eleva los brazos, introducir la prenda hasta los hombros. Si la prenda es cerrada, introducirla por la cabeza y deslizarla por la espalda evitando los pliegues. Si es abierta, introducir una manga hasta el hombro, pasar la chaqueta por la espalda y terminar con el otro brazo.
- Para colocar el pantalón o la falda, si puede colaborar solicitarle que levante las nalgas, e introducir la ropa sin dejar pliegues en lo posible
- Los calcetines se enrollan hasta la punta y se van desenrollando conforme se ponen.
- Los zapatos se colocarán cuando el residente esté sentado en el borde de la cama o en la silla. Si el zapato es de cordones o hebillas se aflojarán bien previamente cuidando de no apretarlos mucho al abrocharlos.

Si la persona usuaria no colabora:

- Si la prenda es cerrada, introducirla hasta los hombros elevándole los brazos, pasarla por la cabeza y girando lateralmente a la persona usuaria si es necesario, estirar bien la ropa evitando pliegues. Si la prenda es abierta, introducir un brazo por la manga hasta el hombro y pasar la chaqueta por detrás de la espalda. Flexionar el otro brazo e introducir la otra manga.
- Cuando la persona usuaria tiene suero o algún miembro afectado comenzar siempre por este. Si tiene suero, introducir el suero por la manga de la chaqueta o camisón y a continuación deslizar el brazo por la manga.
- Estirar bien la ropa para evitar pliegues.
- Para colocar el pantalón o la falda introducir el pantalón o falda hasta las rodillas, y girando a la persona usuaria se subirá la prenda, estirándola bien.

En cualquier caso dejar siempre a la persona usuaria en la postura adecuada, con todo ordenado y recogido.

La ropa sucia introducirla en bolsa de plástico para su posterior lavado y colocar en el armario la ropa que se vuelva a utilizar.

Al abandonar la habitación, asegurarse de que todo quede a su alcance.

En este video podéis ver un resumen:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pV3v0kHVS3s

Ayudas para su uso, accesorios.

Para aumentar la autonomía de las personas mayores dependientes, son indispensables, en ocasiones, algunas ayudas técnicas. En el mercado existen dispositivos para caminar, accesorios para el aseo diario, etc. En este punto nos limitaremos a las ayudas en el vestir.

Entre otras tenemos:

- Elegir prendas de vestir amplias y con aberturas grandes, son más agradables de llevar y más fáciles de poner.
- La ropa abierta por la espalda se pone fácilmente, ya que no requiere que se hagan grandes movimientos con los brazos, y con ella se puede vestir a una persona tanto si está de pie como sentada o tumbada.
- Es mejor elegir ropa que no se arrugue demasiado, salvo casos de alergia. Antes de comprar una prenda de algodón, debemos comprobar que lleva al menos un 50% de fibra y descartar aquellas que tienen más de un 30% de seda, lino, lana o rayón.
- Si la persona tiene dificultades para abrochar botones o cremalleras es mejor sustituirlas por cierres de velcro. También existen abrochadores y abrecremalleras



- Si la persona es incontinente y es necesario el uso de pañales y sobre todo si es necesario que éstos se los cambie otra persona, debe hacerse todo lo que esté en nuestra mano para que el cambio de pañales se pueda efectuar de la forma menos penosa y más rápida posible, usando pantalones amplios, fáciles de desabrochar (velero o con goma en la cintura), que permiten el cambio sin necesidad de desvestir a la persona.
- Pinzas de alcance. Existen unas pinzas de mango largo que se manejan desde una empuñadura situada en un extremo. En el otro extremo se ubican las pinzas curvas, recubiertas de goma antideslizante para evitar que los objetos resbalen. Algunos modelos disponen de un imán para los objetos metálicos pequeños. Su empleo permite recuperar cosas que, de otra forma, estarían fuera del alcance de las personas con movilidad reducida.



- Evitar los cordones de los zapatos y sustituirlos por velcros.
- Calzadores de mango largo y ponemedias







- La grúa de bipedestación es una muy buena ayuda



1.7.- Colaboración en los cuidados postmortem.

Todas las instituciones sociosanitarios debieran tener un protocolo de defunciones, podría ser algo muy similar a este:

PROTOCOLO DE DEFUNCIONES[7]

1. El profesional sociosanitarios competente de turno avisará a la trabajadora social, al Capellán y a Recepción.
2. La recepción avisará a todos los departamentos y conectará rápidamente la calefacción-aire acondicionado del tanatorio.
3. Al amortajar tener atención especial en: peinar, afeitar o depilar, cerrar bien la boca, colocar la venda para que no se vea y asimismo que no se vea el algodón de la nariz, colocar la dentadura (en su defecto suplir con algodón) y vestirle. Habrá sudarios en cada lencería de las plantas y en el almacén general. (a continuación se explica el procedimiento)
4. El aviso a la familia lo hará la trabajadora social, si ella no está lo hará el enfermero de planta.
5. *A la familia se le comunicará:*
   a. Que no tienen que llamar a la compañía de seguros ni funeraria.
   b. Que todo el papeleo se encarga de hacerlo la funeraria.
   c. Que no tienen que comprar los certificados de defunción.
   d. Que se traigan si tienen documentación sobre el lugar de enterramiento y la póliza de defunción, si está en su poder.
6. El aviso a la funeraria lo hará la misma persona que avisa a la familia.
7. Si está el tanatorio ocupado se utilizará otro emplazamiento ya previsto en el protocolo de la residencia.
8. El médico cumplimentará un certificado c de defunción. En caso de incineración se pondrá en el certificado que “no existen problemas para la incineración”. Los

7 Documento elaborado por el Centro de Humanización de la Salud (CEHS) de la residencia San Camilo de Madrid

formularios para estos certificados estarán en la primera planta, quienes se encargarán de pedir cuando queden pocos.

9. En las carpetas nominales de la Trabajadora Social estarán las pólizas de defunción, si las hubiere, y el lugar donde se le quiere enterrar, si es que se conoce. Para los enfermos de paliativos se tendrá siempre una fotocopia del DNI en la planta (también es conveniente tener una fotocopia de la póliza de defunción o de un recibo de p ago).
10. Se concretará entre familia-funeraria y residencia la hora del entierro.
11. Se comunicará a la familia que revise los objetos personales que el fallecido haya dejado en su habitación. Una vez revisados por la familia o bien después de haber manifestado ésta que no desea hacerlo, un auxiliar con el enfermero de turno recogerá todo lo sobrante en bolsas grandes y lo consignará a Recepción para que lo guarden en el ropero, donde se almacena la ropa nueva. Si existen objetos de valor (joyas, dinero...) el enfermero de turno los mete en un sobre con el nombre del anciano especificando lo que contiene y se lo baja al director (seguir el mismo proceso que en los traslados hospitalarios y en los estados de inconsciencia en la residencia).
12. Al día siguiente se limpiará a fondo la habitación y se dejará preparada para el próximo ingreso.

TÉCNICA DE AMORTAJAMIENTO

El material necesario*:* Mortaja o sudario para envolver el cuerpo; Vendas para atar las muñecas y tobillos, esparadrapo; Recipiente con agua y jabón para lavar todo el cuerpo; Esponja; Guantes para realizar la técnica del lavado; Toalla para secar después de lavar el cuerpo; Material para curas; Algodón; Jeringas de 10 c.c.; Pinzas; Tijeras; Bolígrafo y etiqueta para identificar el cadáver.

Procedimiento:

1. Verificar y confirmar el éxitus[8] en el parte médico. Se deberá colaborar con la enfermera responsable durante todo el proceso.

2. Trasladar a la persona usuaria que comparte la habitación con el fallecido a otra habitación o, en su defecto, aislarlo mediante un biombo o cortina;
3. Lavarnos las manos y colocarnos guantes de un solo uso;
4. Preparar todo el material necesario y trasladarlo a la habitación del fallecido;
5. Dejar el cuerpo en decúbito supino colocando la cama en posición horizontal si estaba levantada y se le deja una almohada;
6. Desconectar y retirar catéteres, drenajes, etc. que llevara el fallecido;
7. Realizar la higiene completa del fallecido. Lavarle la cara y afeitarle si hace falta, limpiarle las secreciones y peinarle;

8 Exitus es un término latino significa «salida» y se emplea en medicina como simplificación de la expresión más correcta Exitus Letalis, que literalmente significa «salida mortal» o «salida que causa la muerte» o más médicamente «proceso hacia la muerte». Su uso en medicina (sobre todo en medicina forense y medicina legal) es para significar que la enfermedad ha progresado hacia o desembocado en la muerte.

8. Colocar en un carrito el material para curas y ayudar a la enfermera a taponar las salidas de sangre u otras secreciones, si las hay, y a colocar el apósito perineal tras un taponamiento rectal y vaginal si se precisaran;
9. Estirar las extremidades inferiores y colocar los brazos a lo largo del cuerpo. El cadáver debe quedar alineado;
10. Cerrarle los ojos bajando los párpados superiores tirando levemente de las pestañas. Colocarle la dentadura si se le había quitado al enfermo moribundo, y cerrarle la boca;
11. Sujetar la mandíbula del cadáver con un vendaje alrededor de la cabeza;
12. Entregar a la enfermera los objetos de valor retirados del fallecido (para su posterior entrega a los familiares) y ponerle una bata mortuoria o sudario. Si la familia lo desea, se facilitará que puedan vestir con sus ropas al cadáver;
13. Cubrirle por completo con una sábana y ponerle la etiqueta de identificación: identificar al cadáver con nombre, fecha, hora y unidad de procedencia;
14. Antes del traslado al tanatorio, asegurarse de que las puertas de las demás habitaciones están cerradas y de que no circulan persona usuarias por los pasillos;
15. Notificar el éxitus a los servicios que corresponda: Farmacia, Admisión, Cocina, etc.
16. Recoger y limpiar la habitación, después avisar para su desinfección;
17. NOTA: Los fallecidos por causa de ciertas enfermedades contagiosas deben ser amortajados de forma especial.

En este video podéis ver un resumen, en este caso para la mortaja utiliza una sábana pero puede ser la propia ropa del fallecido o un sudario: http://video.google.com/videoplay?docid=3551206803419614439x

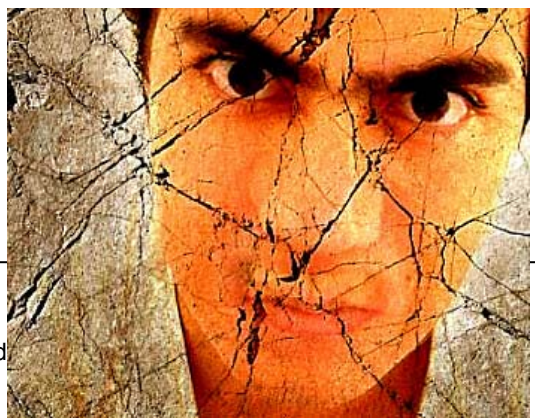
RECOMENDACIONES PARA EL DUELO

El duelo es un proceso normal por el que pasamos cuando hemos perdido a un ser querido y en el que tenemos que ir adaptándonos a una nueva realidad. La pérdida significa una ruptura inesperada con lo que ha sido nuestra vida hasta ese momento, todo a partir de ahora se ve de forma diferente, y necesitamos una adaptación.

Tiene 5 etapas:

Negación y aislamiento: la negación nos permite amortiguar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante; permite recobrarse. Es una defensa provisoria, pronto será sustituida por una aceptación parcial: "no podemos mirar al sol todo el tiempo".

Ira: la negación es sustituida por la rabia, la envidia y el resentimiento; surgen todos los por qué. Es una fase difícil de afrontar para los familiares y todos los que los rodean; esto se debe a que la ira se desplaza en todas



direcciones, aún injustamente. Suelen quejarse por todo; todo les viene mal y es criticable. Luego pueden responder con dolor y lágrimas, culpa o vergüenza. La familia y quienes los rodean no deben tomar esta ira como algo personal para no reaccionar en consecuencia con más ira, lo que fomentará la conducta hostil del doliente.

Pacto o negociación: ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, mas el enojo con la gente y con Dios, surge la fase de intentar llegar a un acuerdo para intentar superar la traumática vivencia.

Depresión: cuando no se puede seguir negando la persona se debilita y se verá invadida por una profunda tristeza. Es un estado, en general, temporario y preparatorio para la aceptación de la realidad. Hay que permitir que exprese su dolor, porque le será más fácil la aceptación final y estará agradecido de que se lo acepte sin decirle constantemente que no esté triste. Es una etapa en la que se necesita mucha comunicación, se tiene mucho para compartir, tal vez se transmite más acariciando la mano o simplemente permaneciendo en silencio a su lado.

Aceptación: quien ha pasado por las etapas anteriores en las que pudo expresar sus sentimientos -su envidia por los que no sufren este dolor, la ira, la bronca por la pérdida del hijo y la depresión- contemplará el próximo devenir con más tranquilidad. No hay que confundirse y creer que la aceptación es una etapa feliz: en un principio está casi desprovista de sentimientos. Comienza a sentirse una cierta paz, se puede estar bien solo o acompañado, no se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor... la vida se va imponiendo.

Aunque estas etapas están plenamente aceptadas, cada persona vive el duelo de una forma distinta.

COMO RELACIONARSE CON UNA PERSONA EN DUELO	
COMENTARIOS A EVITAR...	PARA TRANSMITIR COMPRENSIÓN...
No intentar consolar con frases represivas: "no llores", "no digas eso". Intentar, comprender que es el momento de llorar, quejarse y expresar emociones. No intentar "amortiguar" su pena recurriendo a aspectos positivos de su vida: "tienes tus hijos", "tienes más amigos", se transmite incomprensión. Evitar las frases que demandan fortaleza: "ahora tienes que ser fuerte", "no te puedes venir abajo". La persona en duelo suele tener sensación de impotencia ante "lo que se le viene encima". Este tipo de frases aumentarán su percepción de incapacidad. Evitar provocar su resignación con comentarios hechos y fríos: "es mejor así", "es el destino",	Háblele de manera sincera, respetando su dolor y haciéndose cargo de la magnitud de éste: "sólo puedo transmitirte mi gran tristeza, sabes cuánto quiero yo a María", "Como madre puedo imaginar tu desconsuelo." Transmítale su apoyo clara y concisamente. En situaciones tan difíciles es mejor ser breve: "estoy a tu disposición para cualquier cosa que necesites". No se lo repita una y otra vez, le abrumaría. Permítale que relate cómo ocurrió el fallecimiento. "Rumiar", los primeros días, una y otra vez las circunstancias de la muerte, le ayudará a ir tomando conciencia de la realidad de la pérdida. Háblele con sus gestos, si no le salen las

etc. Aceptar que una realidad tan dura esté sujeta al destino o a la voluntad de Dios, provoca un profundo sentimiento de vulnerabilidad y sobre todo de injusticia. No recurrir a aspectos impersonales y pasivos como el tiempo o el destino como "solución al sufrimiento": El duelo es un proceso activo en el cual el doliente ha de implicarse y trabajar para poder salir adelante. Pero eso sí, en su momento.	palabras. Recuerde que son el lenguaje del corazón. Apriete sus manos, mírele a los ojos con complicidad en el dolor, si tiene la suficiente confianza, abrácele. Él sabrá entender su silencio. Recuerde que él "sólo" espera de usted que le acompañe en su dolor, es decir, que comprenda su tristeza y se la consienta.

2. Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación de la persona usuaria

Las personas dependientes necesitan un hábitat adecuado a sus necesidades para asegurar una calidad de vida.

CONDICIONES IDÓNEAS DE LA INSTITUCIÓN.

Suelos.

- No se use cera abrillantadora para su limpieza.
- Sean lisos y antideslizantes, sin desniveles.
- Sean de cerámica texturados, graníticos, vinílicos o de madera sin lustre.
- Se rellenen las juntas e irregularidades para facilitar el deslizamiento de las ayudas técnicas (silla de ruedas, andadores,...)
- No se dejen obstáculos en el suelo.

Mobiliario

- No exista exceso de muebles, que estén fijos a las paredes o al suelo.
- Las estanterías sean bajas.
- La distribución de las sillas, mesas, etc., permitan la libre deambulación, teniendo en cuenta el uso de elementos auxiliares (muletas, sillas de ruedas, andadores u otro material ortoprotésico).
- Las sillas tengan reposabrazos y respaldos altos.

Puertas y pasillos



- Los pasillos sean anchos y las puertas amplias.
- Las puertas tengan picaportes en “L”.
- Existan pasamanos en las paredes.

Escaleras.

- La altura de los peldaños sea menor de 15 cm y que el ancho (fondo – huella) sea mayor de 30 cm.
- Los pasamanos estén fijos a ambos lados, de forma cilíndrica y situados a una distancia entre 2 y 5 cm de la pared.
- Tengan rellanos intermedios, no más de diez escalones.
- Se coloquen en los peldaños huellas antideslizantes de seguridad.
- Se sustituyan tramos cortos por rampas si fuera necesario y posible

Los cuartos de baño

El cuarto de baño presenta serios problemas para la persona con escasa movilidad y estabilidad.

Es recomendable que:

- Se aumenten los puntos de apoyo con barras o asideros que permitan conservar el equilibrio y la seguridad.
- Plato de ducha, o una superficie antideslizante que permita el correcto desagüe del agua, sobre todo si utiliza silla de ruedas.
- Se utilicen alfombras antideslizantes
- El uso de duchas tipo teléfono, ya que permiten una mayor comodidad y estabilidad, estando incluso sentado. También resulta cómodo poner una agarradera a la esponja. Existen otras adaptaciones que ya hemos visto en el apartado 1.2.- Aplicación de técnicas de aseo e higiene corporal de este módulo.
- La luz sea adecuada.
- El inodoro tenga el asiento alto o un adaptador.
- Los lavabos no tengan pie y su altura máxima sea de 80 cm y el espejo esté inclinado a una altura de 95 cm, en caso de usar silla de ruedas.

Dormitorio

Lo más importante a destacar es la limpieza, el confort, la aireación, la luminosidad y la temperatura. Se aconseja que:



- La habitación esté ventilada, sin corriente ni malos olores.
- Se aproveche la luz natural, el sol da vida y en las personas mayores cobra mayor relieve porque favorece la absorción de calcio y la cicatrización de posibles heridas.
- Si la persona usuaria está encamado, el ambiente sea tranquilo evitando ruidos innecesarios (reloj, tele, despertador, etc.).
- Los objetos personales o recuerdos están a su alcance.
- Se eviten los muebles y obstáculos innecesarios así como alfombras.
- Si fuera posible, se adapten rampas de acceso y agarraderas.
- Los armarios se organicen colocando lo más pesado en la parte baja y lo más ligero en la parte alta, y lo que más use, a su alcance.

Mobiliario de la habitación de la persona usuaria

La cama es un elemento donde la persona pasa mucho tiempo, por su encamamiento o por convalecencia relacionadas con su edad o algunas patologías, por ello debe ser cómoda y no debe provocar problemas de salud.

Irá provista con toda la lencería necesaria.

Debe colocarse en la habitación de manera que tenga tres de sus lados libres, para facilitar el trabajo del personal sanitario (cambios posturales, aseo de la persona usuaria, aplicación de cuidados, etc.).

Se dispone de forma que el cabecero esté en contacto con la pared, pero sin que se ubique debajo de la ventana, ni próxima a la puerta (para no impedir el acceso a la habitación o al aseo).

Sus medidas estándar son:

- 0,80-0,90 m de ancho.
- 0,70 m de alto (sin colchón).
- 1,80-1,90 m de largo.

Es decir, tendrá las medidas necesarias para favorecer el descanso y bienestar de la persona usuaria y facilitar la realización y aplicación de los cuidados necesarios.

Es importante que sean articuladas y con un plano regulable en altura y fácilmente manejables en su movilización, por lo que deben disponer de ruedas.

Los accesorios de la cama son:

a. *Colchón* de una o varias piezas, cubierto con una funda para su protección, que debe estar fabricada en un material elástico, transpirable al vapor e impermeable al agua y debe ser hipoalérgica e ignífuga.
b. *Almohada* con funda de protección.
c. *Barandillas* laterales como medida de protección de la persona usuaria.
d. *Sistema electrónico* para la regulación de la altura, de forma automática o *Manivela* para regular de forma manual la altura y articulación de la cama.
e. *Otros accesorios, opcionales en función de las necesidades de la persona usuaria son:* triángulo, barras de tracción, pesas, poleas, etc.

Mesilla

Se sitúa junto a la cama, de forma que sea accesible, para que la persona usuaria pueda coger cualquier objeto o utensilio que necesite.

Silla o sillón



Se utilizan como lugar de descanso para aquellas personas usuarias independientes.

Deben ser cómodos y estar tapizados con material, de alta durabilidad y de fácil limpieza y desinfección.

Suelen disponer de brazos y reposapiés.

Se colocan junto a la persona usuaria, al lado contrario de la mesilla.

Siempre que el espacio lo permita, se debe disponer también de una silla o sillón para sus visitantes (deben ser cómodos y de material fácilmente lavable). Se colocan en la habitación, de manera que no interfieran el acceso a la cama ni al aseo, y que permitan a la persona usuaria desplazarse por la habitación con comodidad.

Armario

Se utiliza para guardar la ropa y otras pertenencias de la persona usuaria y también una manta de repuesto por si la persona usuaria la necesita.

Contendrán baldas, cajones y perchas suficientes.

Lámpara

Generalmente está fijada a la pared para que no ocupe espacio y para evitar riesgos de accidente.

Biombo

Se emplea para separar una cama de otra si es que la habitación es compartida. Su objetivo es mantener y preservar la intimidad de la persona usuaria.

Papelera o cubo

Suele ubicarse dentro del aseo y se utiliza para recoger los desechos (basura, papeles, etc.) generados por la persona usuaria (que no sean sanitarios ni biológicos). Suele ser de tamaño pequeño y lleva una bolsa de plástico en su interior para facilitar su recogida y limpieza.

Todo el mobiliario debe estar fabricado con materiales de colores claros, para que no se enmascare la suciedad y sea fácilmente lavable, pues puede ser una importante fuente de infección.

HIGIENE DE LA HABITACIÓN

Los profesionales sociosanitarios son los responsables de la higiene personal de la persona usuaria, así como de mantener la cama en condiciones idóneas para facilitar su comodidad. Deben realizar la retirada de excretas en las condiciones de seguridad e higiene más adecuadas, para evitar el riesgo de posibles enfermedades infecciosas. Para favorecer la comodidad de la persona usuaria, además de todos los aspectos reseñados anteriormente, es importante mantener la habitación de la persona usuaria en condiciones óptimas de limpieza e higiene.

La acumulación de eliminaciones de la persona usuaria (orina, vómitos, exudados, heces, etc.) en un ambiente semicerrado o cerrado da lugar a que se produzcan olores desagradables, que repercuten en la propia persona usuaria, en el personal sanitario, en otras persona usuarias y en las visitas.

Todo ello hace que el entorno resulte incómodo y poco acogedor, además de constituir, desde el punto de vista sanitario, una posible e importante fuente de infección, que hace necesaria la limpieza y eliminación de la suciedad para evitar el riesgo de que se produzcan infecciones nosocomiales.

Si el personal sociosanitario observa que la habitación del persona usuaria no reúne las condiciones adecuadas, debe avisar al personal de limpieza para que friegue el suelo y limpie los muebles para evitar la diseminación de microorganismos.

Al realizar la limpieza, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Se debe llevar a cabo siempre en seco.
- El polvo se elimina por aspiración.
- Las superficies de muebles, aparatos, materiales, etc., se limpian con un paño húmedo.
- Se tendrá en cuenta que el polvo es un agente contaminante que favorece el proceso de diseminación y transmisión de microorganismos, con las consecuencias negativas que lleva asociado.
- La limpieza de la habitación se hará diariamente y todas las veces que sea necesario, para mantenerla en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
- Antes de iniciar el proceso, es importante tener preparado todo el material necesario para la limpieza.
- Se realiza, siempre que sea posible, con las ventanas abiertas, pero evitando las corrientes de aire.
- No hay que olvidar que la lejía es el mejor desinfectante, aunque actualmente haya en el mercado una gran variedad de productos que consiguen los mismos resultados y tienen un olor más agradable.
- Cuando la habitación queda libre, debe realizarse una limpieza más exhaustiva de todos los muebles, así como de todo el material que tenga que ser reutilizado; en algunos casos será necesario desinfectarlo y esterilizarlo.

Para la limpieza de las habitaciones hay que seguir unas Normas generales de limpieza:

- debe ser metódica, programada y continua (diaria).
- Todos los servicios, incluido el departamento de administración, intervienen en la difusión de la contaminación por lo tanto debemos ser escrupulosos en su limpieza
- El plan basado en la limpieza, la desinfección y el buen comportamiento higiénico de las personas, debe ser una responsabilidad compartida por todo el personal.
- Sólo si se logra una perfecta coordinación del estamento profesional de la limpieza con el personal sociosanitario podrá traducirse en una higiene eficaz.
- En cada área, la limpiadora contará para la realización de su trabajo con: 1) Doble cubo de distintos colores, uno para la solución de detergente + desinfectante y otro para el aclarado y 2) Dos cubos de distintos colores con paño y bayetas de diferentes colores, ya sean para el mobiliario o para el baño.



Métodos y productos para cada área del hospital

- Como ya se ha indicado barrido en seco no se contempla; siempre se procederá al arrastre húmedo.
- La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba abajo, y siempre de dentro hacia fuera.
- El hipoclorito siempre se debe diluir en agua fría.
- Renovar el contenido del doble cubo en cada habitáculo.
- Una vez realizada la limpieza el material se guardará limpio, desinfectado y escurrido.
- Pueden utilizarse como desinfectantes para su aplicación en suelos y superficies los siguientes: fenoles, aldehídos, hipoclorito diluido al 20%, (si se cuenta con algún área crítica la dilución será al 10%). Se tendrá en cuenta el no utilizar hipoclorito en superficies metálicas porque se deterioran. Hay que seguir siempre las indicaciones realizadas en las instrucciones de la casa suministradora del producto utilizado.

2.1.- Disposición y limpieza de los efectos personales de la persona usuaria.

Toda persona usuaria debe tener en su habitación:

- Un vaso para beber y una jarra (colocados sobre la mesilla).
- Otro vaso para la realización de la higiene bucal (en el cuarto de baño).
- Una palangana para la limpieza del persona usuaria.
- Una cuña o botella para la recogida de las heces y orina (en persona usuarias encamados).
- Recipientes adecuados para las recogidas de muestras si fuera necesario.
- Pijama o camisón y bata al alcance de su mano. Además de toda la ropa necesaria que será guardada en su armario.
- Un paquete de pañuelos desechables o de gasas.

- Lencería para la cama (sábanas, almohadón, protector o empapador, manta y colcha). La que no se utilice se guarda en el armario de la lencería y se cambian según indique el protocolo de la institución
- Material de higiene personal colocado en el cuarto de baño. Dentro de este grupo se incluyen:
  - Jabón líquido (gel).
  - Esponja (actualmente se utilizan las jabonosas y de un solo uso).
  - Peine.
  - Toallas.
  - Crema hidratante.
  - Papel higiénico.
- En determinadas ocasiones, y en función de la situación personal y patología que padezca la persona usuaria, es necesario disponer de otro tipo de materiales y equipos que permitan aplicar más fácilmente los procedimientos técnicos necesarios para favorecer el bienestar de la persona usuaria. Los equipos accesorios más habituales son los siguientes:
  - Férulas de acero o arco: dispositivo que se coloca sobre el persona usuaria para que la ropa de cama no descanse directamente sobre su cuerpo.
  - Pupitre: es un respaldo regulable, formado por un arco metálico, que se utiliza para ayudar a la persona usuaria a permanecer sentada.
  - Almohadillas: permiten que la persona usuaria pueda adoptar distintas posiciones con comodidad y sin resbalarse.
  - Centinelas de la cama: son almohadillas de polietileno, que contienen aire en su interior (infladas), y que se colocan a los lados de la cama para evitar lesiones o caídas del persona usuaria.
  - Trapecio de cama para ayudarse a incorporarse
  - Pie de gotero: se dispone adaptándolo a la cabecera de la cama, o bien como dispositivo independiente, permitiendo la regulación de su altura y el desplazamiento del persona usuaria, pues va provisto de ruedas. Se utiliza para colgar las bolsas y frascos de sueros, medicación, nutrición, etcétera, facilitando así la administración y aplicación a la persona usuaria.



- Equipos o dispositivos para la movilización o desplazamiento de la persona usuaria:
  - Silla de ruedas.
  - Grúas de arrastre, de cama, de bipedestación.
  - Muletas o bastones.
  - Andadores, etc.

2.2.- Control de las condiciones ambientales:

Las habitaciones destinadas a la hospitalización de las persona usuarias deben reunir una serie de requisitos en relación con las condiciones ambientales que repercuten en el estado de salud.

El medio que rodea a la persona usuaria, el mobiliario y la decoración tienen una notable influencia sobre la respuesta al tratamiento que está recibiendo. El estado de ánimo de la persona usuaria puede verse afectado como consecuencia de las características del ambiente; en este sentido, la *limpieza* y la *seguridad* son los dos elementos que mayor importancia.

Los factores medioambientales que repercuten directamente y en mayor medida sobre el bienestar y la comodidad de la persona usuaria son:

Luminosidad.

Hay que utilizar el color en las paredes adecuadamente ya que proporciona un mejor aprovechamiento de la iluminación artificial, además existen tratamientos superficiales que evitan el brillo y los reflejos que puedan molestar.



Hay que aprovechar al máximo la luz natural no solo por ser la el tipo de iluminación idóneo sino también por sus propiedades curativas, desinfectantes, térmicas, etc. Además de su importancia como factor esencial de salud, la luz solar aporta a las habitaciones iluminación natural, que va a influir en el estado de ánimo de los persona usuarias. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una iluminación excesiva o que incida directamente sobre la cara de la persona usuaria puede ocasionar molestias y producir irritabilidad, nerviosismo, etc.

Algunos especialistas en la materia opinan que una habitación está bien iluminada si tiene un espacio de ventanas igual, en superficie, a casi la cuarta parte del suelo.

Luz artificial (iluminación eléctrica) utilizada está diseñada de forma que pueda ser utilizada según las necesidades.

Puede adaptarse para que proporcione luz indirecta, como luz de foco directo para el examen de la persona usuaria, luz para leer o luz muy débil. La luz ha de ser buena, evitando las luces brillantes.

Los interruptores deben estar accesibles, con señalización de encendido y apagado, claro y sencillo.

Las instalaciones eléctricas antiguas deben revisarse periódicamente y no demorar los arreglos en las que los necesiten.

Las bombillas de poco voltaje (40 – 60 w) se sustituyan por otras de mayor voltaje (100 w) en aquellos lugares donde se suele realizar actividades.

Temperatura.

Generalmente, la temperatura ambiente que debe tener la habitación oscila entre los 20-23° C. Las personas reaccionan de manera diferente a las condiciones atmosféricas, por lo que se ha establecido una temperatura que puede considerarse ideal para todas ellas.

Temperaturas inferiores a éstas pueden hacer que la persona usuaria sienta frío; y temperaturas superiores a las establecidas hacen que se sienta incómodo por el efecto del calor. En ambos casos, se siente molesto y en condiciones inadecuadas para sentir bienestar.



La temperatura se regula mediante termómetros o termostatos que se disponen en las habitaciones de los persona usuarias, pasillos, dependencias especiales, etc., y que detectan y avisan (en ocasiones) de las variaciones bruscas de temperatura que ocurran en algunas zonas del hospital.

Hay instituciones que disponen de circuitos cerrados de ventilación, que llevan incorporado un sistema automático de control de la temperatura, adecuándola a las necesidades que se hayan programado previamente.

Es importante que se realice el mantenimiento y limpieza de los sistemas de control de la temperatura con el mayor rigor posible, ya que con gran facilidad se producen contaminaciones de los sistemas de refrigeración, sobre todo por *Legionella.* (El hábitat natural de este microorganismo es el agua, donde puede mantenerse y multiplicarse con facilidad; además, es capaz de resistir temperaturas de hasta 60°C, lo que hace que los persona usuarias de alto riesgo puedan adquirir la enfermedad a través de esta fuente de infección.)

La temperatura ambiente puede variar en función del lugar o zona de la institución en que nos encontremos. Las variaciones pueden oscilar entre los siguientes intervalos:

Zona	Temperatura en °C
Pasillos	20–21
Habitación de la persona usuaria	20–23
Zonas comunes	21–23

Ventilación.

Movimiento del aire y ventilación

El aire caliente pesa menos que el frío, por lo que tiende a elevarse; de esta manera, en los espacios cerrados asciende desde el suelo hacia el techo. El movimiento que realiza el aire, debido a las corrientes que producen las variaciones de temperatura, tiene un efecto tonificante sobre el organismo.

El acondicionamiento consiste en hacer que el aire de las residencias, consiga tener unas características casi iguales a las del aire libre.

La ventilación se realiza, normalmente, abriendo las ventanas y la puerta durante cortos espacios de tiempo y de forma alternativa, si hay más de una ventana. Para renovar el aire de la habitación es suficiente con que se abra la ventana durante 10-15 minutos.

Siempre que sea posible, se lleva a cabo durante los procedimientos de cambio de ropa de cama y limpieza de la habitación.

Cualquiera que sea el método elegido para ventilar una habitación, se evitará que se originen corrientes de aire.

Hay instituciones con circuito cerrado de aire acondicionado o sistemas de climatización, no deben abrirse las ventanas de las habitaciones para ventilar, pues el aire está en constante renovación y, si se abriera la ventana, se producirían descompensaciones en el circuito del aire.

Pureza del aire

Las impurezas habituales que se encuentran en el aire son gases, partículas de polvo y microorganismos.

Las enfermedades respiratorias pueden diseminarse mediante estas impurezas. En las habitaciones debe protegerse a las persona usuarias contra la infección mediante la aplicación de técnicas de aislamiento, liberación del polvo, buena ventilación y amplio espacio entre las camas.

Ruido.

Los investigadores han demostrado que el ruido ambiental, expresado en decibelios (dB), tiende a producir fatiga física y trastornos nerviosos o emocionales.

Muchas instituciones están sustituyendo los antiguos sistemas acústicos de alarma o de llamada (altavoces, intercomunicadores) por sistemas ópticos de aviso que emplean luces, tanto en los paneles del control de enfermería como en las habitaciones de los persona usuarias, cuarto de curas, lencería, *office* y cualquier otra sala de la planta para evitar los riesgos derivados de la exposición continua a determinados ruidos.

El ruido que se genera puede provenir del exterior o del interior (de la propia institución):

Ruido exterior

Se produce, generalmente, como consecuencia de la realización de obras, circulación, sonidos de sirenas de ambulancias, coches de la policía y otra serie de actividades, que en muchos casos, además, pueden llevar asociada la producción de vibraciones.

Estos ruidos resultan inicialmente inevitables, pero en muchas entidades sociosanitarias se tiende a colocar sistemas de aislamiento en las ventanas, que tienen como objetivo mitigar los efectos negativos derivados del ruido y de las vibraciones, ya que todos estos factores pueden influir en el estado emocional de los persona usuarias.

Ruido interior

Se produce como consecuencia del tránsito de personas en los pasillos y de la actividad laboral del propio centro sanitario.

El nivel tolerable de ruidos en el ambiente, en términos generales, éste no debe ser superior a los 25 dB.

Para evitar la producción de ruidos, es importante que el personal sanitario cumpla con las siguientes normas:

- Respetar los carteles de recomendación de «Silencio».
- Hablar en tono moderado, nunca a gritos o en tono de voz alto, ni con risas llamativas o escandalosas.
- No permitir que en las habitaciones se escuche la TV o la radio con un volumen elevado.
- Controlar la utilización de los teléfonos móviles.
- No golpear puertas al entrar o salir de la habitación.
- Desplazar el mobiliario suavemente y sin arrastrarlo.
- Utilizar calzado de suela flexible o de goma para evitar desplazamientos ruidosos (taconeo).
- Realizar el transporte de las camas, sillas de ruedas, carros, pies de goteo, etc., con cuidado, evitando hacer ruido o golpear las paredes, muebles o las puertas.

Es importante, siempre que sea posible, que a las visitas se les recomiende el cumplimiento de estas normas.

2.3.- Técnicas de realización de camas:

Tipos de camas y actuación ante las mismas.



CAMA METALICA DE SOMIER RÍGIDO

Consta de un somier rígido, sin articulaciones.

CAMA METALICA DE SOMIER ARTICULADO

El somier se divide en tres segmentos móviles, encargados cada uno de ellos de alojar diferentes zonas corporales. El superior es para la cabeza y espalda, el central para la pelvis y el inferior para las extremidades inferiores.



Los distintos segmentos de somier se mueven mediante la utilización de una manivela. Otro de los dispositivos con los que está equipada esta cama es de ruedas para su transporte, además de un sistema de frenado.

CAMA METALICA DE SOMIER ARTICULADO ELÉCTRICA

Al igual que la anterior son metálicas y de color claro. El somier articulado en tres segmentos se moviliza utilizando un sistema eléctrico. Poseen una batería que acumula energía para poder cambiar de posición sin necesidad de conectar el cable eléctrico. Dispone de un mando que permite posicionarla en las diferentes posiciones



.

El elemento fundamental de la cama es el COLCON. Hay varios tipos y los más utilizados son:

- Colchón de látex. Hoy día se utilizan cada vez más, por constituir una buena base para el reposo del paciente.
- Colchón de espuma. Se deja vencer más fácilmente por el peso del cuerpo. Puede ser de una pieza o estar seccionado en bloques (40-50 bloques). Favorece la comodidad y el acoplamiento del paciente, repartiendo la presión del cuerpo, y evitando una excesiva fricción y roces en la piel.
- Colchón alternating o antiescaras. Consta de una serie de tubos neumáticos que se hinchan y deshinchan alternativamente mediante el funcionamiento de dos motores. Mientras están hinchados los tubos de número par, los de número impar permanecen deshinchados, invirtiéndose automáticamente el ciclo cada cuatro minutos. Este tipo de colchón, al desplazar los puntos de apoyo, evita la presión y, además, realiza un masaje continuo.





- Colchón de esferas fluidificado. Está formado por esferas de vidrio muy finas que se mantienen en movimiento gracias al aire insuflado entre ellas, lo que permite repartir la presión que ejerce el peso del cuerpo del paciente, experimentando una sensación de estar flotando.

Además de los ya citados, existen colchones de muelles, aunque cada vez se utilizan menos, de agua, empleados para prevenir las úlceras por presión, y también de poca utilización y de agua con bolas de poliuretano que se colocan sobre el colchón habitual y permiten reducir el volumen de agua necesario.



Ropa de cama: tipos, complementos, climatología.

La cama debe tener los siguientes elementos de lencería:

SÁBANAS

Se cambian a diario o cada vez que se ensucien o mojen.

Serán preferiblemente de algodón y su tacto no será rugoso.

Son 3:

- La BAJERA que va sobre el colchón
- La ENCIMERA que va bajo la manta y la colcha
- La ENTREMETIDA se sitúa entre la pelvis del enfermo. Es de tamaño inferior a la bajera y encimera. Su misión fundamental es la de proteger, aunque también la podemos utilizar para desplazar al enfermo (es necesario dos auxiliares) hacia la cabecera de la cama cuando éste se ha ido resbalando y se encuentra muy cerca de los pies de la cama.

PROTECTOR DE COLCHÓN IMPERMEABLE

Su ubicación sobre el colchón para protegerlo

MANTAS

Su composición es lana ya que este material es más caliente y ligero. Generalmente son de color claro y nunca deben estar en contacto con la piel del enfermo, siempre sobre la encimera.

COLCHA

Se coloca cubriendo la manta. Generalmente es blanca.

ALMOHADAS

Se les coloca una funda de tela que debe ser cambiada al menos diariamente, además de cada vez que sea necesario.

ORDEN DE LA LENCERÍA EN LA CAMA

1. Funda de colchón.
2. Bajera.
3. Empapador
4. Entremetida.
5. Encimera.
6. Manta.
7. Colcha.
8. Funda de la almohada.

CÓMO SE DOBLA LA LENCERÍA

1. La sábana bajera se dobla a lo largo y con el derecho hacia adentro.
2. La sábana encimera se dobla a lo ancho y con el revés hacia adentro.
3. La sábana entremetida y el hule se doblan a lo ancho con el derecho hacia adentro.
4. La manta y la colcha se doblan a lo ancho y con el derecho hacia adentro.

Hoy en día en muchas instituciones se utiliza servicio de lavandería externo, por lo que antes de realizar la cama debemos confirmar que colocamos bien las sábanas por si acaso.

ACCESORIOS:

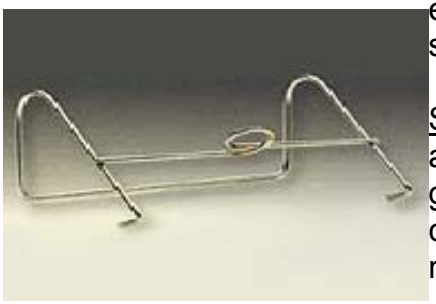
Barandilla o Reja de Seguridad: se coloca a los lados de la cama y puede ocupar todo o parte del lateral. Este accesorio se usa para evitar posibles caídas en pacientes. También se usan para facilitar la movilización a los pacientes, que necesitan de un punto de apoyo para moverse, así pueden agarrarse a la barandilla para lateralizarse o sentarse en la cama.



Protector de Barandilla o centinela de cama: Es como una especie de almohada rígida que se coloca entre el colchón y la reja de seguridad. Sirve para proteger al paciente de posibles golpes con la barandilla.



Arco de Lama o Férula de Arco: Es un dispositivo que puede estar hecho de hueso, madera, metal, plástico, compuestos o escayola, que se utiliza para fijar, unir o proteger una parte lesionada del cuerpo. Se coloca sobre el paciente para aliviar el peso de la ropa.



Soporte o pie de Suero: Es un accesorio muy útil también, y en este caso sirve de soporte para el suero o para la nutrición enteral.



Soporte de Bolsa de Orina: Es un accesorio que contiene dos ganchos en los que se ajusta el conector de orina de los enfermos, normalmente con sondaje vesical.

Tablillas para los pies. Es un dispositivo que se coloca en el pie de la cama para apoyar los pies del enfermo. Algunos se ajustan al marco o "tambor" de un lado al otro del pie de la cama; otros se fijan a los lados del marco de la cama y de esta forma pueden descansar sobre el colchón en un punto a lo largo de la cama. Las tablillas para los pies suelen ser de madera, plástico o lona dura.

Normalmente, los pies de los pacientes acostados en posición dorsal se doblan hacia las plantas. Si no se ejercitan o apoyan, con el tiempo pueden quedar fijos en flexión plantar (pie péndulo o pie equino).

Posiciones de la cama.

La cama articulada puede llegar a adoptar las siguientes posiciones:

- El plano horizontal. En algunas eléctricas además se puede modificar la altura del plano horizontal. En este plano las posiciones básicas son:

Posición de DECÚBITO SUPINO

Es la posición que se emplea con mayor frecuencia para estar o para las exploraciones médicas. También es parte del plan de cambios posturales



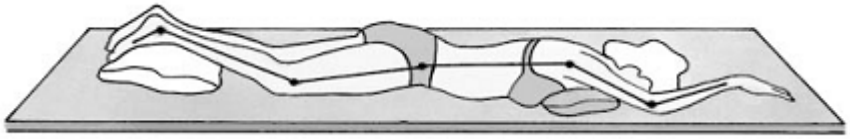
Posición de DECÚBITO LATERAL

Se utiliza en los cambios posturales, en la higiene corporal, para el descanso, cambio de ropa de cama con paciente encamado…





Posición de DECÚBITO PRONO



Sería la ideal para por ejemplo una úlcera de sacro, forma parte del plan de cambios posturales pero se tolera mal y se usa por eso muy poco.

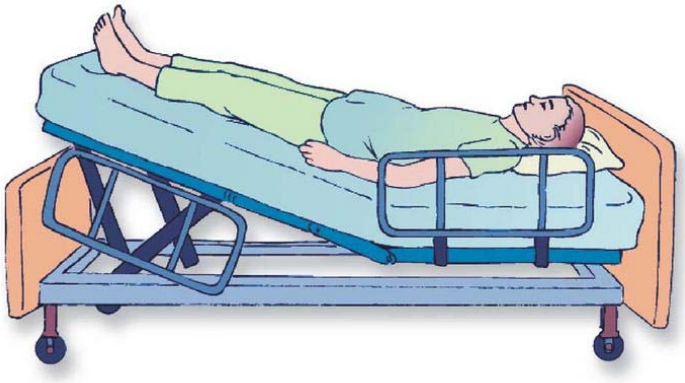
- Se eleva solo el cabecero y tenemos la posición fowler, (imagen de la derecha).





La posición de fowler se utiliza para administrar comida, para permanecer en la cama, para la higiene bucal…

- Eleva los pies de la persona usuaria por ejemplo para aliviar edemas[9]



- La posición sillón. Se eleva el cabecero y pliega hacia abajo la parte de los pies



- Trendelenburg con la cabeza mas baja que los pies. Se da en situaciones que requieran un buen aporte sanguíneo cerebral, mareos, lipotimias etc.



- Anti-trendelenburg con los pies por debajo de la cabeza. Está indicada en pacientes con problemas respiratorios, hernia de hiato, etc

9 es la acumulación de líquido en el espacio tisular intercelular o intersticial, además de en las cavidades del organismo



La cama rígida como mucho podrá adoptar la posición horizontal, la trendelenburg y la anti-trendelenburg.

Estas son las posiciones básicas pero hay muchas otras, por ejemplo, la que utilizáis para el lavado del cabello hiperextensinando el cuello se llama Roser que veremos en el apartado 3.3 del módulo 3 de este manual.

En la siguiente página Web encontrarás más información y videos sobre las posiciones anatómicas y sus usos: http://posicionesanatomicas-cesalud.blogspot.com/

Protocolos de actuación para camas cerradas y ocupadas.

En una institución, al igual que en el ámbito hospitalario la cama puede estar:

- Abierta, aquella que ya tiene asignada una persona usuaria. En este supuesto hay dos opciones:
  - Ocupada: la persona usuaria permanece encamado.
  - Desocupada cuando puede deambular o pasar a la silla por breves periodos de tiempo.
- Cerradas, cuando tienen asignada una persona usuaria.

CÓMO HACER LA CAMA DESOCUPADA O LA CERRADA

La técnica para hacer una cama desocupada o la cerrada es la misma. A continuación describiremos el procedimiento.

0.- Nos lavaremos las manos con agua y jabón y nos colocaremos guantes de un solo uso como cada vez que efectuemos un procedimiento

1.- En primer lugar prepararemos todo el material

- Guantes desechables
- Carro de lencería sucia. Cuando finaliza el procedimiento hay que depositarlos en la tolva o en el carro de la lavandería.



- Carro de lencería limpia. Como se puede ver en la imagen puede un mismo carro utilizarse para la ropa limpia y la sucia. En este caso cuando finaliza el procedimiento hay que depositar los sacos de la ropa sucia en la tolva o en el carro de la lavandería. El carro de la lencería limpia suele guardarse en el almacén de planta.



2.- El carro (los carros, según sea nuestro caso) se deja en la puerta y se coge lo necesario.

3. La lencería se pone en una silla en sentido inverso al que se va a quedar colocado. Esto es, cogemos el material en este orden:

1. Funda de la almohada
2. Colcha
3. Manta.
4. Encimera
5. Bajera.
6. Entremetida
7. Empapador

8. Funda de colchón

4.- Comentar a la persona usuaria lo que se va a hacer y si está encamada pedirle que se levante un momento. Si es posible hacer la cama en horizontal.

5.- Comprobar que la cama está frenada si lleva ruedas y que la temperatura de la habitación es la adecuada, así mismo evitaremos en lo posible las corrientes de aire

6.- Retirada de colcha y manta, a continuación retirada de encimera y entremetida y por último, retirada de empapador y bajera y si fuera necesario, la funda del colchón. En cada institución está protocolizado cada cuanto tiempo se cambia la funda del colchón pero, siempre que esté sucia o que la cama sea cerrada hay que cambiarla.

7.- Tirar del colchón hacia la parte superior de la cama, hasta que toque la cabecera.

Colocar la funda del colchón si fuera necesario. Normalmente son con gomas ajustables.

8.- Colocar la bajera. Ajustar las cuatro esquinas haciendo la mitra y remeter los dos laterales. Para hacer la mitra seguir los siguientes pasos:



a.-


b.-


c.-

a.- se mete la sábana bajera bajo el cochón a unos 25-30 cm del extremo remetido con la mano.

b.- Se deja caer esa parte de la sábana.

c.- Se remete bajo el colchón

El modo de realizar la mitra, se explica claramente en cualquiera de estos dos videos:

- http://www.youtube.com/watch?v=nc2seSFbonk
- http://www.youtube.com/watch?v=fqgzrRWU1aI&feature=relat

9.- Colocar el empapador sobre tercio medio del colchón y sobre éste la entremetida, procurar remeter bien los laterales.



La funda del colchón, bajera, empapador y entremetida deben estar bien estiradas y sin arrugas.

10.- A continuación se coloca la encimera, sobre esta la manta y cubriendo a ambas la colcha. La encimera, manta y colcha debe cubrir al paciente hasta la altura de los hombros.

Realizar solo la mitra en la parte de los pies, con las tres piezas a la vez y sin remeter los laterales.

Realizar el embozo:

- Doblar el dobladillo superior de la colcha debajo de la manta.
- Doblar el dobladillo superior de la sábana sobre el borde de la colcha y la manta.
- El lado de la sábana que tiene el dobladillo debe estar en la parte inferior para que no entre en contacto con el paciente.

11.- Vestir almohadas y colocarlas en la cabecera:

- Sostener la funda en el centro de la costura terminal.
- Con la mano fuera de la funda volver la funda sobre la otra mano.
- Coger la almohada a través de la funda en el centro de un extremo de la almohada.
- Llevar la funda sobre la almohada.
- Ajustar la esquina de la almohada en la esquina de la funda que no tiene costura.
- Doblar el material sobrante del lado que tiene la costura debajo de la almohada.

12.- Aflojar la ropa superior de la cama para que los pies del paciente cuando entre en la cama no choquen con ellas.

Recordar que:

- La ropa sucia nunca debe tocar la limpia.
- La lencería no debe tocar el uniforme.

- No dejar la ropa sucia en el suelo. Dejarla en una bolsa o en el carro de la ropa sucia.
- No pasar la mano por la lencería.
- No sacudir la lencería al aire para evitar la transmisión de microorganismos.

13.- Dejar la cama abierta. Se puede hacer de tres formas diferentes:

a) En pico. Para ello se procede a doblar dos veces en el mismo sentido el extremo superior de la cama correspondiente al lado por donde va a entrar el paciente

b) En abanico o fuelle. Para abrirla de esta forma, tenemos que coger los dos



extremos del embozo y doblarlos hacia los pies de la cama para luego volver a subirlos hacia la mitad de la cama en sentido inverso





c) De arriba abajo. Se dobla toda la ropa de cama superior hasta los pies de esta (de tal forma que quede abierta) y, después, se vuelve el embozo hacia la cabecera



14.- Dejar todo ordenado, recogido y al alcance de la persona usuaria

15.- Retirarse los guantes y lavarse las manos.

Este video resume la técnica. Esta pensado para el ámbito hospitalaio por lo que además de la cama desocupada de un habitación estandar explica otros modelos http://www.youtube.com/watch?v=HuQnJszBNb0

TÉCNICA PARA HACER LA CAMA ABIERTA OCUPADA.

0.- Nos lavaremos las manos con agua y jabón y nos colocaremos guantes de un solo uso.

1.- En primer lugar prepararemos todo el material, es el mismo que para la cama desocupada: guantes desechables, carro de lencería sucia (también cuando finaliza el procedimiento hay que depositar los sacos en la tolva o en el carro de la lavandería) y carro de lencería limpia con las mismas condiciones que en el caso de la cama desocupada.

2.- Al igual que en el caso anterior, el carro (los carros, según sea nuestro caso) se deja en la puerta y se coge lo necesario.

3. La lencería se pone en una silla en sentido inverso al que se va a quedar colocado de la misma manera que en el caso de la cama desocupada

4.- Comentar a la persona usuaria lo que se va a hacer y en la medida de lo posible solicitar su colaboración. En este caso es importante preservar su intimidad e ir avisándole de los pasos a dar. Si es posible hacer la cama en horizontal.

5.- Comprobar que la cama está frenada si lleva ruedas y que la temperatura de la habitación es la adecuada, así mismo evitaremos en lo posible las corrientes de aire.

6.- Debemos proteger al paciente de posibles caídas, para lo cual es importante que esta técnica se realice entre dos personas o bien ayudarnos de las barandillas de cama aunque resulten incómodas, nunca hay que confiarse de que la persona usuaria puede sujetarse.

7.- Si no está contraindicado, colocaremos la cama en posición horizontal (paciente en decúbito supino).

8.- En primer lugar, debemos aflojar la ropa de la cama.

9.- Retirar la colcha y la manta, doblarlas como ya se ha explicado si se van a reutilizar y si están sucias se depositan en el carro o bolsa correspondiente.

10.- Dejar la sábana encimera cubriendo al paciente o colocar una toalla de baño por encima. No dejar nunca al paciente totalmente descubierto, aunque sepamos

que nadie nos ve o aunque creamos que no es consciente, es importante preservar su intimidad.

11.- Si es posible, se retira la almohada para cambiarle la funda y se coloca encima de una silla. Muchas personas usuarias no toleran estar sin almohada.

12.- Colocar al paciente en decúbito lateral, cercano a uno de los bordes de la cama, recordar que si realizamos solos la técnica debemos colocar las barandillas de seguridad.

13.- Enrollar la ropa sucia a retirar (entremetida, empapador y sábana bajera) desde el borde de la cama donde nos encontramos, hacia la espalda del paciente.

14.- Empezar a hacer la cama por el lado contrario al que se encuentra el paciente;

15.- Colocamos la sábana bajera limpia enrollándola hasta el centro de la cama. Se fija a la cabecera y a los pies y se hace el ángulo o mitra;

Colocar la entremetida y empapador, si se precisan, hasta la espalda de la misma forma que la sábana bajera y se fija a lo largo de la cama;



16.- Dar la vuelta al paciente de manera que se sitúe encima de la ropa limpia, en decúbito lateral, y se hace la otra mitad de la cama quitando primero la ropa sucia. Nuevamente si realizamos solos la técnica acordarnos de colocar las barandillas de seguridad antes de dejar al paciente en decúbito lateral.

17.- Estirar la sábana y la entremetida limpias evitando arrugas, remetiéndolas debajo del colchón y efectuando el ángulo o mitra de las dos esquinas restantes;

18.- Ayudar a colocar al paciente de nuevo en decúbito supino;

19.- Extender la sábana encimera limpia sobre el paciente y retirar la sucia o la toalla empleada para taparle.

20.- Después colocar el resto de la ropa (manta y colcha), efectuando el ángulo o mitra de las dos esquinas de los pies y remeter con holgura en los pies de la cama de forma que quede floja la ropa para que pueda moverse cómodamente y así evitar decúbitos y posturas inadecuadas (sobre todo el pie equino).

21.- Vestir la almohada con una funda limpia y colocarla por debajo de la cabeza del paciente.

22.- Dejar colocado al paciente en una postura cómoda y adecuada. Que tenga fácil acceso al timbre y a sus objetos personales;

23.- Recoger el material. La ropa sucia no deberá ser aireada ni colocada en el suelo, sino echada directamente en una bolsa de ropa sucia;

24.- Nos retiramos los guantes y nos lavamos las manos nuevamente.

En este video tienes un resumen de la técnica:
http://www.youtube.com/watch?v=75o2sJeTf3I&feature=player_embedded

3. Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones

Para empezar este apartado, es necesario explicar una serie de conceptos importantes que ayudarán a su comprensión.

Denominamos METABOLISMO al conjunto de procesos físicos y químicos que el organismo realiza y que generan y consumen energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la digestión y la eliminación de desechos (por la micción y la defecación), entre otros. Así, gracias al metabolismo, nuestro organismo transforma las sustancias que toma del exterior y las descompone y asimila (las transforma por medio de reacciones bioquímicas) para que puedan ser utilizadas por las células que, de esta forma, logran mantenerse con vida.

Llamamos METABOLISMO BASAL a la energía que necesita el organismo para mantener sus funciones vitales en estado de absoluto reposo. Esta energía se mide en cantidad de CALORÍAS.

Esta energía la obtenemos de una serie de sustancias incorporadas a través de los alimentos. Los ALIMENTOS son todas las sustancias o productos aptos para el consumo humano capaces de aportar las sustancias necesarias para la vida, no solo las energéticas, sino también las estructurales y las reguladoras.

Se clasifican los alimentos en 7 grupos asociándose según la función que realicen, reguladora (verde), estructural (rojo) o energética (amarillo). En la siguiente rueda[10] se exponen los grupos:



El 7 grupo (azul) lo constituye el agua junto al ejercicio físico. El agua merece un estudio aparte, se deben ingerir entre 1'5 y 2 litros, pero la cantidad varía en función de la alimentación y el estilo de vida. En el módulo 3 y en el apartado 2.2 Participación en la toma de constantes vitales, veremos qué es el balance hídrico y nos detenemos a explicar la importancia del agua.

La ALIMENTACIÓN es el proceso consciente y voluntario que el individuo realiza para conseguir, preparar e ingerir los alimentos.

La PIRÁMIDE DE ALIMENTOS básicos describe la calidad y cantidad de los alimentos diarios que necesitamos para obtener los nutrientes necesarios. Es una manera fácil de poder planificar un menú diario, asegurándonos de que es equilibrado y variado.

10 Promovida en España por el Programa de Educación en Alimentación y Nutrición (EDALNU) del Ministerio de Sanidad



Otro concepto relacionado íntimamente con el tema es la nutrición. La NUTRICIÓN se define como el conjunto de procesos involuntarios e inconscientes que el organismo realiza para incorporar, transformar y absorber las sustancias contenidas en los alimentos, las cuales son transportadas a los tejidos para ser utilizadas por éstos.

Las sustancias a las que hace referencia el párrafo anterior son las sustancias que integran los distintos alimentos, que el organismo incorpora a través de éstos y que son esenciales.

Se agrupan de la siguiente forma:

- Nutrientes energéticos: hidratos de carbono y las grasas. Evidentemente nos aportan sobre todo energía. Obtenidos de los alimentos representados en color rojo en la rueda.
- Nutrientes reguladores: sales minerales, las vitaminas. Se encargan se regular el conjunto de procesos físicos y químicos del metabolismo. Obtenidos de los alimentos representados en color verde en la rueda.
- Nutrientes estructurales: las proteínas. Los ladrillos con los que construimos nuestro cuerpo. Obtenidos de los alimentos representados en color amarillo en la rueda.

Otra manera de clasificarlos es en función de la cantidad de ese nutriente que nuestro organismo necesita y así tenemos:

a) Macronutrientes: proteínas, hidratos de carbono y las grasas. Se necesitan en gran cantidad.
b) Micronutrientes: sales minerales y las vitaminas. Se necesitan en pequeñas cantidades.

Puesto que la alimentación es un acto voluntario y consciente, es susceptible de ser influenciada por la educación, las costumbres sociales o la tendencia religiosa. La

nutrición, al ser una acción inconsciente e involuntaria, no es educable, sino que depende totalmente de la alimentación.

La trasformación de los alimentos en nutrientes se da en el aparato digestivo (apartado 3.2 de este módulo). Una vez formados pasan a la sangre que será quien los trasporte por todo el cuerpo para que sufran las reacciones metabólicas oportunas y puedan así realizar su función.

En las reacciones metabólicas se generan una serie de desechos, las toxinas, que debemos eliminar. Sobre todo serán nuestro el hígado y riñones (producen la orina) quienes se encarguen de ello y la orina los expulsará del organismo. Por supuesto que no es la única forma de liberar toxinas, ¿quién no ha oído comentar que el sudar libera toxinas?

No todo lo que ingerimos (alimentos) se convierte en nutriente y por lo tanto tampoco todo pasará a sangre. Lo que no pasa a sangre lo eliminamos a través de las heces.

3.1.- Evolución del metabolismo en el ciclo vital.

Uno de los cambios metabólicos más significativos es la intolerancia a la glucosa en personas que no han sido diabéticas. Esta alteración, muchos autores la atribuyen a una disminución en la producción de insulina por parte del páncreas. Además pueden estar implicados factores como los cambios dietéticos y la disminución del ejercicio físico, por lo que esta alteración puede acabar en una diabetes de tipo II.

Otro de los cambios importantes radica en la menor necesidad de energía, por que disminuye el metabolismo basal. En este punto hay menos acuerdo entre los diversos autores, ya que hay quien opina que no tiene porque disminuir. Otros justifican una posible disminución por diferentes motivos:

- Cambios en la composición corporal: es conocida la disminución de la masa magra, de forma que se reduce el gasto correspondiente a renovación proteica.
- Descenso de actividad de muchos tipos celulares, con lo que el gasto de energía disminuye.
- Descenso de la actividad física, con la consecuente disminución de gasto de energía.

3.2.- Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y endocrino. Patología relacionada.

SISTEMA DIGESTIVO

El sistema digestivo está constituido por un tubo de unos 10 -12 m de longitud y un conjunto de estructuras llamadas glándulas[11] anejas.

Las partes integrantes del tubo son:

- Cavidad oral
- Faringe
- Esófago
- Estómago
- Intestino delgado
- Intestino grueso

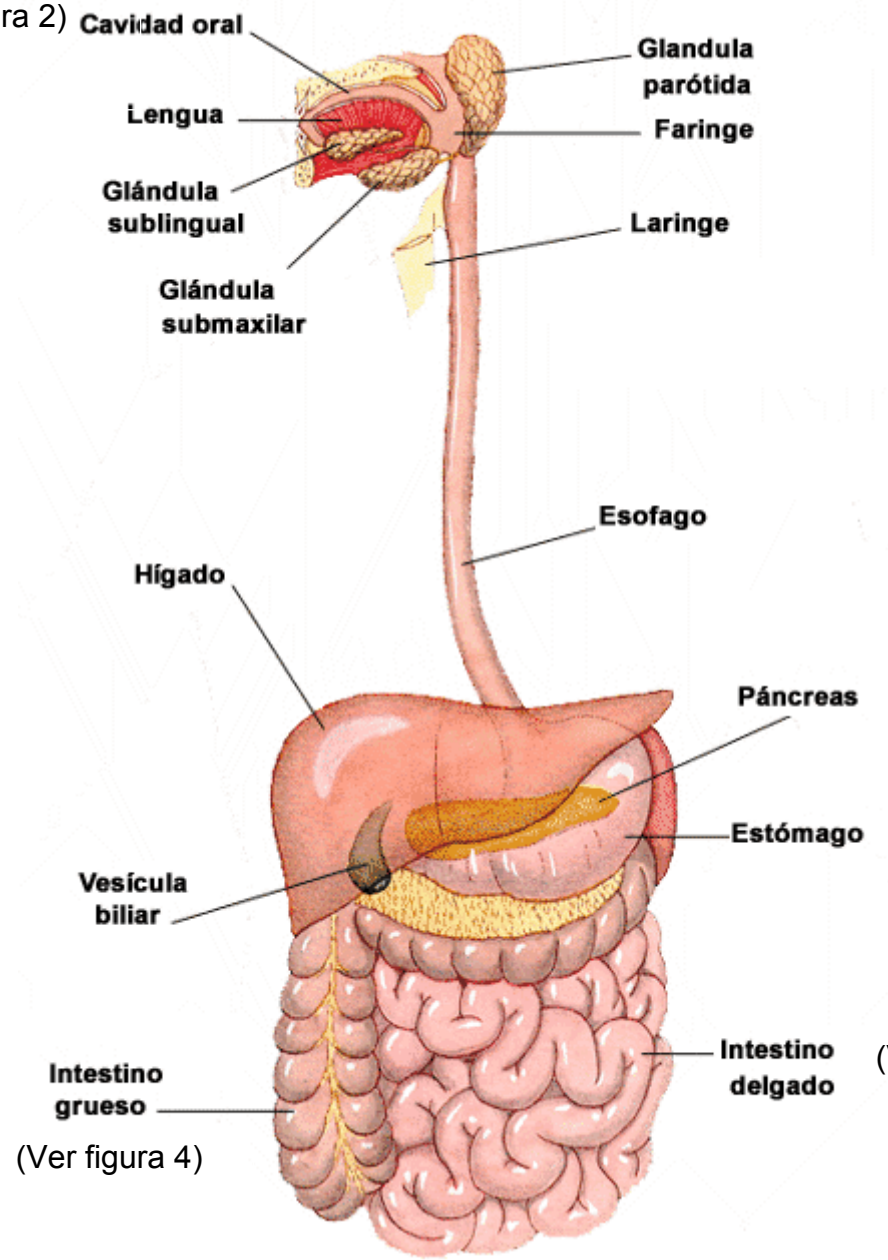
Las glándulas anejas son:

- el hígado,
- el páncreas y
- las glándulas salivales (parótidas, sublinguales y submaxilares; figura 1).
- La vesícula biliar solo almacena la bilis producida en el hígado, por eso aunque es una estructura anatómica anejada al tubo digestivo no es glándula.

En las imágenes se puede apreciar la forma y distribución de estas estructuras.

11 Cualquier órgano capaz de segregar sustancias necesarias para el organismo. Las hay exocrinas, como las digestivas y las hay endocrinas que producen hormonas.

(Ver figura 2)



(Ver figura 3)

(Ver figura 4)

Figura 1

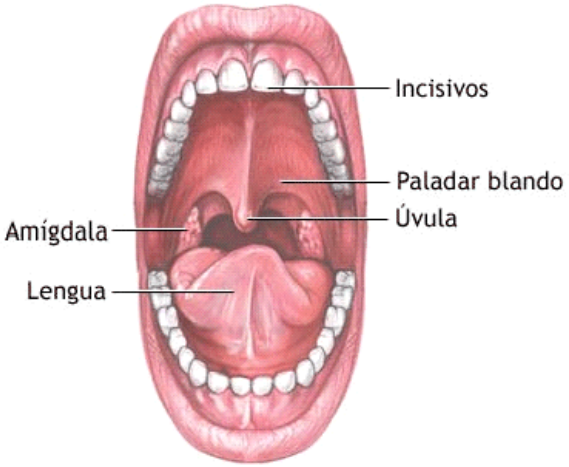


Figura 2

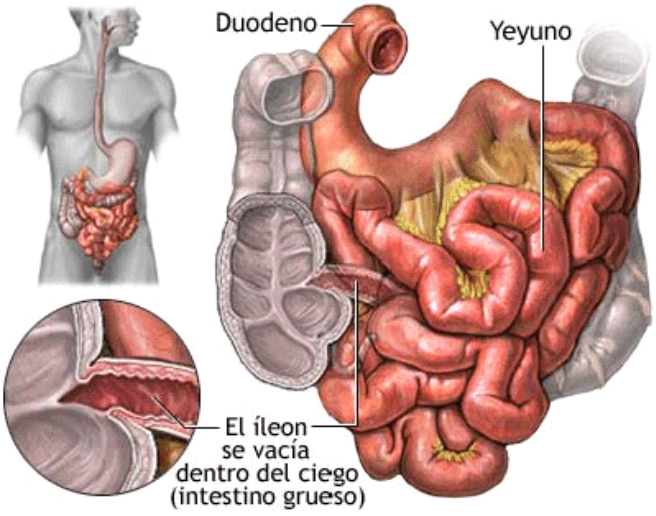


Figura 3

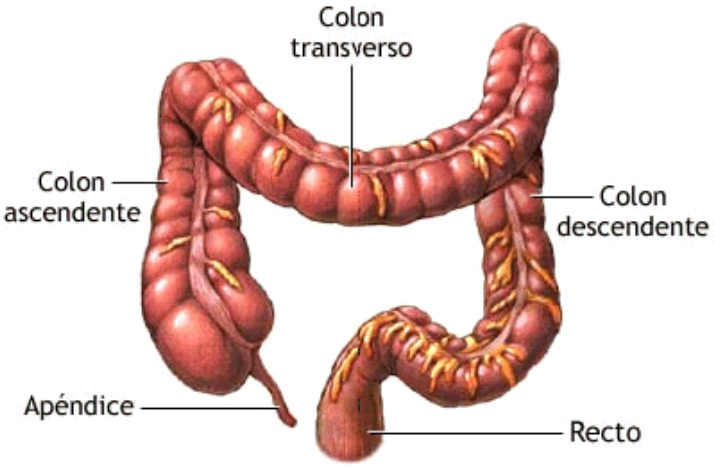


Figura 4

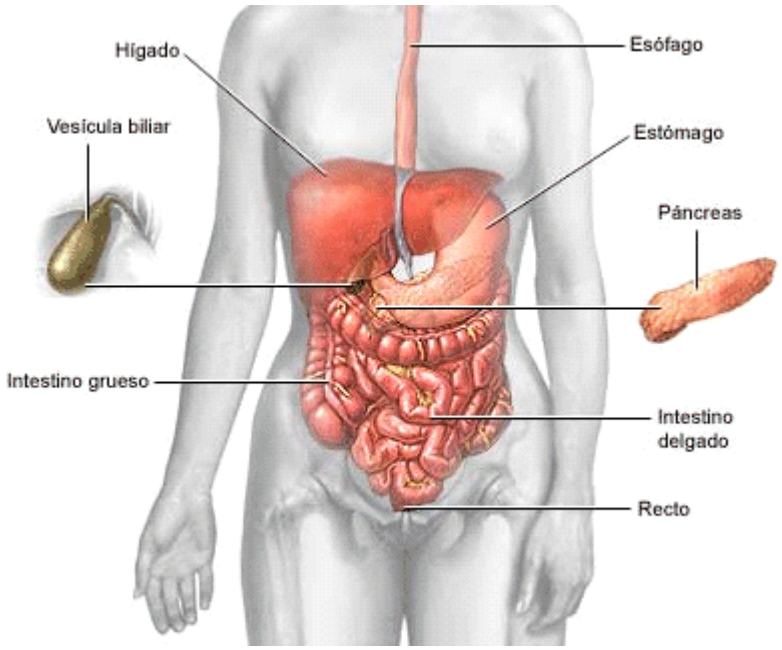


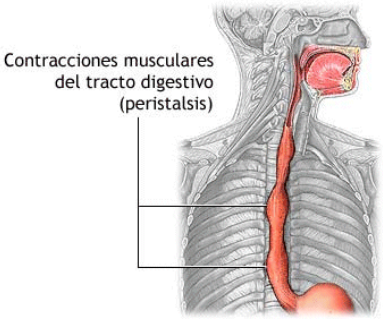
Figura 5

El tubo digestivo, en su trayecto a lo largo del tronco del cuerpo, discurre por delante de la columna vertebral. Comienza en la cara, desciende luego por el cuello, atraviesa las tres grandes cavidades del cuerpo: torácica, abdominal y pélvica.

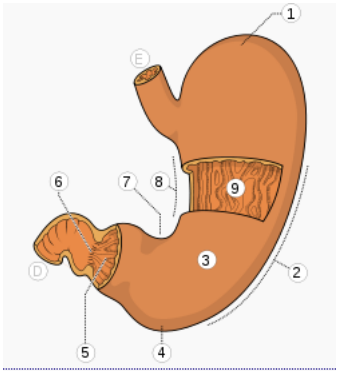
Longitudinalmente, el tubo digestivo se estructura de la siguiente forma:

1. La cavidad oral (figura 2) es una recubierta por una membrana mucosa. Constituye la entrada del tubo digestivo y es la encargada de recibir los alimentos que ingerimos y triturarlos. En ella podemos encontrar una serie de estructuras que le sirven de límite:
    a. Techo de la boca: formado por el paladar duro (huesos palatinos y maxilares se describirán en el apartado 3.1 del módulo 3) en su parte anterior o frontal y el paladar blando (velo del paladar), en su parte posterior, en el que distinguimos la úvula o campanilla
    b. Lengua: estructura muscular que constituye el suelo de la boca, donde se encuentran las papilas gustativas, en las que reside el sentido del gusto.
    c. Dientes: son 32 piezas de consistencia dura en el humano adulto. Están situadas en cavidades de los huesos maxilares y se encargan de triturar los alimentos. Para ampliar información acerca de la dentadura haz clic en este enlace: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/dientes.htm
    d. Glándulas salivares: consideradas una de las glándulas anejas, son las encargadas de secretar la saliva. (figura 1)
2. Faringe. Es una cavidad músculo-membranosa que se encuentra en la parte posterior de la boca y que comunica con la cavidad nasal, el oído medio, la laringe y el esófago. Como veréis en el apartado 2.1 del MF 3 (1018) es común al aparato respiratorio.

3. El esófago es un conducto o músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. De los incisivos al cardias (porción donde el esófago se continúa con el estómago) hay unos 40 cm. El esófago empieza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual. (es decir que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio). El esófago alcanza a medir 25 cm y tiene una estructura formada por dos capas de músculos, que permiten la contracción y relajación en sentido descendente del esófago. Estas ondas reciben el nombre de movimientos peristálticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el estómago. Es sólo una zona de paso del bolo alimenticio, y es la unión de distintos orificios, el bucal, el nasal, los oídos y la laringe.



4. El estómago es un órgano en el que se acumula comida. Varia de forma según el estado de repleción (cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica) en que se halla, habitualmente tiene forma de J. Consta de varias partes que son:.



1. Fundus
2. Curvatura mayor
3. Cuerpo
4. Antro pilórico
5. Píloro
6. Canal pilórico
7. Incisión angular
8. Curvatura menor
9. Pliegues de la mucosa gástrica

E. Esófago y D. Duodeno

En un individuo mide aproximadamente 25 cm del cardias al píloro y el diámetro transverso es de 12cm

En su interior encontramos principalmente dos tipos de células:

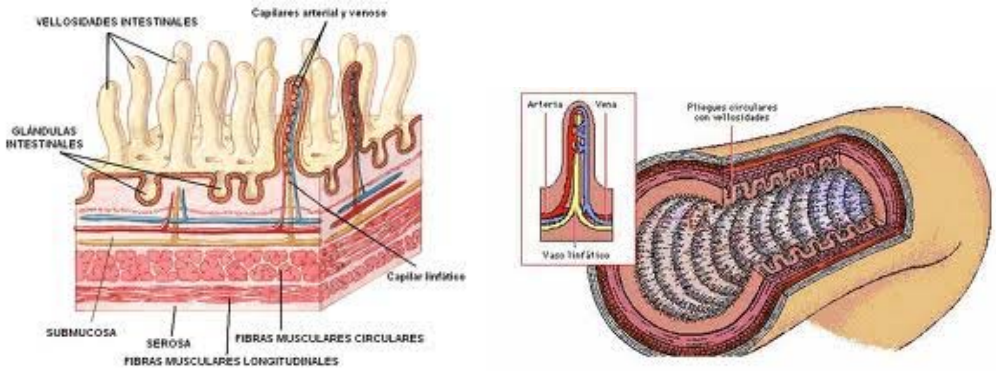
- las que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, una glucoproteína utilizada en la absorción de vitamina B_{12} en el intestino delgado
- las que secretan pepsinógeno, precursor enzimático que se activa con el ácido clorhídrico que participa en la ruptura de algún tipo de proteína en proteínas en más pequeñas.

Estos productos de secreción con agua forman el jugo gástrico. Con el jugo gástrico se realiza la digestión de proteínas, lípidos (o grasa) pero no ocurre la digestión de carbohidratos.

Otras funciones del estómago son la eliminación de la flora bacteriana que viene con los alimentos por acción del ácido clorhídrico.

El intestino delgado (ver figura 3) comienza en el duodeno (tras el píloro) y termina en la válvula ileocecal, por la que se une a la primera parte del intestino grueso. Su longitud es variable y su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal y mide de 6 a 7 metros de longitud.

En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya digeridos. El tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción.



El *duodeno*, que forma parte del intestino delgado, mide unos 25-30 cm de longitud; el intestino delgado consta de una parte próxima o yeyuno y una distal o íleon; el límite entre las dos porciones no es muy aparente. El duodeno se une al yeyuno después de los 30 cm a partir del píloro.

El *yeyuno-íleon* es una parte del intestino delgado que se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos: El primero que se origina en el duodeno y el segundo se limita con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lenta pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El límite entre el yeyuno y el íleon no es apreciable. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes y de las proteínas. Al intestino delgado, principalmente al duodeno, se vierten una diversidad de secreciones, como la bilis y el jugo pancreático.

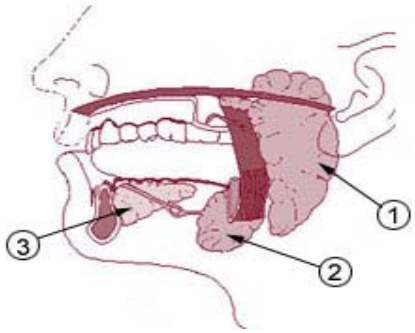
El intestino grueso (figura 4) se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego de donde sale el apéndice vermiforme y termina en el recto. Desde el ciego al recto describe una serie de curvas, formando un marco en cuyo centro están las asas del yeyuno íleon. Su

longitud es variable, entre 120 y 160 cm, y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha la región donde se une con el recto donde su diámetro no suele sobrepasar los 3 cm, mientras que el ciego es de 6 o 7 cm.

Tras el *ciego*, la del intestino grueso es denominada como *colon ascendente* con una longitud de 15 cm, para dar origen a la tercera porción que es el *colon transverso* con una longitud media de 50 cm, originándose una cuarta porción que es el *colon descendente* con 10 cm de longitud. Por último se diferencia el *colon sigmoideo*, *recto* y *ano*. El recto es la parte terminal del tubo digestivo.

Glándulas anejas (figura 5)

5. El páncreas es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno, es de origen mixto, segrega hormonas a la sangre para controlar los azúcares y jugo pancreático que se vierte al intestino a través del conducto pancreático, e interviene y facilita la digestión, sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos.
6. El hígado es la mayor víscera del cuerpo. Pesa 1500 gramos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellas la bilis es conducida al duodeno. Normalmente salen dos conductos: derecho e izquierdo, que confluyen entre sí formando un conducto único. El conducto hepático, recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar alojada en la cara visceral de hígado. De la reunión de los conductos cístico y el hepático se forma el colédoco, que desciende al duodeno, en la que desemboca junto con el conducto excretor del páncreas.
7. La vesícula biliar es un reservorio músculo membranoso puesto en derivación sobre las vías biliares principales. Contiene unos 50-60 cm³ de bilis. Es de forma ovalada o ligeramente piriforme y su diámetro mayor es de unos 8 a 10 cm. Su función es la de almacenar la bilis producida en el hígado.
8. Las glándulas salivales producen la saliva, la cual es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa, se produce 1,5 litro al día (aprox.), es una solución de proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono y electrólitos y contiene. células epiteliales descamadas y leucocitos. Las glándulas salivales grandes están representadas por 3 glándulas pares: las glándulas sublinguales: ubicadas en el tejido conectivo de la cavidad oral, glándulas parótidas y submandibular: ubicadas por fuera de la cavidad oral.



① Parótida ② Submaxilar ③ Sublingual

La FUNCIÓN principal del aparato digestivo consiste en la transformación de los alimentos que ingerimos en sustancias más simples fácilmente utilizables por el organismo.

El proceso se efectúa en las siguientes etapas:

1. Ingesta y trituración de los alimentos, se forma el bolo alimenticio. Los alimentos se trituran y lubrican con saliva para que discurran por el tubo digestivo con mayor facilidad. La saliva contiene unas enzimas que comienzan a degradar los hidratos de carbono que contienen los alimentos. Por eso se dice que en la boca comienza la digestión mecánica (trituración) pero que también se da la digestión química (transformación)
2. Transporte del bolo hasta el estómago por el esófago favorecido por el peristaltismo. El peristaltismo es un movimiento de los músculos de la pared del esófago que formando ondas empuja al bolo alimenticio hacia el estómago.
3. Digestión que es de dos tipos:
    a. La digestión mecánica (sobre todo en boca, pero también en el estómago por la contracción de las paredes)
    b. La digestión química que es quien produce la transformación en los nutrientes necesaria (un levísimo comienzo en la boca con la saliva, algo más en el estómago, sobre todo algún tipo de proteína y fundamental mente se va a dar en el intestino delgado, concretamente en el duodeno, por la acción de la bilis producida en el hígado, el jugo pancreático producido en el páncreas y el propio jugo intestinal.

    El jugo que sale del estómago se llama quimo y el que sale del duodeno se llama quilo.

4. Absorción que se da en dos fases:
    a. Absorción intestinal de los nutrientes que se da en el yeyuno-ileon. Consiste en el paso a sangre de los nutrientes obtenidos en el duodeno.
    b. Absorción de agua, consiste en la recuperación del agua que contienen el producto de la digestión (quilo) . Se da fundamentalmente en el colon del intestino grueso. Cuando se recupera el agua tenemos las heces ya formadas

5. Eliminación de las heces a través del ano previa acumulación en el recto.

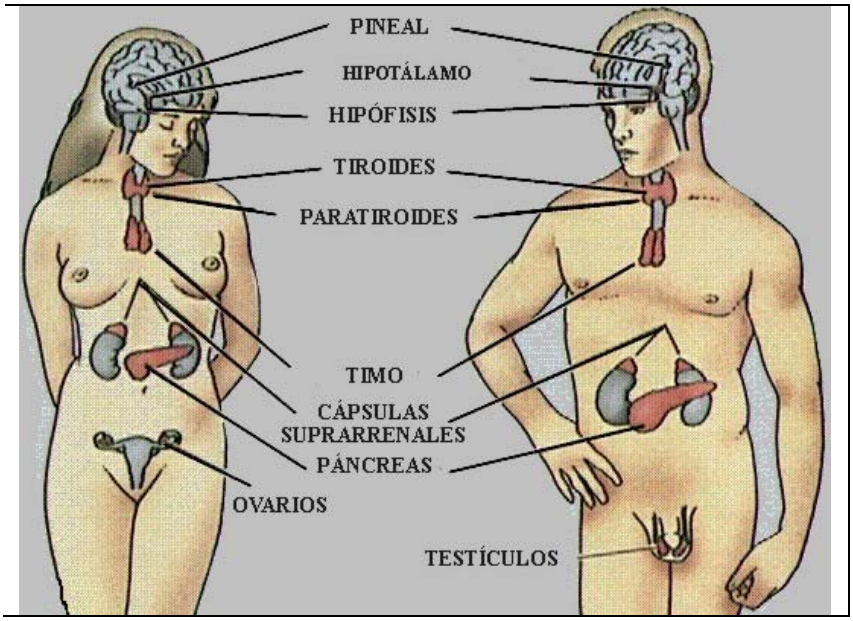
SISTEMA ENDOCRINO

El sistema endocrino está formado por glándulas que producen las hormonas; es toes, las glándulas de secreción interna porque vierten su producto de secreción a la sangre o glándulas endocrinas.

Como ya hemos comentado las glándulas endocrinas segregan las hormonas que son moléculas cuya función es la de actuar como mensajeros químicos. Se trasportan vía sanguínea a todo el organismo. Por ejemplo el páncreas se encarga de secretar la insulina a la sangre según son los niveles de azúcar en sangre para que se vaya almacenando.

Las glándulas endocrinas más importantes son:

1. La glándula pineal
2. La hipófisis
3. El hipotálamo
4. El tiroides
5. El paratiroides
6. El páncreas
7. Las suprarrenales
8. los ovarios en ♀
9. los testículos en ♂



Los órganos endocrinos también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones se liberan directamente en el torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exocrinas liberan sus secreciones sobre la superficie interna o externa de los tejidos cutáneos, por ejemplo el páncreas libera el jugo pancrático en el duodeno y cuando desempeña esa función se comporta como glándula exocrina, en cambio cuando libera insulina a sangre lo hace cono endocrino. Las glándulas endocrinas se pueden clasificar en tres grupos:

1. glándulas endocrinas, cuya función es la producción exclusiva de hormonas;
2. glándulas endo-exocrinas, que producen también otro tipo de secreciones además de hormonas (por ejemplo el páncreas)
3. tejidos no glandulares, como el tejido nervioso del sistema nervioso autónomo, que produce sustancias parecidas a las hormonas.

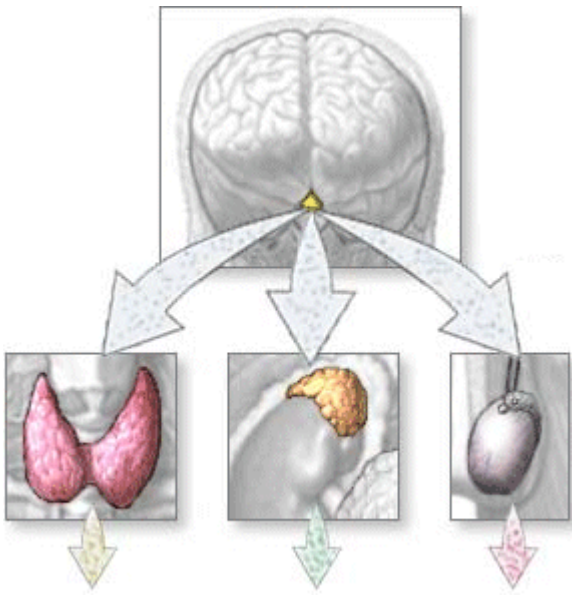
La glándula pineal

Está situada en la parte posterior del cerebro y tiene tan sólo cinco milímetros de diámetro.

Está íntimamente relacionada con los órganos sexuales. La glándula pineal secreta ciertas hormonas que regulan todo el progreso, evolución y desarrollo de los órganos sexuales, después de que estas hormonas han logrado su objetivo, entonces degenera en un tejido fibroso que ya no es capaz de secretar hormonas.

La hipófisis

La hipófisis, también llamada glándula pituitaria, está formada por tres lóbulos: el anterior, el intermedio y el posterior. Se localiza en la base del cerebro y se ha denominado la "glándula principal". Los lóbulos anterior y posterior de la hipófisis segregan hormonas diferentes.



El lóbulo anterior de la hipófisis libera varias hormonas que estimulan la función de otras glándulas endocrinas, por ejemplo, la adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropa o ACTH, que estimula la corteza suprarrenal; la hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina (TSH) que controla el tiroides; la hormona estimulante de los folículos o foliculoestimulante (FSH) y la hormona luteinizante (LH), que estimulan las glándulas sexuales; y la prolactina, que, al igual que otras hormonas especiales, influye en la producción de leche por las glándulas mamarias. La hipófisis anterior es fuente de producción de la hormona del crecimiento o somatotropina, que favorece el desarrollo de los tejidos del organismo, en particular la matriz ósea y el músculo, e influye sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. La hipófisis anterior también secreta una hormona denominada estimuladora de los melanocitos, que estimula la síntesis de melanina en las células pigmentadas o melanocitos. En la década de 1970, los científicos observaron que la hipófisis anterior también producía sustancias llamadas endorfinas, que son péptidos que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico para reducir la sensibilidad al dolor.

El hipotálamo

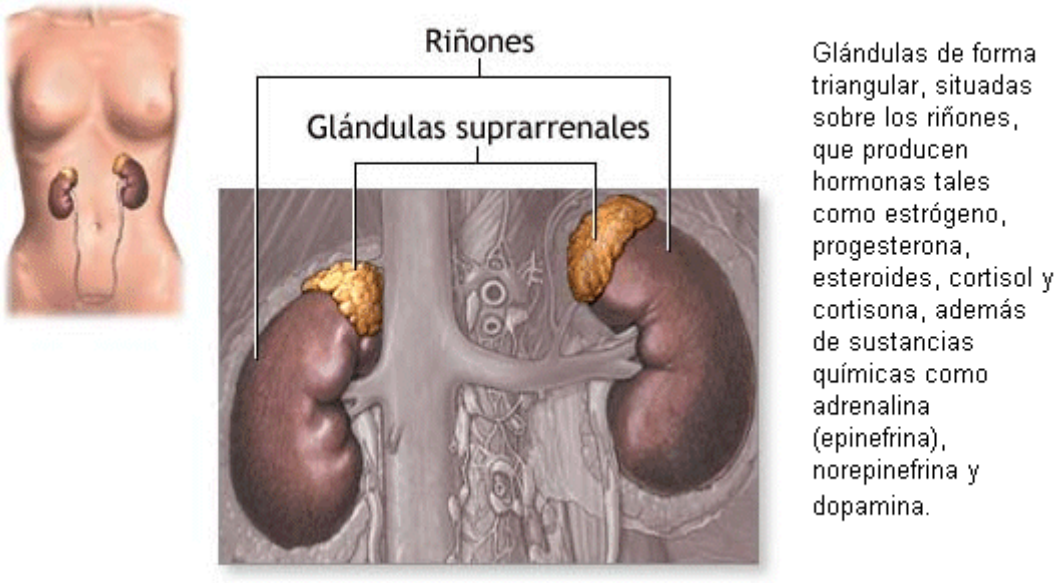
El hipotálamo es porción del cerebro de donde deriva la hipófisis y produce las hormonas "controladoras". Estas hormonas regulan procesos corporales tales como

el metabolismo y controlan la liberación de hormonas de glándulas como la tiroides, las suprarrenales y las gónadas (testículos u ovarios). También secreta una hormona antidincontinencia urinariarética (que controla la excreción de agua) denominada vasopresina. que controla la cantidad de agua excretada por los riñones e incrementa la presión sanguínea. El lóbulo posterior de la hipófisis también almacena una hormona fabricada por el hipotálamo llamada oxitocina. Esta hormona estimula las contracciones musculares, en especial del útero, y la excreción de leche por las glándulas mamarias.

La secreción de tres de las hormonas de la hipófisis anterior está sujeta a control hipotalámico por los factores liberadores: la secreción de tirotropina está estimulada por el factor liberador de tirotropina (TRF), y la de hormona luteinizante, por la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH). La dopamina elaborada por el hipotálamo suele inhibir la liberación de prolactina por la hipófisis anterior. Además, la liberación de la hormona de crecimiento se inhibe por la somatostatina, sintetizada también en el páncreas. Esto significa que el cerebro también funciona como una glándula.

Glándulas suprarrenales

Las dos glándulas se localizan sobre los riñones.



Glándulas de forma triangular, situadas sobre los riñones, que producen hormonas tales como estrógeno, progesterona, esteroides, cortisol y cortisona, además de sustancias químicas como adrenalina (epinefrina), norepinefrina y dopamina.

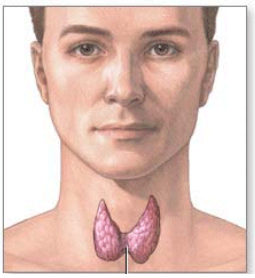
Cada glándula suprarrenal está formada por una zona interna denominada médula y una zona externa que recibe el nombre de corteza.

La médula suprarrenal produce adrenalina, llamada también epinefrina, y noradrenalina, que afecta a un gran número de funciones del organismo. Estas sustancias estimulan la actividad del corazón, aumentan la tensión arterial, y actúan

sobre la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos y la musculatura. La adrenalina eleva los niveles de glucosa en sangre (glucemia).

La corteza suprarrenal elabora un grupo de hormonas denominadas glucocorticoides y otras sustancias hormonales que regulan el equilibrio de agua y sal del organismo, influyen sobre la tensión arterial, actúan sobre el sistema linfático, influyen sobre los mecanismos del sistema inmunológico y regulan el metabolismo de los glúcidos y de las proteínas. Además, las glándulas suprarrenales también producen pequeñas cantidades de hormonas masculinas y femeninas.

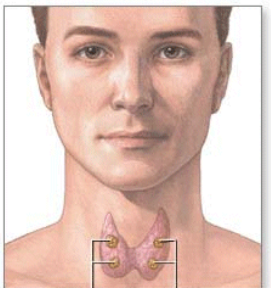
Tiroides



La tiroides es una glándula bilobulada situada en el cuello. Las hormonas tiroideas, la tiroxina y la triyodotironina aumentan el consumo de oxígeno y estimulan la tasa de actividad metabólica, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos del organismo y actúan sobre el estado de alerta físico y mental.

El tiroides también secreta una hormona denominada calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre e inhibe su reabsorción ósea.

Glándulas paratiroides



Se localizan en un área cercana o están inmersas en la glándula tiroides.

La hormona paratiroidea o parathormona regula los niveles sanguíneos de magnesio, calcio y fósforo en la sangre y huesos.

Ovarios

Los ovarios son los órganos femeninos de la reproducción, o gónadas femeninas. Son estructuras pares con forma de almendra situadas a ambos lados del útero. Los folículos ováricos producen óvulos, o huevos, y también segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos, necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales secundarias, como distribución de la grasa, amplitud de la pelvis, crecimiento de las mamas y vello púbico y axilar.

Con el envejecimiento progresivo de los ovarios, y el descenso de su producción de estrógenos, tiene lugar la menopausia. En este periodo la secreción de gonadotropinas aumenta como resultado de la ausencia de inhibición estrogénica.

Testículos

Las gónadas masculinas o testículos son cuerpos ovoideos pares que se encuentran suspendidos en el escroto. Las células de Leydig de los testículos producen una o más hormonas masculinas, denominadas andrógenos (por ejemplo la testosterona). La más importante es la testosterona, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, influye sobre el crecimiento de la próstata y vesículas seminales, y estimula la actividad secretora de estas estructuras. Los testículos también contienen células que producen gametos masculinos o espermatozoides.

En el hombre, con el paso destiempo, se da una reducción gradual de la secreción de andrógenos.

Páncreas

La mayor parte del páncreas está formado por tejido exocrino que libera enzima en el duodeno, pero como ya se ha citado, también hay actividad endocrina. Unas Las estructuras denominadas islotes de Langerhans, distribuidos por todo el tejido que secretan insulina y glucagón.

La insulina actúa sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas, aumentando la tasa de utilización de la glucosa y favoreciendo la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas. El glucagón aumenta de forma transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de glucosa procedente del hígado.

Metabolismo hormonal

La liberación de las hormonas depende de los niveles en sangre de otras hormonas y de ciertos productos metabólicos (por ejemplo los niveles de glucosa regulan la producción de insulina), así como de la estimulación nerviosa.

Se desconoce la forma en que las hormonas ejercen muchos de sus efectos metabólicos y morfológicos.

Aunque en apariencia no se consumen o se modifican en el proceso metabólico, las hormonas pueden ser destruidas en gran parte por degradación química. Los productos hormonales finales se excretan con rapidez y se encuentran en la orina en grandes cantidades, y también en las heces y el sudor.

PATOLOGIAS RELACINADAS CON EL APARATO DIGESTIVO:

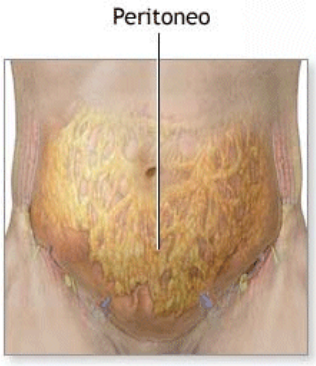
La apendicitis o inflamación del apéndice (ver figura 4).

Sus principales síntomas son: dolor en el lado derecho del vientre (bajo la línea que une el ombligo con la cadera), acompañado por vómitos, estreñimiento o, a veces, diarrea.

La prueba con la que puede sospechar que estamos ante un caso de apendicitis es la de presionar el área del apéndice. Al presionar deja de doler par volver a sentir dolor al soltar.

La peritonitis o inflamación del peritoneo

El peritoneo es la membrana que recubre la cavidad abdominal y por acción de bacterias patógenas provenientes de la ruptura del apéndice (apendicitis mal cuidada) o por la perforación del estómago se inflama



El estreñimiento o estitiquez es el retardo de la defecación.

La causa de esta demora puede ser patológica, como tumores o inflamaciones de la pared intestinal. Sus orígenes más frecuentes, hoy en día, están en el estrés, las dietas incorrectas, y muy especialmente la falta de fibra en la dieta y la vida sedentaria, así como la ingestión de medicamentos como antidepresivos y otros. Es muy habitual en pacientes dependientes. Se considera como uno de los síndromes geriátricos[12]

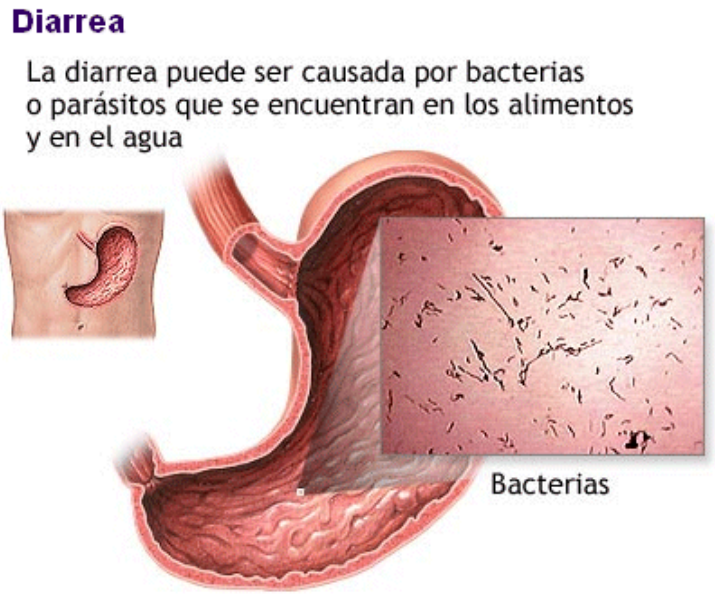
12 Los síndromes geriátricos son las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades en el adulto mayor



La adición de fibra en la dieta ayuda en los procesos de digestión y a prevenir el estreñimiento. Las verduras, las frutas frescas (especialmente las deshidratadas), el trigo entero, el salvado o los cereales de harina de avena son todos excelentes fuentes de fibra. Para recoger los beneficios de la fibra es importante ingerir una buena cantidad de líquidos.

La diarrea es la defecación frecuente de materias generalmente líquidas.

Se debe al paso anormalmente rápido de las heces por el intestino grueso, sin tener el tiempo suficiente para la absorción del agua. Las causas pueden ser bacterias patógenas, sustancias químicas, trastornos nerviosos, irritación provocada en las paredes intestinales por los alimentos no digeridos. Una diarrea prolongada puede traer como consecuencia una deshidratación.



La causa más común de la diarrea es una infección viral leve que desaparece por sí sola en pocos días y es usualmente conocida como "gripe estomacal". Otras dos causas comunes de la diarrea son la intoxicación por alimentos y la diarrea del viajero que se presentan por la ingestión de agua o de alimentos contaminados con organismos como las bacterias o los parásitos. Los medicamentos también pueden desencadenar diarrea, especialmente los antibióticos, los laxantes que contienen magnesio y la quimioterapia para el tratamiento del cáncer.

La úlcera gástrica y gastroduodenal son heridas que se producen en la mucosa del estómago, y frecuentemente en el duodeno, a raíz de un aumento de las

secreciones gástricas, estimuladas por tensiones nerviosas, bebidas alcohólicas, ajetreo de la vida moderna, comidas abundantes o condimentadas.

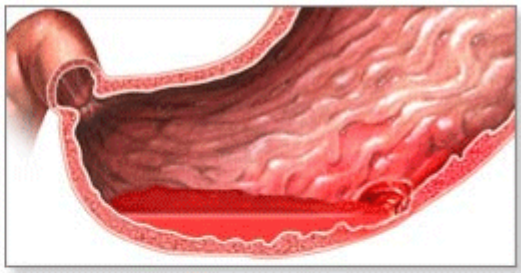


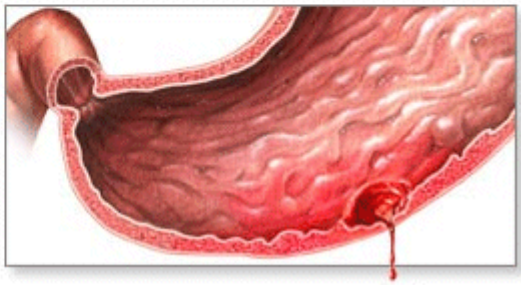
La úlcera es una lesión semejante a un cráter en la piel o en la membrana mucosa producida por una condición inflamatoria, infecciosa o maligna. Para evitar la irritación de una úlcera, una persona puede tratar de eliminar ciertas sustancias de su dieta como cafeína, alcohol, aspirina y el consumo de cigarrillos. Los pacientes pueden tomar ciertos medicamentos para suprimir el ácido estomacal que provoca la erosión del revestimiento del estómago. Se puede usar terapia endoscópica para detener el sangrado de la úlcera.

Emergencias por úlceras

Las ulceras pépticas pueden llevar a situaciones de emergencia. Los dolores abdominales fuertes con o sin evidencia de sangrado pueden ser indicio de una perforación de la úlcera en el estómago o duodeno. El vómito de una sustancia semejante a café o la presencia de heces negras pueden ser indicio de serios sangrados.







Las úlceras pépticas pueden llevar a que se presente sangrado, perforación u otras emergencias

El vómito es la expulsión brusca, por la boca, del contenido gástrico y, a veces, también del intestino. Los músculos abdominales se contraen con fuerza, elevando la presión abdominal, que empuja el contenido estomacal, lo impulsa hacia el esófago, y luego, es expulsado por la boca. El vómito prolongado puede provocar deshidratación grave, y otros problemas que requieren de asistencia médica.

Enfermedades entéricas

El tubo digestivo es el hábitat natural de muchas clases de bacterias, la mayoría de ellas inocuas en las condiciones ordinarias. Un número de habitantes intestinales

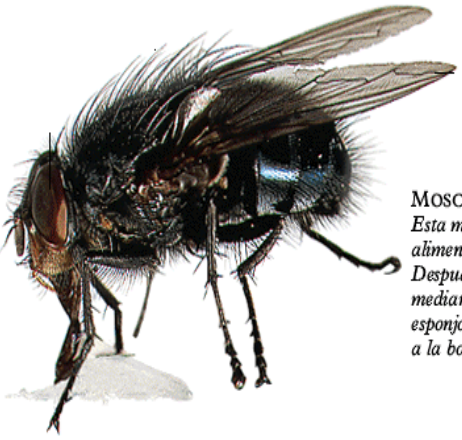
son, sin embargo, serios patógenos; entre ellos se incluyen los agentes causantes de las fiebres tifoidea y paratífica, la disentería, el cólera, las infecciones causadas por Salmonella, incorrectamente llamadas «intoxicación bacteriana por los alimentos»

Algunas de estas bacterias causan daños localmente, mientras que otras se dispersan desde los tejidos del intestino a otras partes del cuerpo. Todas, sin embargo, tienen dos importantes atributos en común:

- abandonan el cuerpo en la materia fecal excretada.
- deben entrar en el nuevo hospedador a través de la boca, para llegar de nuevo al intestino.

Las enfermedades entéricas, tal como son denominadas, se adquieren principalmente al tragar alimentos o bebidas contaminadas con heces.

Antes de la introducción de las condiciones sanitarias modernas, los abastecimientos de agua estaban constantemente sometidos a la contaminación directa a partir de las letrinas o de las alcantarillas defectuosas. Hoy, sin embargo, la contaminación por estos métodos se ha convertido en algo raro y se han hecho relativamente más importantes otros métodos de transmisión. La mosca doméstica común es un eficaz agente de transmisión porque visita indiscriminadamente tanto los alimentos como las heces.



MOSCA DOMÉSTICA
Esta mosca disuelve el alimento sólido con saliva. Después sorbe el líquido mediante una almohadilla esponjosa que tiene unida a la boca.

Además existen muchísimos más portadores sanos de patógenos entéricos que casos clínicos declarados, por lo que cualquiera que maneje alimentos es una fuente potencial de contaminación. Por lo tanto, solamente la más estricta higiene personal por parte de las personas que manipulan los alimentos puede evitar la dispersión de las enfermedades entéricas.

Muchos animales, incluidos el ganado y las aves de corral, pueden estar infectados naturalmente con miembros del género Salmonella, por lo que es posible quedar infectado al comer carne o huevos contaminados.

Intoxicación alimentaria se presenta al ingerir alimentos contaminados con otros organismos. Una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad (intoxicación) consecuente a la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos tanto sólidos como líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias orgánicas o inorgánicas perjudiciales para el organismo, tales como: venenos, toxinas, agentes biológicos patógenos, metales pesados, etc.

La mayoría de los casos de intoxicaciones alimentarias son en realidad toxoinfecciones alimentarias, provocadas por bacterias patógenas, virus, priones o parásitos,1 y/o sus productos metabólicos. Estas contaminaciones suelen surgir por manipulaciones, preparación o conservación inadecuadas de los alimentos. Unas buenas prácticas higiénicas antes, durante y tras la preparación de los alimentos pueden reducir las posibilidades de sufrir una intoxicación.

La vigilancia y control de los alimentos para asegurar que no producirán intoxicaciones alimentarias se denomina seguridad alimentaria.

Síndrome de malabsorción se llama cuando el intestino delgado no puede absorber los nutrientes de los alimentos.

Las causas de un síndrome de malabsorción incluyen: enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, síndrome del intestino corto, que es el resultado de una cirugía para extirpar una gran parte del intestino delgado, enfermedad de Whipple, una infección bacteriana rara, enfermedades genéticas, algunas medicinas …

Hepatitis

Es una enfermedad inflamatoria secundaria a infecciones víricas que afecta al hígado.

Dependiendo del virus que cause la enfermedad, cursa con distintos síntomas, como son ictericia (tinte amarillento de la piel), pérdida de apetito, fiebre, etc.

Cirrosis hepática:

En una enfermedad crónica del hígado caracterizada por la muerte progresiva de tejido hepático con la aparición de “cicatrices”, lo que dificulta la realización de sus funciones.

Su causa suele estar ligada al consumo excesivo de alcohol. Cursa con cansancio, pérdida de apetito, dolor abdominal, fiebre, ictericia y ascitis (acumulación de líquido en la cavidad abdominal).

Colecistitis

Es la inflamación de la vesícula biliar. Los síntomas pueden ser fiebre, vómitos, ictericia, etc.

La litiasis biliar

Es la formación de cálculos o piedras en la vesícula biliar. Cursa con dolor abdominal (más acusado tras la ingesta), náuseas y vómitos.

Para ampliar información sobre las patologías del aparato digestivo puedes consultar la siguiente página Web:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/digestivesystem.html

TRASTORNOS DE LA FUNCIÓN ENDOCRINA

Las alteraciones en la producción endocrina se pueden clasificar como de hiperfunción (exceso de actividad) o hipofunción (actividad insuficiente). La hiperfunción de una glándula puede estar causada por un tumor productor de hormonas que es benigno o, con menos frecuencia, maligno. La hipofunción puede deberse a defectos congénitos, cáncer, lesiones inflamatorias, degeneración, trastornos de la hipófisis que afectan a los órganos diana, traumatismos, o, en el caso de enfermedad tiroidea, déficit de yodo. La hipofunción puede ser también resultado de la extirpación quirúrgica de una glándula o de la destrucción por radioterapia.

Gigantismo o acromegalia

La hiperfunción de la hipófisis anterior con sobreproducción de hormona del crecimiento provoca en ocasiones gigantismo o acromegalia, o si se produce un exceso de producción de hormona estimulante de la corteza suprarrenal, puede resultar un grupo de síntomas conocidos como síndrome de Cushing que incluye hipertensión, debilidad, policitemia, estrías cutáneas purpúreas, y un tipo especial de obesidad.

Enanismo

Originado por una deficiencia de la hipófisis anterior (si aparece al principio de la vida), ausencia de desarrollo sexual, debilidad, y en algunas ocasiones desnutrición grave.

Alteraciones de la corteza suprarrenal

Se por una disminución de la actividad de la corteza suprarrenal origina la enfermedad de Addison, mientras que la actividad excesiva puede provocar el síndrome de Cushing u originar virilismo, aparición de caracteres sexuales secundarios masculinos en mujeres y niños.

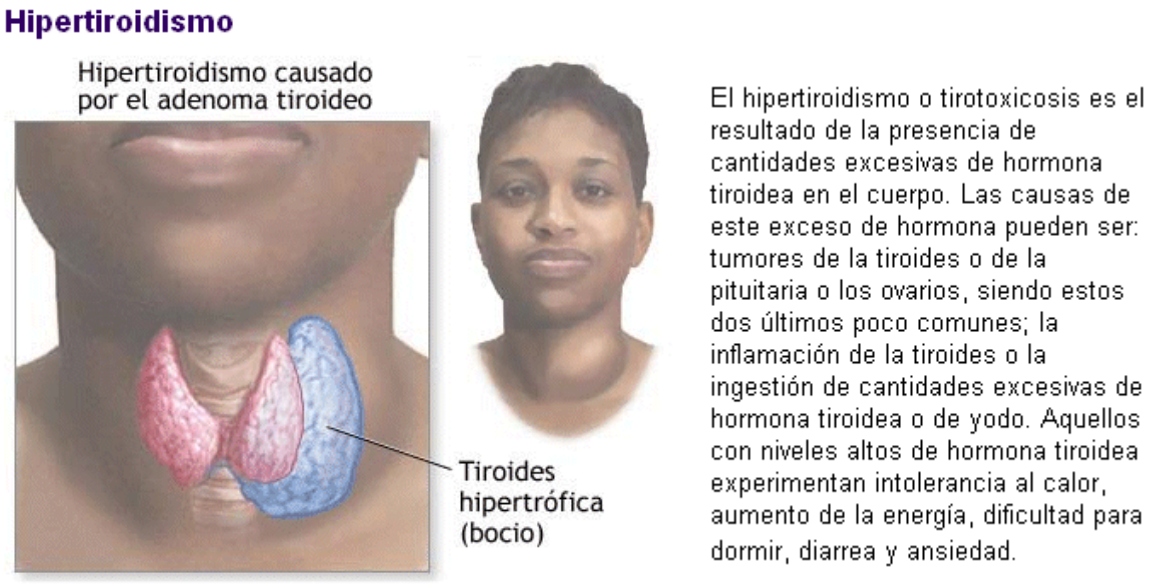
Alteraciones en las gónadas

Las alteraciones de la función de las gónadas afecta sobre todo al desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios.

Alteraciones tiroideas

Las deficiencias tiroideas producen cretinismo y enanismo en el lactante, y mixedema, caracterizado por rasgos toscos y disminución de las reacciones físicas y mentales, en el adulto.

La hiperfunción tiroidea (enfermedad de Graves, bocio tóxico) se caracteriza por abultamiento de los ojos, temblor y sudoración, aumento de la frecuencia del pulso, palpitaciones cardiacas e irritabilidad nerviosa.



Alteraciones pancreáticas

La más conocida es la diabetes mellitus, por un defecto en la producción de la hormona pancreática insulina, o puede ser consecuencia de una respuesta inadecuada del organismo.

Es una común enfermedad producida por una alteración del metabolismo de los carbohidratos en la que aparece una cantidad excesiva de azúcar (glucosa) en la sangre y en la orina (hiperglucemia e hipergluconuria). Afecta de un 1 a un 2% de la población, aunque en el 50% de los casos no se llega al diagnóstico.

Es una enfermedad multiorgánica ya que puede lesionar los ojos, riñones, el corazón y las extremidades. También puede producir alteraciones en el embarazo..

Se distinguen dos formas de diabetes mellitas:

- La tipo I, o diabetes mellitus insulino-dependiente (DMID), denominada también diabetes juvenil, afecta a niños y adolescentes, y se cree producida por un mecanismo autoinmune. Constituye de un 10 a un 15% de los casos y es de evolución rápida.

- La tipo II, o diabetes mellitus no-insulino-dependiente (DMNID), o diabetes del adulto, suele aparecer en personas mayores de 40 años y es de evolución lenta. Muchas veces no produce síntomas y el diagnóstico se realiza por la elevación de los niveles de glucosa en un análisis de sangre u orina.

Tratamiento

El tratamiento adecuado permite disminuir el número de complicaciones Con el tratamiento adecuado la mayoría de los diabéticos alcanzan niveles de glucosa en un rango próximo a la normalidad. Esto les permite llevar una vida normal y previene las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. Los diabéticos tipo I o los tipo II con escasa o nula producción de insulina, reciben tratamiento con insulina y modificaciones dietéticas. El paciente debe ingerir alimentos en pequeñas dosis a lo largo de todo el día para no sobrepasar la capacidad de metabolización de la insulina. Son preferibles los polisacáridos a los azúcares sencillos, debido a que los primeros deben ser divididos a azúcares más sencillos en el estómago, y por tanto el ascenso en el nivel de azúcar en la sangre se produce de manera más progresiva. La mayoría de los pacientes diabéticos tipo II tienen cierto sobrepeso; la base del tratamiento es la dieta, el ejercicio y la pérdida de peso (que disminuye la resistencia de los tejidos a la acción de la insulina). Si, a pesar de todo, persiste un nivel elevado de glucosa en la sangre, se puede añadir al tratamiento insulina. Los pacientes que no requieren insulina, o los que tienen problemas con las inyecciones de insulina, pueden utilizar medicamentos por vía oral para controlar su diabetes. En la actualidad, hay bombas de infusión de insulina que se introducen en el organismo y liberan la hormona a un ritmo predeterminado. Esto permite realizar un control más exhaustivo de los niveles de glucosa en la sangre; sin embargo, hay complicaciones asociadas a este tratamiento, como son la cetoacidosis y las infecciones en relación con la bomba de infusión.



Las personas con diabetes manejan constantemente sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre. Después de tomar la muestra de sangre y examinarla, se determina si los niveles de glucosa son bajos o altos. En caso de estar demasiado bajos, la persona ingiere carbohidratos y en caso de que la glucosa en la sangre esté demasiado alta, se administra la cantidad apropiada de insulina, como por ejemplo, a través de una bomba de insulina.

Para ampliar información sobre las alteraciones del sistema endocrino puedes consultar la siguiente página Web:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/endocrinediseases.html

3.3.- Comprobación de hojas de dietas

La dieta es un plan alimentario de un individuo. Se llama basal cuando no presenta o ninguna modificación y proporciona a la persona todos los componentes básicos de la nutrición. Lo contrario es una dieta terapéutica (apartado 3.3 de este módulo).

Toda dieta debe cumplir las cuatro leyes fundamentales de la alimentación:

1.- Ser completa: debe aportar todos los nutrientes que requiere el organismo en cantidad suficiente.
2.- Equilibrada: debe guardar una relación adecuada entre los diferentes nutrientes (hidratos de carbono - 50-55%; grasas - 30-35%; proteínas- 15%).
3.- Variada: debe contener tan diversos alimentos como sea posible (ver la pirámide alimentaria de la introducción inicial de este tercer apartado)
4.- Adecuada en calidad y cantidad: debe ser proporcionada según las características individuales (por ejemplo, edad, sexo, actividad física,…)

haciendo posible que quien la realiza se mantenga dentro de los límites de peso adecuados.

No esta demás que junto a lo ya citado resulte agradable, con productos naturales, e imaginación en la cocina.

Es importante que también sea regular, repartiendo los alimentos en cinco o seis comidas diarias, evitando las comidas copiosas

En la siguiente tabla se recogen alimentos recomendados para la persona mayor.

ALIMENTOS RECOMENDADOS Y CANTIDADES PARA UNA ADECUADA DIETA EN LA PERSONA MAYOR		
ALIMENTO	**PREPARACIÓN**	**APORTE**
Carnes.	- Preferiblemente, carnes magras cocinadas a la plancha. - También, en forma que sea fácil la masticación (albóndigas, filete ruso, tiras de pechuga de pollo,...)	Al menos, 3-4 veces por semana.
Pescados.	- Preferiblemente, cocidos, a la plancha o al vapor. - Se recomienda tener mucho cuidado con las espinas; si es necesario, se le ofrecerá el pescado ya sin ellas pues los accidentes con las mismas son muy frecuentes.	Entre 3 y 4 raciones a la semana.
Huevos.	- Preferiblemente, cocidos, pasados por agua y en tortilla (si es posible, se evitarán fritos).	Un máximo de tres a la semana. Si se trata sólo de la clara, se puede aumentar un poco esta cantidad.
Lácteos.	- Leche descremada, yogures descremados, queso fresco...	Entre 2 y 3 raciones diarias.
Frutas.	- Se consumirán maduras, bien lavadas y peladas. También, en forma de zumo, compota, macedonia...	Son recomendables 2-3 raciones diarias.
Legumbres.	- Si es preciso, se ofrecerán en forma de purés combinado con verduras.	Entre 2 y 3 veces a la semana.
Cereales y patatas.	- Pan, arroz y pasta: deben prepararse y presentarse siempre con la textura adecuada para facilitar su masticación.	
Verduras y hortalizas.	- Cocidas o al vapor. - En forma de purés o cremas solas o acompañadas de otros alimentos. - En ensaladas cortadas en pequeños trozos. Se procurará añadir zanahoria, tomate, remolacha, palmito y maíz. - Si no es posible suministrarlas así, se hará en forma de zumo fresco colado.	Dos veces al día.
Aceite.	- Se procurará que sea de oliva. - Se deben evitar las frituras. Si éstas se consumen, se deben dejar en reposo en papel absorbente tras sacarlas del aceite.	
Agua.		Se recomienda una ingesta de 20-45 ml/Kg de peso.
Bollería.		Se intentará que su consumo sea excepcional.
Alcohol.	- Si no existe contraindicación médica, se permitirá un poco de vino o cerveza diario. - Se evitarán licores de alta graduación.	

En todas las instituciones se recogen las diferentes dietas que ofrece la institución y que personas usuarias deben seguir una u otra dieta. Toda esta información se recoge en la HOJA DE DIETAS que como profesionales sociosanitarios debemos conocer y además tener en cuenta que:

- Todos los pacientes ingresados tendrán adjudicada una dieta diaria en relación a sus necesidades individuales, previa valoración facultativa.
- Cada bandeja de alimentación vendrá identificada con el nombre del paciente y el tipo de dieta que contiene.
- Antes de entregar la bandeja, deberemos comprobar los datos del usuario para evitar equivocaciones.
- Entregaremos en último lugar las bandejas de los pacientes dependientes que necesiten de nuestra ayuda para comer.
- Para facilitar la ingesta, colocaremos al paciente en la posición adecuada y prepararemos la habitación con todo el material necesario, poniéndolo al alcance del usuario.
- Confirmaremos que la temperatura de la comida es adecuada.
- Tras la ingesta, observaremos la cantidad de comida ingerida por el paciente y lo anotaremos en su hoja.
- Recogeremos las bandejas.
- Ayudaremos o realizaremos la higiene bucal, según el grado de dependencia del paciente.

Dietas y menús de instituciones sociosanitarias.

La dieta terapéutica es la modificación del tipo de alimentación habitual del individuo debido a un proceso patológico.

Las finalidades de una dieta terapéutica son una de las siguientes:

- Prevenir la aparición de síntomas de una determinada enfermedad
- Constituir el tratamiento de una enfermedad
- Eliminar la ingestión de algunos alimentos.

Los principales tipos de dietas utilizados en las instituciones sociosanitarias además de la basal son los siguientes:

DIETA ABSOLUTA: está prohibida la ingesta de líquidos y sólidos por vía oral, por prescripción facultativa.

DIETA LÍQUIDA: es una dieta compuesta por líquidos: agua, zumos, caldos…..Es una dieta insuficiente. Se suele utilizar por poco tiempo.

DIETA BLANDA: Se utiliza tras una dieta líquida. Es el paso previo a una dieta normal. Los alimentos que se utilizan en esta dieta suelen ser fáciles de digerir y suelen estar preparados de forma sencilla. Esta dieta debe ser equilibrada porque puede instaurarse durante mucho tiempo.

DIETA HIPOCALÓRICA: contiene menor cantidad de calorías que la dieta normal. Su objetivo es que el usuario utilice las reservas para perder peso.

DIETA HIPERCALÓRICA: persigue incrementar los depósitos y reservas en el organismo del ingresado. Está especialmente indicada en procesos de anorexia en los que existen desgastes excesivos de los depósitos orgánicos.

DIETA HIPOPROTEICA: está indicada para aquellos residentes que padezcan patología renal o insuficiencia hepática, pues el consumo de proteínas podría provocarles intoxicaciones y lesiones a distintos niveles.

DIETA HIPERPROTEICA: una dieta es rica en proteínas. Está indicada en pacientes desnutridos, personas con enfermedades crónicas, quemados….

DIETA POBRE EN POTASIO: en esta dieta se restringe total o parcialmente el consumo de sal, según la situación de la persona. Está indicada en usuarios con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, en casos de insuficiencia renal y en personas con edemas.

DIETA POBRE EN COLESTEROL: se reduce el consumo de alimentos que contienen colesterol. Está indicada para personas con niveles de colesterol en sangre elevados. En esta dieta se reduce el consumo de grasas.

DIETA ASTRINGENTE: se reducen o limitan los alimentos ricos en fibra, se utiliza en casos de diarrea.

DIETA LAXANTE: es una dieta rica en fibra (residuos). Está indicada en casos de estreñimiento crónico.

DIETA SIN AZÚCAR DE ABSORCIÓN RÁPIDA: está especialmente indicada para los usuarios diabéticos, que por déficit o ausencia de insulina no pueden gestionar adecuadamente los azúcares refinados.

Ejemplos de estas dietas a modo de menús los tenéis en la página Web:
http://www.residenciasolinatura.com/index.php/es/menu-del-dia.html

Menús en patologías especiales.

Como ya hemos citado en el apartado La dieta desempeña un papel muy importante en el tratamiento médico de muchas enfermedades.

Dependiendo de la patología del usuario, se le suministrarán o restringirán determinados alimentos, según éstos puedan mejorar o agravar su estado de salud.

Algunas de las dietas dirigidas a determinadas patologías no son más que la unión de varias de las estudiadas en el apartado anterior. A continuación, expondremos algunas de las indicadas en patologías más comunes:

DIETA PARA PACIENTES CARDIACOS O CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)

Toda dieta dirigida a pacientes cardiópatas (con infartos de miocardio e insuficiencias cardiacas) o que sufran de HTA se basará en la reducción de grasas saturadas (carnes grasas y productos lácteos), sustituyendo estos alimentos por pescados, carnes de ave y lácteos desnatados; disminuyendo el aporte de sodio para que no sobrepase los 250-500 mg/día; y asumiendo una dieta hipocalórica en paciente obeso.

DIETA PARA PACIENTES DIABÉTICOS

La dieta diabética debe estar basada en la reducción de los alimentos que proporcionan azúcares (dulces, bollería, pastas…) y las bebidas alcohólicas. El azúcar como condimento puede ser sustituido por edulcorantes. Es conveniente ajustar el horario de las comidas, sobre todo en pacientes insulinodependientes, realizando cinco comidas al día, no demasiado copiosas, acompañadas de ejercicio físico suave.

DIETA PARA PACIENTES CON ESTREÑIMIENTO

La disminución del peristaltismo debido a la edad, el encamamiento prolongado o determinadas patologías (hipotiroidismo, trastornos psicológicos o mentales) suelen ser las causas más frecuentes del estreñimiento. La dieta debe estar dirigida a la ingesta de alimentos poco digeribles que dejen abundantes residuos; es decir, los ricos en fibra, como verduras, frutas, legumbres con su piel, productos integrales,… junto con un consumo elevado de líquidos.

DIETA PARA PACIENTES CON VÓMITOS O DIARREA

Los vómitos y la diarrea pueden ser síntomas de diversas patologías gastrointestinales (infecciones intestinales, síndromes de mala absorción o pacientes postquirúrgicos). La dieta comenzará con una ingesta estricta de líquidos (suero oral, caldos, zumos, infusiones,…) para pasar a una dieta blanda (sopa de arroz, puré de patatas y zanahoria, pescados o carnes de ave cocidas o a la plancha) tras la desaparición de los vómitos. Quedan excluidos alimentos como la leche y sus derivados, las frutas y verduras crudas, los dulces, el chocolate, etc.

3.4.- Alimentación por vía oral:

En las instituciones sanitarias es probable que nos encontremos en nuestra práctica diaria con personas en las que el grado de dependencia varía considerablemente.

Algunos serán independientes, a los que solo debemos vigilar. Otros necesitarán de ayuda, bien humana o en algunos casos bastará con alguna ayuda técnica. Los habrá que son incapaces por sí mismos de ingerir alimentos por vía oral o bucal, estos requerirán de una ayuda total por nuestra parte o contarán con dispositivos

para la alimentación por patologías que impidan el acto voluntario de la masticación, el reflejo de la deglución o enfermedades neurológicas/mentales avanzadas.

Así, y dependiendo del caso, la alimentación del paciente se podrá llevar a cabo por tres vías diferentes:

- Alimentación por vía oral: a través de la cavidad bucal.
- Alimentación enteral: por vía digestiva, a través de distintos dispositivos de ayuda, como la sonda nasogástrica (SNG) o la sonda de gastrostomía.
- Alimentación parenteral: a través de un catéter endovenoso (por vía intravenosa) mediante una alimentación preparada exclusivamente para esta vía

Independientemente del sistema de alimentación, el profesional sociosanitario deberá CONSEJOS PARA ALIMENTAR A UNA PERSONA DEPENDIENTE:

a) Colocar a la persona en posición de Fowler (semisentado) si está encamado, o bien sentado.
b) Preparar los alimentos que se van a consumir, adecuando estos a la capacidad de masticación y deglución de la persona: enteros, troceados, triturados, etc. Procurar no mezclar alimentos sólidos y líquidos en personas con problemas de deglución.
c) La presentación del plato y el adecuado mantenimiento del calor, en los platos calientes, lo hacen más apetitosos y favorecen su ingesta.
d) Las comidas serán lentas, evitando que la persona se atragante o se canse. Se fomentará la independencia en la persona, para la alimentación.
e) Respetar las preferencias sobre los diferentes alimentos de la persona, en la medida de lo posible, asegurando siempre una alimentación sana.
f) Crear un ambiente agradable durante la alimentación de la persona: temperatura ambiental óptima, diálogo amistoso con la persona, etc.
g) Mostrar paciencia, evitando que nuestras prisas transmitan agobio a la persona

Procedimiento de ALIMENTACIÓN ORAL En USUARIO INDEPENDIENTE o PARCIALMENTE DEPENDIENTE

En la institución este tipo de pacientes come en el comedor común. Es importante que el ambiente sea agradable y que la persona usuaria disponga de todo lo necesario.

El procedimiento es el siguiente:

- Hay que comprobar que la persona usuaria se ha lavado las manos y por su puesto el profesional sociosanitario también.
- Comprobar que la persona usuaria está en una posición adecuada
- Comprobar que la dieta es la adecuada y entregar la bandeja al paciente.
- Verificar que la temperatura de la comida es la adecuada o avisar al paciente para que lo haga.

- Colocar el material necesario cerca del paciente y ayudarlo en lo que precise.
- Cuando finalice retirar la bandeja y comprobar la cantidad que ha ingerido.
- Ayudar al paciente en la realización de la higiene bucal si es necesario

Es muy importante recordar que la comida es sin duda un acto social y de costumbres.

Como profesionales, deberemos fomentar el autocuidado y la relación social entre pacientes durante las comidas, ya que ello mejorará su estado de ánimo y aumentará su apetito favoreciendo, además de la necesidad básica de la alimentación, otras como la comunicación y el ocio.

Debemos también tener en cuenta que los cambios que queramos introducir en la dieta deben hacerse de forma gradual y con el consentimiento del paciente, y sólo tras valorar sus hábitos y gustos dietéticos, sin olvidar aspectos como la dentición, cultura, grado socio-económico, etc.

Procedimiento de ALIMENTACIÓN ORAL EN USUARIO DEPENDIENTE

Los primero s pasos son iguales y normalmente también comen en el comedor, se sigue el siguiente procedimiento:

- Hay que comprobar que la persona usuaria se ha lavado las manos y por su puesto el profesional sociosanitario también.
- Comprobar que la persona usuaria está en una posición adecuada
- Comprobar que la dieta es la adecuada y entregar la bandeja al paciente.
- Colocar una servilleta o toalla bajo el mentón del paciente para evitar que se manche.
- Sentarse junto al él e ir ayudándole en todo lo necesario: cortar los alimentos, ayudarle a utilizar los cubiertos o darle la comida.
- Colocar nuestra mano bajo la almohada para elevar ligeramente la cabeza del paciente si fuese necesario y acercarle el vaso o la taza a la boca con cuidado. Podremos hacer uso de pajitas que faciliten la ingesta.
- Administrar los alimentos sólidos en pequeñas cantidades, asegurándonos que el paciente haya terminado de tragar para continuar.
- Recordar administrarle agua al paciente durante la comida.
- Retirar la bandeja una vez que el paciente haya acabado.
- Realizar la higiene bucal al paciente y colocarlo en posición cómoda.

Hay ocasiones que por problemas de deglución habrá que suministrarle el alimento con jeringa directamente en el fondo de la boca.

Cuando somos nosotros quienes le damos el alimento, cuidar que este a la temperatura idónea y que se respetan sus ritmos de deglución.

Es importante en personas usuarias con disminución del nivel de consciencia, extremar las precauciones debido al riesgo de aspiración al bronquio o broncoaspiración.

Para evitar la broncoaspiración durante la alimentación oral en pacientes con problemas neurológicos, de semiinconsciencia o deglutorios, debemos tener en cuenta los siguientes consejos:

- Preguntar al paciente si presenta dificultades para tragar.
- Evitar la ingesta de líquidos. Utilizar espesantes o gelatinas, o aconsejar el cambio de dieta a una de consistencia blanda.
- Ofrecer alimentos blandos en pequeñas cantidades, asegurándonos que ha tragado antes de ofrecer alimentos de nuevo. Inspeccionar la boca en caso necesario.
- Si el paciente padece alguna hemiplejia o hemiparesia, explicarle que debe masticar con el lado no afectado.
- Valorar la aparición de signos de dificultad como disnea (dificultad para respirar), tos o sialorrea (aumento de salivación).
- Tras la ingesta, mantener al paciente incorporado en posición Fowler durante un espacio de tiempo para evitar el reflujo

El profesional sociosanitario siempre comprobará cuidadosamente la temperatura de los alimentos antes de acercarlos al paciente. Si debemos administrarle sopas, caldos o infusiones, debemos prestar aún mayor atención a la temperatura.

Ayudas técnicas para la ingesta.

En la ALIMENTACIÓN ORAL uno de los mayores problemas que presentan las personas dependientes es la disfagia[13] y la deshidratación, para lo que vienen muy bien el uso de espesantes.

Los espesantes que se utilizan habitualmente son productos a base de almidones modificados. También existen productos a base de gelatinas, pero su uso es menos frecuente.

Dentro del grupo de almidones modificados, encontramos los espesantes neutros (sin sabor) y los espesantes no neutros (que aportan sabor al líquido o alimento al cual se añaden).

Los espesantes neutros (Resource Espesante, Nutilis, Vegenat-med Espesante, Espesante NM), son los que se usan con más frecuencia y son los únicos financiados por el Sistema Nacional de Salud.

13 dificultad en la deglución

Los espesantes no neutros (con sabor) no están financiados por el Sistema Nacional de Salud y pueden adquirirse en cualquier farmacia sin necesidad de receta.

Si necesitas ampliar información sobre las necesidades nutricionales de la tercera edad consulta el siguiente documento:
http://www.nestlenutrition.es/archivos/areas/Man_hoyd.pdf

Existen dificultades motoras que también pueden condicionar que el momento de la comida resulte estresante. Para evitar esto existen recursos técnicos que facilitan la ingesta. Algunos de ellos los citamos a continuación, pero a los cubiertos, platos y vasos les dedicaremos un apartado aparte.

Antideslizantes

Alfombrillas de material plástico disponible en varios tamaños, colores y formas que se colocan bajo el plato e impiden que éste se mueva al empujar la comida con los cubiertos. Facilita la actividad a aquellas personas que la han de llevar a cabo con una sola mano y a las que padecen problemas de incoordinación de movimientos o temblor. También pueden ser útiles para otras actividades como escribir, juegos de mesa o manualidades.



Soportes

- Para servir líquidos:

Consta de una base fija y una plataforma basculante en la que se encaja y se sujeta mediante una cinta la jarra, la tetera o la botella. Permite servir sin necesidad de aguantar peso y facilita el uso de ese tipo de utensilios a las personas con poca fuerza y/o poca destreza.

Existen otros modelos que combinan una base fija con una plataforma antideslizante e inclinable que tiene dos tacos de madera que actúan como tope y ayudan en la sujeción de la jarra, tetera, botella o tetrabrik.

- Para el tetrabrik

En un dispositivo de plástico en el que se encaja el tetrabrik. Sirve para que, personas con dificultades manipulativas y/o problemas sensitivos, puedan hacer uso de este tipo de recipientes sin derramar su contenido por ejercer demasiada presión sobre el cartón.





Manipulación de alimentos

- Plancha para cortar y untar

Pequeña bandeja de plástico con apoyos antideslizantes que la fija a la superficie en la que trabajamos. Tiene además dos topes en una de las esquinas para impedir que el alimento resbale fuera de la bandeja.

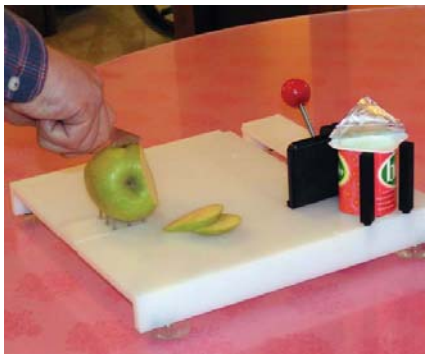
Es útil para todas aquellas personas que no pueden utilizar las dos manos y su función es suplir a la mano que debería sujetar.

- Tabla para cortar

Existen muchas tablas que sujetan los alimentos y facilitan así las acciones de cortar, pelar o trocear.

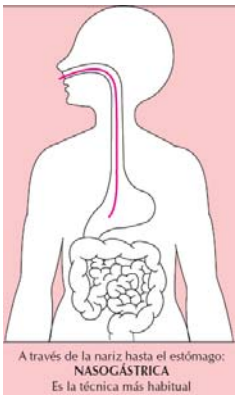
Son útiles para las personas que realizan la actividad con una sola mano. Pueden ser de distintos materiales y tamaños. Todas ellas constan de un sistema antideslizante de sujeción de la tabla a la superficie en la que se trabaja (generalmente ventosas) y están provistas de un sistema de clavos en el que se fija el alimento que ha de cortar.

Algunas de estas tablas están provistas de sistemas de sujeción para abrir envases y de topes en una de las esquinas por lo que se pueden utilizar también para untar alimentos

ALIMENTACIÓN ENTERAL

La nutrición enteral consiste en la administración de los alimentos necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado por vía digestiva, ya que el paciente no es capaz de ingerirlos por vía oral debido a alguna patología (oncológica o cancerígena, neurológica, o gastrointestinal). Para su administración es necesario el uso de dispositivos de ayuda llamados sondas, con cuya utilización se suprimen las etapas bucal y esofágica de la digestión.



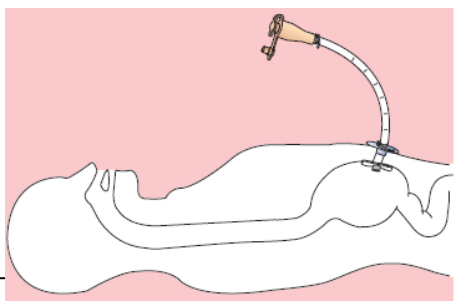
Existen distintos dispositivos para la administración de la nutrición enteral. Los factores que deben tenerse en cuenta para su elección son: la duración estimada del tratamiento, la patología del enfermo y sus preferencias.

Si se prevé que el período de tiempo que se administrara la administración enteral no va a ser muy prolongado, está indicada la utilización de sondas nasogástricas (SNG).

Las sondas son tubos de diámetro pequeño y material plástico más o menos flexible que permiten el paso de la nutrición enteral sin dificultad.

Estos dispositivos son colocados por la enfermera a través de uno de los orificios nasales y llegan hasta el estómago pasando por el esófago. Quedan fijados mediante esparadrapo a la nariz y pueden permanecer un tiempo prolongado (desde 15 días a 6 meses, dependiendo del material).

Si se considera que la duración de la nutrición enteral va a ser muy prolongada, se puede optar por colocar sondas o catéteres de gastrostomía. La colocación de dicha sonda es un procedimiento quirúrgico que se realiza bajo anestesia. Se coloca un tubo corto, flexible y de poco diámetro que



posee un globo al final que, al llenarlo de agua, sirve de anclaje, a través de una incisión hasta llegar directamente al estómago. La forma de colocación más habitual hoy en día es a través de endoscopio y la sonda se llama PEG.

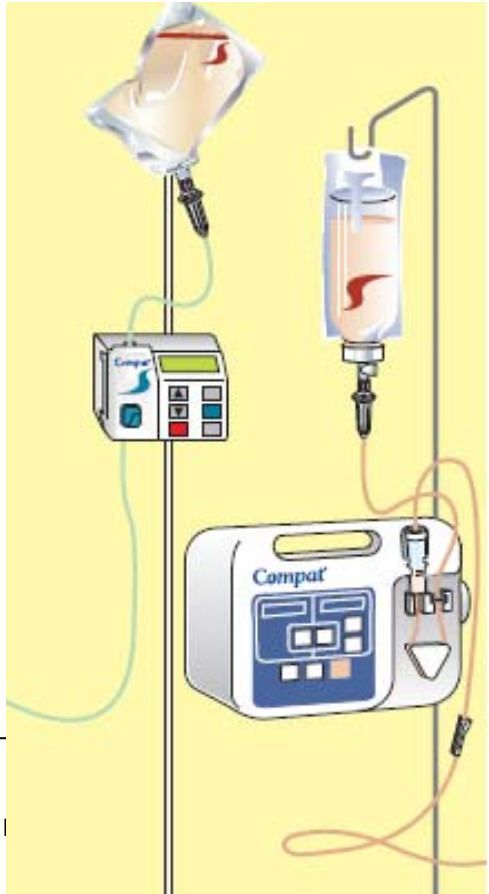
Una vez que el facultativo decide aportar al paciente los nutrientes necesarios por vía enteral, es necesario seleccionar la dieta basada en las necesidades fisiológicas, la capacidad digestiva y la estimación de los requerimientos nutricionales del paciente. Pueden administrarse desde alimentos triturados hasta preparados comerciales líquidos o en polvo.

Los cuatro métodos más empleados para la administración de la alimentación enteral son:

1) La infusión continua a través de bomba infusora, que es el aparato que regula la cantidad y velocidad de líquido a infundir. Tiene como desventaja que el paciente está casi todo el día conectado a la nutrición enteral.

Procedimiento a seguir:

- Preparar todo el material necesario y dejarl al alcance de la mano. El material a preparar es:
  - Guantes de un solo uso
  - Tapón de SNG.
  - Un vaso con agua.
  - Toalla.
  - Servilletas.
  - Jeringa de 50 cc.
  - Bomba infusora.
  - Sistema de bomba infusora.
  - Alimentación (preparado comercial según prescripción médica).
- Lavarse las manos y colocarse los guantes.
- Informar a la persona usuaria del procedimiento que vamos a realizar.
- Colocar al paciente sentado o en posición Fowler.
- Comprobar la correcta colocación de la sonda (SNG y de gastrostomía).
- Retirar el tapón de la sonda.
- Aspirar con la jeringa el contenido gástrico residual que pueda existir en el estómago, observando la cantidad y las características del mismo.





- Purgar el sistema de alimentación con la nutrición enteral y colocarlo en la bomba infusora.
- Conectar el sistema a la sonda a través de las conexiones en forma de cono.
- Seleccionar el ritmo de infusión en la bomba y comenzar la administración.
- Evitar la entrada de aire al estómago durante la administración.
- Limpiar la sonda con 30-50 cc. de agua al terminar la administración, pinzar la sonda con los dedos y colocar el tapón.
- Proceder a la higiene bucal.
- Recoger el material y reorganizar la habitación.
- Mantener al paciente en posición Fowler hasta 1h después de la administración para evitar reflujos de contenido gástrico.
- Proceder a la higiene bucal.
- Recoger el material y reorganizar la habitación de la persona usuaria si la ingesta se hubiera dado en ella.
- Recoger todo y dejara la persona usuaria cómoda
- Retirar los guantes y nos lavarse las manos
- al salir despedirnos de la persona usuaria
- Registrar en la historia de la persona usuaria las observaciones pertinentes.

2) La infusión intermitente, también a través de bomba infusora. Es útil en muchos casos. Se basa en la infusión a una velocidad mayor durante períodos de unos 30 minutos, administrando 4 ó 5 tomas al día.

El procedimiento es igual que en el caso anterior pero habrá que ajustar la cantidad ingerida y la velocidad de perfusión

3) Administración por bolos a través de jeringa y de forma manual. La alimentación puede ser una dieta líquida o triturada y suele coincidir con las horas de alimentación del centro.

El procedimiento es el siguiente:

- Preparar todo el material necesario y dejarlo a mano. Los materiales necesarios son guantes de un solo uso, no estériles, tapón de SNG, un vaso con agua, toalla, servilletas, jeringa de 50 cc y alimentación (triturada o preparado comercial).

- Lavarse las manos y colocarse los guantes.
- Informar a la persona usuaria del procedimiento que vamos a realizar.
- Colocar a la persona usuaria sentada o en posición Fowler.
- Comprobar la correcta colocación de la sonda (SNG y de gastrostomía) de la siguiente manera:
    - Retirar el tapón de la sonda, teniendo en cuenta que en la sonda de gastrostomía el tapón suele estar integrado; mientras que en la SNG, el tapón es independiente.
    - Aspirar con la jeringa de 50 cc el contenido gástrico residual que pueda existir en el estómago, observando la cantidad y las características del mismo. Si la sonda está mal colocada o se aspira.
- Conectar de nuevo la jeringa llena de 30-50 cc de agua a la sonda y verter el contenido para limpiar la sonda.
- Repetir el paso anterior ahora con el alimento, de forma lenta y a un ritmo constante, todas las veces que sea necesario hasta acabar la dieta.
- Evitar la entrada de aire al estómago durante la administración.
- Limpiar la sonda con 30-50 cc de agua al terminar la administración, pinzarla con los dedos (para evitar que entre aire o salga el alimento introducido) y colocar el tapón.
- Proceder a la higiene bucal.
- Mantener al paciente en posición Fowler durante 1 h. después de la administración para evitar reflujos de contenido gástrico.
- Recoger el material y reorganizar la habitación de la persona usuaria si la ingesta se hubiera dado en ella.
- Recoger todo y dejara la persona usuaria cómoda
- Retirar los guantes y nos lavarse las manos
- al salir despedirnos de la persona usuaria
- Registrar en la historia del paciente las observaciones pertinentes.

4) Administración por gravedad

El procedimiento es muy parecido, la mayoría de los pasos son iguales como podréis comprobar. Necesitaremos guantes de un solo uso, no estériles, tapón de SNG, un vaso con agua, toalla, servilletas, jeringa de 50 cc, alimentación (triturada o preparado comercial, aunque lo más frecuente es el uso de preparados) y un pie de suero

El procedimiento es el siguiente:

- Preparar todo el material necesario Lavarse las manos y colocarse los guantes.
- Informar a la persona usuaria del procedimiento que vamos a realizar.
- Colocar a la persona usuaria sentada o en posición Fowler.
- Comprobar la correcta colocación de la sonda (SNG y de gastrostomía) de la siguiente manera:

  - Retirar el tapón de la sonda, teniendo en cuenta que en la sonda de gastrostomía el tapón suele estar integrado; mientras que en la SNG, el tapón es independiente.
  - Aspirar con la jeringa de 50 cc el contenido gástrico residual que pueda existir en el estómago, observando la cantidad y las características del mismo. Si la sonda está mal colocada o se aspira.
- Conectar de nuevo la jeringa llena de 30-50 cc de agua a la sonda y verter el contenido para limpiar la sonda.
- Conectar los extremos dístales de la sonda y la bolsa.
- Colocar la bolsa en un pie de suero y dejar que fluya por gravedad
- Evitar la entrada de aire al estómago durante la administración.
- Limpiar la sonda con 30-50 cc de agua al terminar la administración, pinzarla con los dedos (para evitar que entre aire o salga el alimento introducido) y colocar el tapón.
- Proceder a la higiene bucal.
- Mantener al paciente en posición Fowler durante 1 h. después de la administración para evitar reflujos de contenido gástrico.
- Recoger el material y reorganizar la habitación de la persona usuaria si la ingesta se hubiera dado en ella.
- Recoger todo y dejara la persona usuaria cómoda
- Retirar los guantes y nos lavarse las manos
- al salir despedirnos de la persona usuaria
- Registrar en la historia del paciente las observaciones pertinentes.

En los siguientes enlaces Web tienes videos resumen:

http://www.youtube.com/watch?v=8BI2jEMoTwo (parte 1) y
http://www.youtube.com/watch?v=p-bCHg47irg&feature=related (parte 2)

o también en esta otra: http://rafaelolalde.blogspot.com/2011/01/guia-audiovisual-sobre-cuidados.html

Échale un vistazo a las dos.

CONSEJOS RESPECTO A LA FÓRMULA:

Si el volumen aspirado es superior a 125-150 ml, esperar una hora antes de administrar la nueva toma o reiniciar la alimentación.

Reinyectar el líquido aspirado.

Lavar los envases reutilizables y los equipos con agua jabonosa. Aclarar y secar. Tener en cuenta que los equipos de bomba deben sustituirse diariamente para asegurar su correcto funcionamiento.

Los contenedores de plástico y las líneas de gravedad deben cambiarse cada 48-72 horas como máximo.

Compruebe la fecha de caducidad.

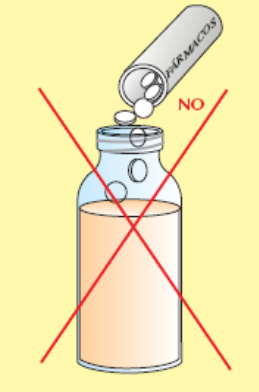
Administrar la fórmula a temperatura ambiente.

Si no se utiliza el envase completo, cerrar inmediatamente y mantener en el frigorífico un máximo de 24 horas; no administre ningún producto que permanezca abierto un período de tiempo superior. Para evitar confusiones, anotar en el frasco la fecha y hora de apertura.

Deseche cualquier contenedor o línea en los que perciba suciedad, grietas o algún pequeño orificio.

No mantenga colgada más de 24 horas ninguna fórmula abierta y conectada, ya que existe un alto riesgo de contaminación bacteriana

No mezclar nunca los medicamentos con la fórmula



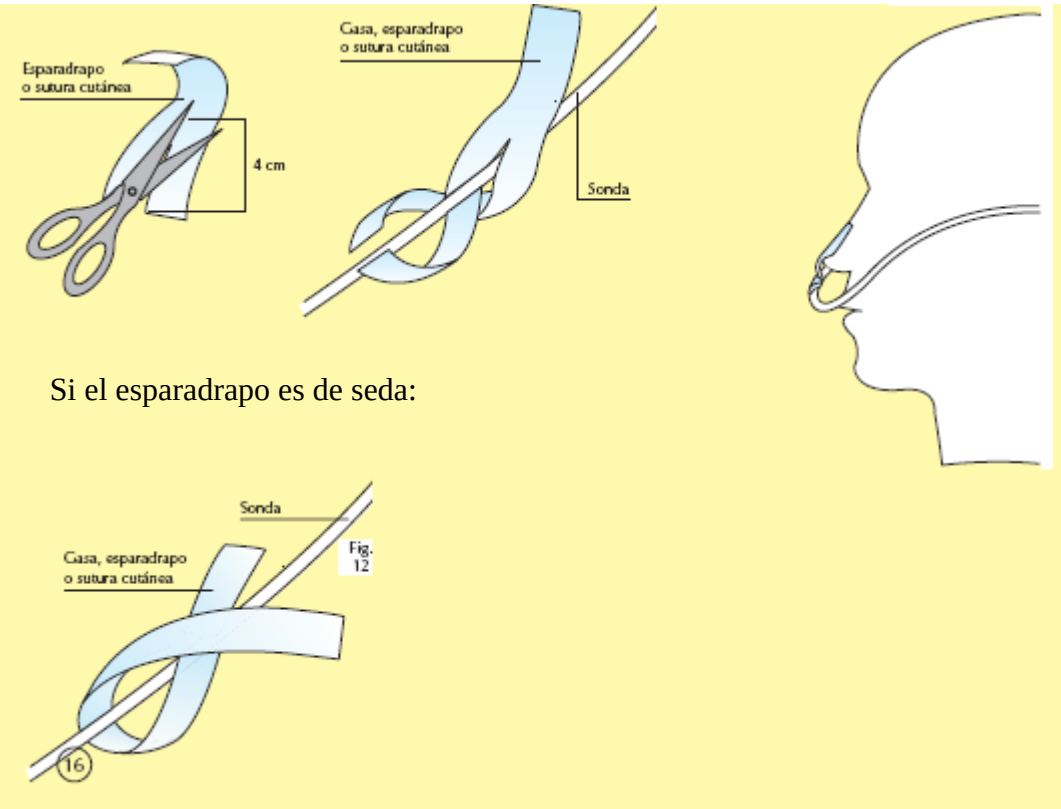
CUIDADOS ESPECIALES de la SNG o SONDA NASOGÁSTRICA

- Comprobar siempre la temperatura del alimento, que debe estar templada o a temperatura ambiente, ya que va directamente al estómago.
- Recordar tapar el extremo de la sonda con el tapón correspondiente para evitar la entrada de aire al estómago o la salida de la alimentación administrada.
- Verificar la correcta colocación de la sonda antes de administrar la alimentación. En el caso de la SNG, pintaremos una señal en la sonda que coincida con el borde nasal y comprobaremos diariamente su coincidencia, pero aún así y todo hay que extraer el contenido gástrico.
- Limpiar siempre la sonda con agua tras acabar cada administración para evitar que se obstruya

En pacientes portadores de PEG, realizar curas diarias de la zona de la ostomía, colocando un nuevo apósito.

En pacientes portadores de SNG:

- Realizar lavado de los orificios nasales diariamente.
- Cambiar el apósito fijador y modificar ligeramente el punto de apoyo de la SNG para evitar lesiones por decúbito (por presión prolongada) en la nariz. El apósito se fija así:



Para ampliar información consulta la página Web:
http://www.nestlenutrition.es/archivos/pubs/Nenteral.pdf

Apoyo a la ingesta: cubiertos, platos y vasos especiales.

CUBIERTOS

Existe gran variedad de mangos de diferentes grosores, materiales, pesos y longitudes, que acoplándolos a los distintos cubiertos consiguen dar solución a múltiples problemas de manipulación. Permiten a personas con espasticidad[14] o

14 La espasticidad se refiere a músculos tensos y rígidos. También se puede llamar "tensión" inusual o aumento del tono muscular

debilidad muscular poder agarrar los cubiertos más cómodamente y con mayor seguridad.

Es un dispositivo que se acopla a los mangos de los diferentes cubiertos. Tiene forma de cinturón y se sujeta alrededor de la mano. Es útil para aquellas personas con dificultades para sostener objetos con los dedos (figuras 1 y 2)

Hay cubiertos flexibles, de acero con mango de plástico que tienen una sección flexible que permite doblarlos; facilitan la alimentación a aquellas personas incapaces de dirigir el cubierto hacia la boca por problemas de movilidad en la muñeca (figura 3).

Los cubiertos de goma están especialmente indicados para aquellas personas cuya incoordinación de movimientos pueda dar lugar a lesiones de los dientes y los labios



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Hay cuchillos de acero que disponen de un mango vertical de plástico. Existen modelos con hoja de sierra o lisa y de diferentes tamaños. Este mango facilita la tarea a las personas que cogen los cubiertos con el puño y cortan los alimentos realizando un movimiento global del brazo (figura 4).

El cuchillo basculante permite el corte por deslizamiento y balanceo con una sola mano. Es muy útil para aquellas personas que tienen la movilidad del brazo reducida (figura 5).

El cuchillo Nelson combina dos funciones. Se trata de un cuchillo que tiene dientes en su extremo para utilizarlo también como tenedor. La hoja del cuchillo se puede utilizar mediante un movimiento de balanceo para cortar los alimentos y la punta del cuchillo para pincharlos y llevarlos a la boca. Se recomienda para personas que sólo mueven una mano (figura 6).







Figura 1 Figura 2 Figura 3



PLATOS

Hay platos con reborde diseñados para facilitar el empuje y el arrastre de la comida, evitando que el alimento se derrame. Para esta misma función también existen bordes que se fijan a cualquier plato estándar. Estos sistemas de contención del alimento son útiles cuando la persona realiza la actividad con una sola mano y no puede ayudarse de la otra para empujar la comida.

Es conveniente que los platos sean de rebordes altos.

Para personas que tardan mucho tiempo en comer existen paltos termo que mantienen el alimento caliente.

VASOS



Los vasos con sistema de paja adaptada permiten beber de forma independiente a aquellas personas que no pueden sujetar el vaso de ninguna otra forma. La persona puede beber directamente sin necesidad de elevar el vaso. En estos casos es necesario que la persona sepa sorber.



Otra adaptación que nos encontramos en los vasos es la incorporación de una tetina o boquilla. Llevan una tapa que dispone de unos agujeros que dosifican la salida del líquido.



Están indicados para personas con riesgo de atragantamiento.

Existe gran variedad de vasos, siempre de plástico: con una o dos asas, de diferentes tamaños, con mayor base para dar más estabilidad, más pesados para evitar temblores o más ligeros para cuando hay debilidad muscular

Los vasos copa son vasos de plástico duro y resistente al calor que tiene la base adaptada para permitir cogerlo cuando no se puede cerrar la mano. Se sujeta en el hueco entre el pulgar y el índice, bien con la palma hacia arriba o bien hacia abajo.

Pautas según estado de la persona usuaria.

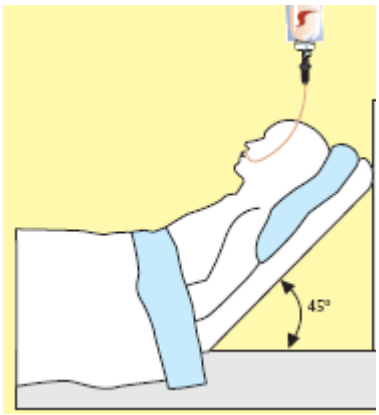
Las pautas generales de alimentación por vía oral incluyen la alimentación en el desayuno, a media mañana, en la comida, en la merienda y en la cena.

En condiciones normales se respetan los menús preestablecidos, aunque en situaciones de patología se podrán modificar según las necesidades específicas, los hábitos y las preferencias del usuario. Por ejemplo un diabético seguirá los menús pero se reducirá el contenido de azúcar. En personas hipertensas también seguirá los menús reduciendo la cantidad de sal.

Posturas de la persona usuaria que facilitan la ingesta.

A la hora de la alimentación, el usuario debe adoptar la posición más fisiológica y cómoda, para evitar así posibles complicaciones, como el atragantamiento o la broncoaspiración, y facilitar la digestión. Esta posición debe ser la de sentado.

En pacientes encamados, se procederá a colocar al usuario en posición Fowler, ayudándonos de almohadas o cojines que mantengan dicha posición, siendo realmente útil contar con una cama articulada para realizar esta movilización. Así, en la posición Fowler el paciente permanece sentado, con el cabecero de la cama a 45º. Las piernas se colocan en semiflexión, con la posibilidad de una almohada bajo las rodillas y la colocación de un tope almohadillado en los pies. Las camas articuladas de 3 segmentos permiten, además de elevar la cabecera, ajustar el segmento pélvico y el pie de la cama, evitando que el paciente se resbale



3.5.- Técnicas de recogida de eliminaciones.

En las instituciones sanitarias nos encontraremos en nuestra práctica diaria pacientes encamados o con determinado grado de dependencia en la movilización que, sin presentar problemas de incontinencia, no serán capaces de utilizar el cuarto de baño a la hora de orinar o defecar (usuarios habituales del pañal) y mantendrán la sensación de llenado.

En estos pacientes, utilizaremos dispositivos de ayuda para la eliminación, como son la cuña y la botella; éstos promueven una cierta independencia y ayudan a mantener el control de esfínteres por parte del paciente. Para la micción y recogida de orina en el caso de los hombres, se indica el orinal tipo botella; para la micción y la defecación en ambos sexos, se utiliza el orinal tipo cuña.

A continuación, exponemos dos procedimientos dirigidos a pacientes continentes dependientes:

1.- RECOGIDA DE ELIMINACIONES CON CUÑA



Se Utiliza en mujeres para recoger orina y heces y en hombre solo para las heces

Es un momento íntimo para la persona usuaria, es probable que esté incomoda por lo que debemos actuar con naturalidad.

Antes de comenzar si el tipo de cama lo permite es mejor elevar ligeramente el cabecero.

Necesitaremos además de la cuña, papel higiénico, guantes desechables y si fuera preciso lencería de cama limpia y pijama o camisón limpio

Procedimiento con persona usuaria colaboradora

1. Preparar el material y acercarlo a la habitación;
2. lavarse las manos y colocarse los guantes;
3. saludar a la persona usuaria y explicarle el procedimiento solicitando su colaboración. Este será de los pocos procedimientos en los que no hay que indicar a la persona usuaria qué se le va a hacer pues suele ser a demanda.
4. En todo momento preservar a intimidad del paciente, invitando a abandonar la habitación a las visitas y evitando el contacto visual con su compañero si lo tuviera mediante cortinas o biombos.
5. Retirar la ropa de cama de modo que permita introducir la cuña, retirar solo lo necesaria a fin de preservar la intimidad del paciente;

6. indicar al paciente que levante las caderas y mientras lo hace introducimos con la mano dominante la cuña entre las piernas o por la derecha y con la parte plana hacia la espalda de la persona usuaria, puedes ayudarle introduciendo bajo sus caderas el brazo no dominante.
7. confirmar que la cuña queda bien colocada.
8. Cuando finaliza, se limpia el perineo con papel o con un chorro de agua jabonosa y posterior aclarado. Si se requiere habrá que realizar el aseo del perineo tal y como se ja indicado en el apartado 1.2 de este módulo.
9. retiramos la cuña y si así estuviera indicado anotamos las características del contenido (cantidad, aspecto, color, etc.) en la gráfica de la persona usuaria.
10. Lavamos la cuña
11. recogemos todo y dejamos a la persona usuaria cómoda
12. retiramos los guantes y nos lavamos las manos
13. al salir no olvidar despedirnos de la persona usuaria

Procedimiento con paciente no colaborador

1. Comenzamos de la misma manera, se repiten los puntos 1 a 5. y a partir de ahora:
2. Colocar a la persona usuaria en decúbito lateral hacia donde estás tú.
3. Colocar la cuña en la misma posición que ya se ha indicado y volver a colocar a la persona usuaria en decúbito supino sobre la cuña.
4. Confirmar que la cuña queda bien colocada.
5. Cuando finaliza, se limpia el perineo con papel o con un chorro de agua jabonosa y posterior aclarado. Si se requiere habrá que realizar el aseo del perineo tal y como se ja indicado en el apartado 1.2 de este módulo.
6. Colocando al paciente en decúbito lateral hacia el lado que tú te encuentras, retiramos la cuña y si así estuviera indicado anotamos las características del contenido (cantidad, aspecto, color, etc.) en la gráfica de la persona usuaria.
7. Lavamos la cuña.
8. recogemos todo y dejamos a la persona usuaria cómoda
9. retiramos los guantes y nos lavamos las manos
10. al salir no olvidar despedirnos de la persona usuaria

2.- RECOGIDA DE ELIMINACIONES CON BOTELLA



Solo se utiliza para la micción en hombres que por la causa que fuere son continentes que no pueden levantarse de la cama.

Necesitaremos además de la cuña, papel higiénico, guantes desechables y si fuera preciso lencería de cama limpia y pijama limpio.

Necesitaremos además de la botella, gasas, guantes desechables y si fuera preciso lencería de cama limpia y pijama o camisón limpio

Procedimiento:

1. Comenzamos de la misma manera, se repiten los puntos 1 a 5, pero en este último en vez de la cuña utilizaremos botella. A partir de ahora:
2. Si el paciente puede indicarle que introduzca el pene en la botella y si no pudiera hacerlo uno mismo.

3. Cuando finaliza limpiaremos el meato[15] con una gasa y retiraremos la botella y si así estuviera indicado anotamos las características del contenido (cantidad, aspecto, color, etc.) en la gráfica de la persona usuaria.

4. Lavamos la botella.
5. Recogemos todo y dejamos a la persona usuaria cómoda.
6. Retiramos los guantes y nos lavamos las manos.
7. Al salir no olvidar despedirnos de la persona usuaria.

Dificulta el procedimiento:

- La obligación de permanecer en cama puede alterar el carácter de la persona usuaria.
- La imposibilidad de que la propia usuaria pueda acceder a la cuña o a la botella porque suele estar en el aseo.
- La incomodidad que genera la presencia del profesional sanitario.

Es frecuente le estreñimiento por:

- La propia inmovilidad
- El pudor a eliminar en presencia de otra persona

Para hacerle frente es importante hidratar bien a la persona usuaria y vigilar su alimentación tal con una dieta rica en fibra y evitando los alimentos astringentes.

Es notorio el riesgo de infección por

- Éstasis[16] vesical

- No ingerir el suficiente líquido
- No limpiar bien la cuña o la botella según sea el caso
- No limpiar bien los genitales tras la eliminación

Lo único que se puede hacer como prevención es hidratar bien a la persona usuaria y ser muy escrupulosos con las medidas higiénicas.

15 Es el orificio por el que la orina sale al exterior
16 Estancamiento de orina en la vejiga.

3.- RECOGIDA DE ELIMINACIONES EN UN USUARIO OSTOMIZADO:

Como ya indicamos en el apartado 1.4 de este módulo, una persona ostomizada es aquella que ha sido objeto de una intervención quirúrgica para realizar una apertura artificial del intestino delgado o grueso a la pared abdominal.

En estos casos el usuario suele llevar una bolsa adherida a la piel para favorecer la recogida de las eliminaciones.

El cambio de bolsa se realizará tantas veces sea necesario y el aseo y la higiene de la piel para prevenir lesiones se realizará con agua y jabón neutro.

Todo lo referente al manejo de la bolsa de colostomía lo hemos visto en el apartado 1.4 vuelve a leerlo si no lo recuerdas

4.- RECOGIDA de MUESTRAS con fines TERAPÉUTICOS

Para la recogida de muestras con fines terapéuticos necesitaremos los siguientes materiales:

- Orinal tipo cuña o tipo botella.
- Empapador.
- Papel higiénico.
- Guantes.
- Impreso de solicitud para el análisis.
- Etiquetas con los datos del paciente o, en su defecto, rotulador indeleble.
- Bote estéril para recoger la muestra.
- Material de aseo: palangana, agua y jabón, esponja y toalla.

El procedimiento es el siguiente:

- Preparar el material y acercarlo a la habitación;
- lavarse las manos y colocarse los guantes;
- saludar a la persona usuaria y explicarle qué venimos a hacer y cómo lo haremos, solicitando su colaboración.
- En todo momento preservar a intimidad del paciente, invitando a abandonar la habitación a las visitas y evitando el contacto visual con su compañero si lo tuviera mediante cortinas o biombos.
- Realizar el aseo del perineo como ya se ha indicado en el apartado 1.2 de este módulo
- Retirar la ropa de cama de modo que permita introducir la cuña o la botella, retirar solo lo necesaria a fin de preservar la intimidad del paciente;

- Dejarle que elimine tal y como se ha explicado
- En el caso de que la muestra a recoger sea de orina, desechar la primera parte de la micción para que se lave la uretra por arrastre.
- En el caso de que la muestra sea de heces, utilizar un depresor (palo de madera habitualmente utilizado por el médico para la exploración de la faringe) para el traslado de la muestra al recipiente adecuado.
- Cuando finaliza, se limpia el perineo como se ha indicado en los procedimientos anteriores.
- Precintamos la muestra y anotamos en ella los datos de la persona usuaria
- Lavamos la cuña o la botella.
- Recogemos todo y dejamos a la persona usuaria cómoda.
- Retiramos los guantes y nos lavamos las manos.
- Al salir no olvidar despedirnos de la persona usuaria.

3.6.- Prevención de riesgos en la alimentación y la recogida de eliminaciones.

Los riesgos más frecuentes de la actividad sanitaria son los derivados del contacto y manipulación de alimentos o de fluidos biológicos, son las enfermedades infecciosas. Las principales fuentes suelen ser:

- Los pacientes y los materiales biológicos procedentes de los mismos.
- Los equipos e instrumentación contaminados.
- Los residuos generales.
- Las diversas instalaciones del hospital, en las que pueden existir reservorios de agentes biológicos, como las instalaciones de aire acondicionado.
- Las vías de infección por contacto con dichos agentes pueden ser:
    - Parenteral: por contacto con la sangre a través de la piel
    - Aérea: por inhalación.
    - Dérmica: por contacto de la piel con líquidos biológicos
    - Digestiva (asociada a malos hábitos higiénicos).

Las principales medidas preventivas indicadas para evitar el riesgo biológico son:

- Precauciones universales: debemos tomar siempre una serie de precauciones generales (lavado de manos y colocación de guantes) para evitar el contacto con fluidos biológicos considerados potencialmente

infecciosos. Esto se debe hacer con independencia del paciente de que se trate. Vistas en el apartado 1.5 de este módulo

Las normas de higiene personal a contemplar son:

- Cubrir heridas y lesiones que puedan estar en contacto con agentes infecciosos antes de iniciar nuestra actividad laboral.
- Lavar las manos al comenzar y al terminar cada jornada de trabajo, así como antes y después de realizar cualquier técnica que implique el contacto directo con pacientes o material infeccioso.

Además:

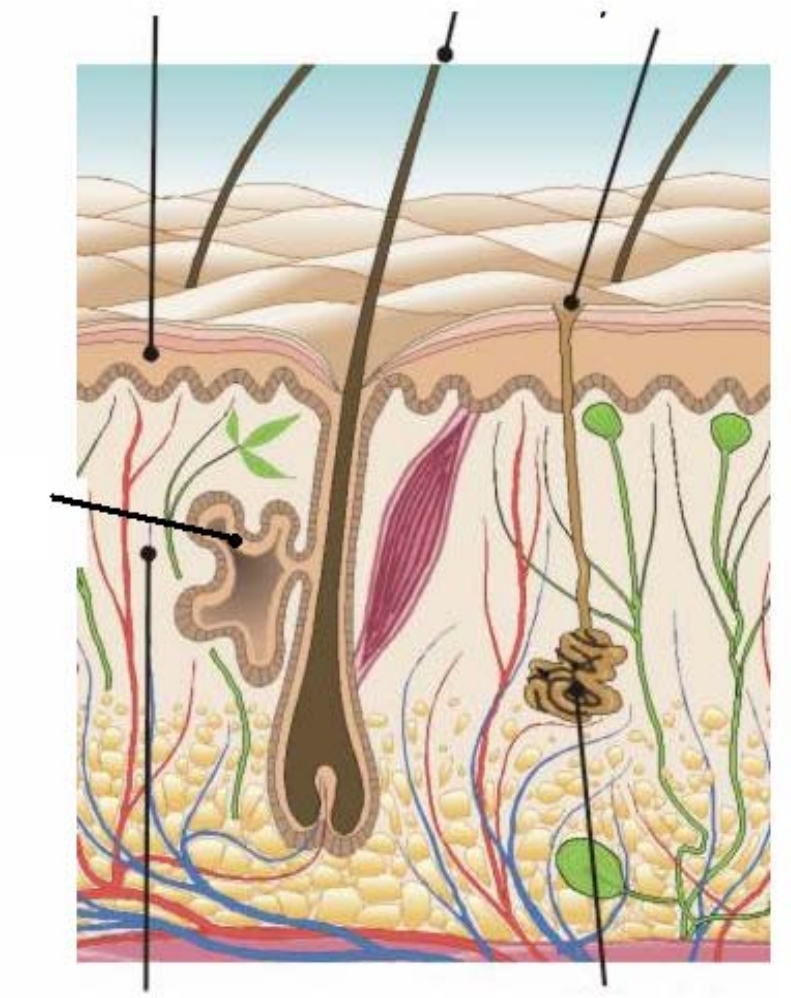
NORMAS GENERALES de PREVENCIÓN de RIESGOS para el PERSONAL SANITARIO

- Vacunarse de **hepatitis B** al iniciar el trabajo en cualquier centro sanitario.
- **Lavarse las manos** antes y después del contacto con pacientes o con material potencialmente contaminado.
- Evitar la **formación de heridas** en el trabajo, sobre todo, con material contaminado.
- Disminuir el **contacto de heridas** con material biológico utilizando barreras (apósitos, guantes...).
- Utilizar **recipientes herméticos** e irrompibles para la obtención de muestras analíticas.
- Usar correctamente el material sanitario y los **contenedores de eliminación** de residuos.
- **Limpiar** adecuadamente, siguiendo el protocolo del centro, las superficies manchadas de sangre o fluidos corporales.
- **Limpiar, desinfectar y esterilizar** el material contaminado de material biológico.
- Hacer uso correcto de **elementos de barrera** (guantes, mascarilla, bata,...), principalmente en aislamientos.
- **Explicar** las normas generales y de aislamiento a los pacientes y sus familiares para evitar las infecciones nosocomiales.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

1.- Nombra las diferentes capas de la piel.

2.- Nombra las zonas indicadas:



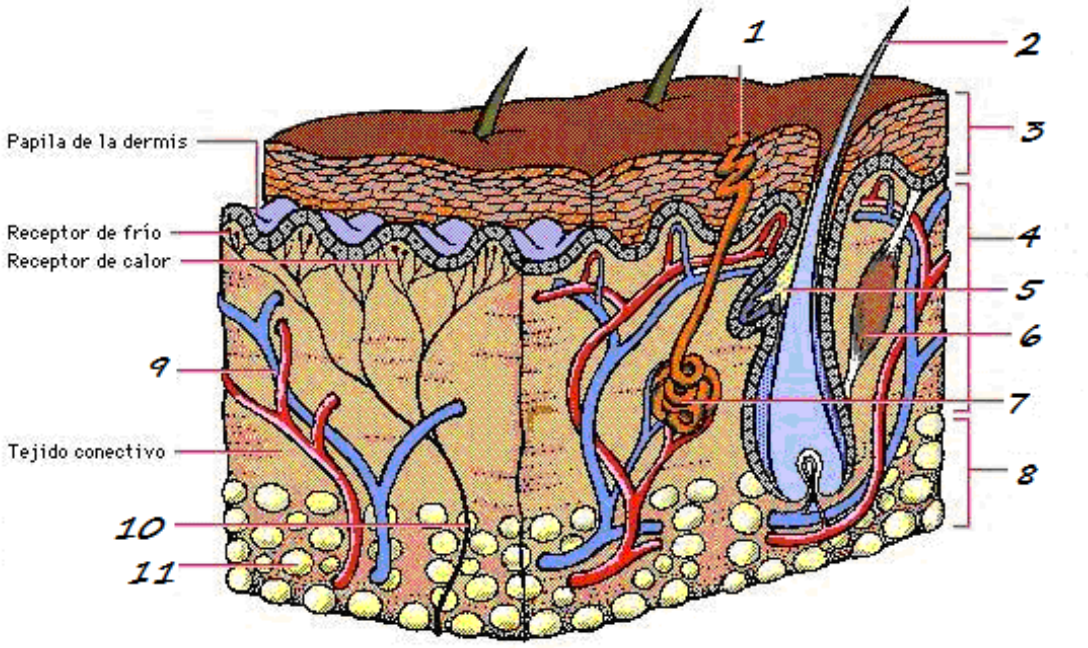
3.- Contesta a las siguientes cuestiones:

a) ¿Para qué sirve el sudor?

b) ¿Qué son los anejos cutáneos?

c) ¿Cuáles conoces?

4.- Nombra las zonas numeradas:



5.- ¿Cuántos tipos de glándulas hay en la piel? ¿Cuáles son?

6.- Enumera las distintas funciones de la piel.

7.- Seleccione el material necesario para la realización de las distintas técnicas de higiene que se proponen

Material	Procedimiento				
	①	②	③	④	⑤
Guantes desechables					
Toallas					
Crema hidratante					
Bolsa para ropa sucia					
Cuña					
Hule o plástico					
Empapadores					
Gasas o torundas					
Champú					
Esponjas desechables					

Jabón líquido					
Vaso					
Secador					
Empapador					
Limas de uña					
Cepillo de uñas					
Tijera de punta roma o cortaúñas de manos y pies					
Pinza (Kocher[17] o similar)					
Peine					
Jarra de agua caliente					
Pijama o camisón					
Palangana con agua caliente (aproximadamente 37º C)					
Ropa de cama					
Alfombra antideslizante					

8.- Ordena cronológicamente las siguientes acciones del aseo a un persona usuaria encamado.

a. Realizar la higiene de espalda y glúteos
b. Realizar la higiene de los pies
c. Realizar la higiene de los miembros superiores
d. Comunicar a la persona usuaria que vas a bañarlo
e. Realizar la higiene de la cara
f. Realizar la higiene de los miembros inferiores
g. Realizar el aseo de tórax y abdomen
h. Realizar el aseo de la zona genital
i. Preparar el material necesario
j. Realizar el aseo de la zona anal
k. Hidratar la piel de la persona usuaria
l. Recoger el material empleado y ordenar la habitación

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9.- Contesta si son verdadera o falsas las siguientes propuestas, corrigiendo las respuestas que consideres falsas.

17 pinzas de forcipresión una de cuyas ramas termina en un diente que encaja en una muesca situada en el extremo de la otra. Se utilizan para pinzar

1. Es necesario limpiar cada ojo con una gasa distinta
2. Los ojos se limpiaran del ángulo externo al interno
3. A medida que se baña a persona usuaria se observará el estado de la piel
4. La higiene de las uñas es competencia exclusiva del podólogo
5. En la higiene genital femenina enjabonaremos y lavaremos la zona genital en el siguiente orden: pliegue inter-glúteo, ano, pubis, zona interna de los muslos, meato urinario, labios menores, labios mayores y hendidura vulvar.
6. En la higiene genital masculina se colocará a la persona usuaria en posición ginecológica.
7. Se cortarán las uñas de las pies siguiendo la forma del dedo y rectas las manos.

10.- Realiza una clasificación de las técnicas de aseo que conozcas.

11.- Cita las al menos 7 consideraciones generales a tener en cuanta ante cualquier técnica de higiene.

12.- Responde a las preguntas tipo test:

1.- Normalmente la temperatura del agua para el aseo e higiene de la persona usuaria, salvo excepciones es de:
a. 17º C. b. 27º C. c. 37º C. d. 47º C. e. 57º C.

2.- Con el baño o ducha de la persona usuaria conseguimos múltiples beneficios, excepto:
a. Estimular la circulación sanguínea
b. Evitar la acumulación de secreciones
c. Modifica el pH de la piel, para evitar la sudoración
d. Ayudar a conservar la integridad de la piel.
e. Favorece la propia autoestima

3.- En el lavado higiénico de la persona usuaria hospitalizada debe de utilizarse en la medida de lo posible:
a. Jabones ácidos
b. Jabones neutros
c. Jabones alcalinos
d. Biombo de aislamiento cuando hay que asearlo en una habitación compartida.
e. b y d.

4.- En el aseo de la persona usuaria encamado lo último que debe de lavarse es:
a. Las piernas i pies. b. La región genital. c. Ojos.
d. Espalda y nalgas. e. No importa el orden en que se haga el lavado.

5.- Es incorrecto en la higiene del oído:
a. Hay que limpiar el conducto auditivo externo con bastoncillos habitualmente.
b. Lavar con agua y jabón las orejas diariamente.
c. Mojar el conducto auditivo externo todos los días con la ducha o el baño.

d. Colocar tapones en los oídos para bañarse en piscinas.
e. Preservar los oídos con tapones, en zonas muy ruidosas (trabajos de metalurgia, chapa,…)

6.- La higiene se ocupa de:
a. La conservación de la salud individual
b. La promoción de la salud comunitaria
c. La conservación de la salud colectiva.
d. La promoción de la salud individual
e. Todas las respuestas anteriores son correctas

7.- Para que la persona usuaria realice el baño o la ducha es necesario proporcionarle:
a. Dos toallas y jabón.
b. Pijama o camisón.
c. Bata.
d. Zapatillas.
e. Todo lo anterior.

8.- Para realizar el baño de la persona usuaria encamado se necesita:
a. Que la temperatura del agua sea de 38º C.
b. Entremetida.
c. Tijeras de punta roma.
d. Hule.
e. Todos.

9.- Cuando la persona usuaria se encuentra encamado, el aseo general en cama:
a. No debe de realizarse a diario.
b. Debe de realizarse todos los días.
c. Debe de realizarse como mínimo dos veces al día.
d. No debe hacerse en ningún caso.
e. B y d.

10.- El baño a la persona usuaria encamado hay que realizarlo por partes. La primera parte que debe lavarse es:
a. Las extremidades inferiores.
b. Espalda y nalgas.
c. Cara, cuello y orejas.
d. Manos.
e. Brazos y manos.

11.- El orden a seguir para realizar el baño la persona usuaria encamado es:
a. Cara, cuello, y orejas - brazos y manos - tórax – abdomen - extremidades inferiores - genitales externos - espalda y nalgas.
b. Cara, cuello, y orejas - brazos y manos - tórax - abdomen - extremidades inferiores - espalda y nalgas - genitales externos.

c. Brazos y manos - cara, cuello, y orejas - tórax - abdomen - extremidades inferiores - genitales externos - espalda y nalgas.
d. Todas son correctas.
e. Todas las respuestas anteriores son falsas.

12.- En el lavado o higiene de los genitales externos:
a. Se precisa de una cuña.
b. Se hace siempre en la dirección de ano a genitales externos.
c. Se coloca a la persona usuaria en posición Roser..
d. Se hace siempre en la dirección de genitales externos a región anal.
e. A y d.

13.- Para realizar la higiene del cabello en un persona usuaria encamado hay que colocarlo en la posición de:
a. Roser. b. Morestin. c. Sims. d. Fowler. e. Ninguna es correcta.

14.- Para el lavado del cabello de la persona usuaria encamado se precisa entre otras cosas:
a. Toallas.
b. Hule.
c. Palangana
d. Pinza de Pean
e. Todas son correctas

15.- Zonas más propensas a la formación de úlceras por decúbito cuando la persona usuaria se encuentra en decúbito prono:
a. Sacro
b. Talones
c. Genitales en el hombre y senos en la mujer
d. Trocánter menor
e. Ninguna es correcta.

16.- Si el enfermo está en decúbito supino... ¿qué zonas son más propensas a la formación de úlceras por decúbito?
a. Rodillas b. Orejas c. Maléolos d. Omóplatos e. Todas son correctas

17.- Con la persona usuaria en decúbito lateral, las zonas más propensas a la formación de úlceras por decúbito son:
a. Sacro b. Talones c. Trocánter mayor d. Occipucio e. Ninguna

18.- Las úlceras por decúbito se producen por:
a. Estar mucho tiempo de pie
b. Realizar una deambulación incorrecta
c. Presión continua y repetitiva en zonas determinadas de la piel
d. Exceso de la producción de ácido clorhídrico gástrico
e. Ninguna es correcta

19.- El primer signo en la formación de una úlcera por presión es:
a. La aparición de una costra

b. La aparición de una vesícula
c. La aparición de un eritema
d. La aparición de un edema
e. Todas son correctas

20.- La prevención de las úlceras por decúbito será:
a. Mantener la misma postura
b. Mantener húmeda la piel para tener una correcta hidratación
c. Realizar cambios posturales cada 2 a 3 horas
d. Evitar los masajes en la piel
e. Todas son correctas

21.- Señala la premisa correcta:
a. Las úlceras por decúbito se suelen localizar en el estómago
b. Las úlceras por decúbito se producen por exceso de melanina en la piel
c. Las úlceras por decúbito se producen por una infección
d. Las úlceras por decúbito se producen por presión prolongada en una zona del cuerpo
e. Las úlceras por decúbito se suelen localizar en el esófago

22.-Para evitar caídas del paciente encamado, se utiliza como accesorio:
a. Arco de cama.
b. Estribo o triángulo de Balkan.
c. Barandillas o reja de seguridad.
d. Protectores de barandilla.
e. centinelas de cama

23.- 3. No se incluye dentro de las condiciones atmosféricas:
a. La humedad.
b. El ruido exterior.
c. La ventilación.
d. La temperatura.
e. ninguna de ellas

24.- 5. Las dimensiones de la cama, en cuanto a la longitud, pueden variar:
a. De 200 a 300 cm.
b. De 190 a 200 cm.
c. De 180 a 190 cm.
d. De 150 a 200 cm.
e. no hay medidas establecidas

25.- Es falso que sea una norma general, en el arreglo de la cama:
a. Explicar el procedimiento al paciente.
b. Colocar el carro de sucio junto a la cama.
c. Preparar previamente todo el equipo necesario.
d. Cambiar la cama por la mañana.

e. cambiar la cama cada vez que se ensucia.

26.- La cama en la que hay un paciente, pero que no la ocupa en el momento de hacerla, se llama:

a. Abierta.
b. Ocupada.
c. Quirúrgica.
d. Cerrada
e. Asignada.

27.- En la técnica de arreglo de la cama, la diferencia entre la cerrada y la abierta es la siguiente:

a. Se deja abierta aunque no esté el paciente.
b. Se recoge la ropa de la cama bajo el colchón.
c. Se añade al equipo el pijama o camisón, la bata y las toallas.
d. No hay diferencias.
e. la cama nunca es cerrada

28.- ¿Cuál de estos colchones no se utiliza en la prevención de las úlceras por presión?

a. Alternanting.
b. De muelles.
c. De esferas fluidificado.
d. De agua.
e. antiescaras

13.- Contesta verdadero (v) o falso (f) a las siguientes afirmaciones. Corrige las falsas

1. La higiene en bañera o ducha está indicada en aquellos pacientes que pueden levantarse y cuyo nivel de autonomía es alto.

2. La limpieza de los genitales siempre se realizará desde la zona más sucia a la zona más limpia.

3. Los grupos de personas en los que vamos a encontrar mayor incidencia de pliegues corporales son los jóvenes y las personas delgadas.

4. Las personas diabéticas son más propensas a tener problemas en los pies, tales como llagas o heridas.

5. Los mecanismos externos que provocan la aparición de úlceras por presión son: presión, fricción y cizallamiento.

6. Los cambios posturales son las modificaciones realizadas en la postura corporal del profesional a la hora de movilizar al paciente y forman parte de la enfermería preventiva.

7. Los nutrientes son las sustancias integrantes de los distintos alimentos, útiles para el metabolismo orgánico, que son los siguientes: hidratos de carbono, grasas y proteínas; sales minerales; vitaminas; y agua.

8. El sistema digestivo está constituido por: boca, laringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y glándulas anejas.

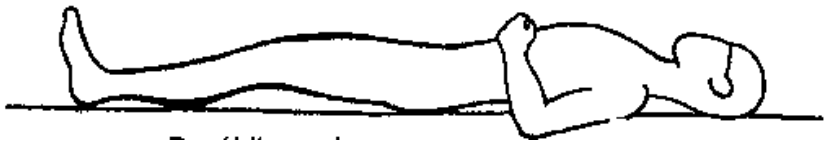
9. La dieta absoluta es la que incorpora todos los nutrientes esenciales.

10. La dieta astringente se indica en pacientes con estreñimiento por ser pobre en fibras y basarse en los cereales y sus derivados.

11. La dieta diabética se basa en la reducción de los alimentos que proporcionan azúcares (dulces, bollería, pastas…) y las bebidas alcohólicas.

12. La alimentación del paciente, dependiendo del caso, se podrá llevar a cabo por tres vías diferentes: por vía oral, enteral (SNG o gastrostomía) o parenteral (catéter endovenoso).

14.- Señala las zonas de riesgo de aparición de UPP en las siguientes posiciones:

Decúbito supino	
Decúbito prono	
Decúbito latera	

Sedestación	

15.- Rellena la siguiente tabla:

	Nombre	Se utiliza para….
		
		
		

16.- Ingresa en la residencia una persona de edad avanzada que hasta ahora ha vivido en el domicilio familiar al cuidado de sus hijos. Diagnosticado de la enfermedad de Alzheimer, presenta bajo nivel de conciencia, por lo que precisa ayuda para levantarse al sillón y no es capaz de deambular. Presenta además buen estado de piel y mucosas y precisa del uso de pañales por INCONTINENCIA URINARIA y fecal

1. ¿Qué valoración de riesgo de UPP obtendría este residente, utilizando la escala de Norton?
2. A la vista del resultado, ¿sobre qué aspectos podemos actuar y cómo?

17.- Martín de 85 años presenta buena coloración de la piel y la mucosa, hoy se ha levantado con fiebre (38ºC) y el resto de las constantes vitales normales. Es un residente consciente, orientado y colaborador. Presenta inestabilidad en la marcha y lentitud de movimientos. Se le ha diagnosticado una inflamación crónica de próstata, la cual le ocasiona una ligera INCONTINENCIA URINARIA.

Con los datos del residente, elabora un plan de cuidados referido a las necesidades higiénicas del mismo.

18.- Dolores de 78 años ha acudido al médico por un problema urinario y se decide sondaje vesical.

Elabora un plan de cuidados para el cuidado de la sonda**.**

19.- Simón de 80 años es un residente que se le practicó una intervención quirúrgica en la que se le realizó una colostomía ascendente. Su aspecto es normal y lleva una dieta normal.

Realiza un plan de cuidados en los aspectos relativos a la colostomía.

20.- ¿Por qué es importante una correcta Higiene de las Manos?

21.- Describe los 5 momentos de la Higiene de las Manos y asóciales un caso práctico

22.- Enumera las condiciones higiénicas y ambientales que ha de reunir la habitación.

23.- Como denominamos a la luz que está situada en el cabezal incide en la cama

24.- Cual es la utilidad de la luz piloto en la habitación del enfermo

25.- Cuales son las ventajas de la luz solar en la iluminación de la habitación.

26.- Que condiciones ha de reunir el mobiliario de la habitación del enfermo.

27.- Enumera el mobiliario de la unidad de la persona usuaria

28.- Que condiciones ha de tener la cama.

29.-Indica al menos cuatro accesorios de la cama hospitalaria

30.-Que entiendes por cama cerrada, y que diferencia encuentras con la cama desocupada.

31.-Enumera el material necesario para hacer una cama en el orden de colocación. Explica brevemente como se realiza una cama abierta desocupada

32.-Que tipo de colchón utilizarás para prevenir las úlceras por presión.

33.-Cual es la principal premisa a tener en cuenta cuando hacemos la cama ocupada

34.- En la residencia de ancianos donde trabajas están ingresados Andrés y Justo, que comparten habitación. Debes distribuir las camas de tal forma que permitan la atención física de los pacientes de forma cómoda. ¿Qué aspectos debes tener en cuenta?

35.- En la Residencia Geriátrica Virgen del Mar se está procediendo a renovar los elementos que constituyen la «unidad del paciente». Se solicita al personal de enfermería que confeccione un listado de dichos elementos, clasificándolos en función de su uso en: a) mobiliario; b) materiales de uso habitual y c) materiales para la higiene y aseo del paciente.

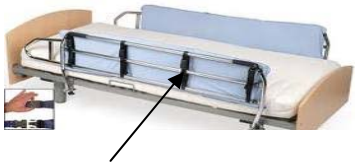
36.- José esta encamado y se le debe arreglar la cama con cambio de la lencería.

a) ¿En qué orden colocarás la ropa de la cama en la silla para arreglar su cama?

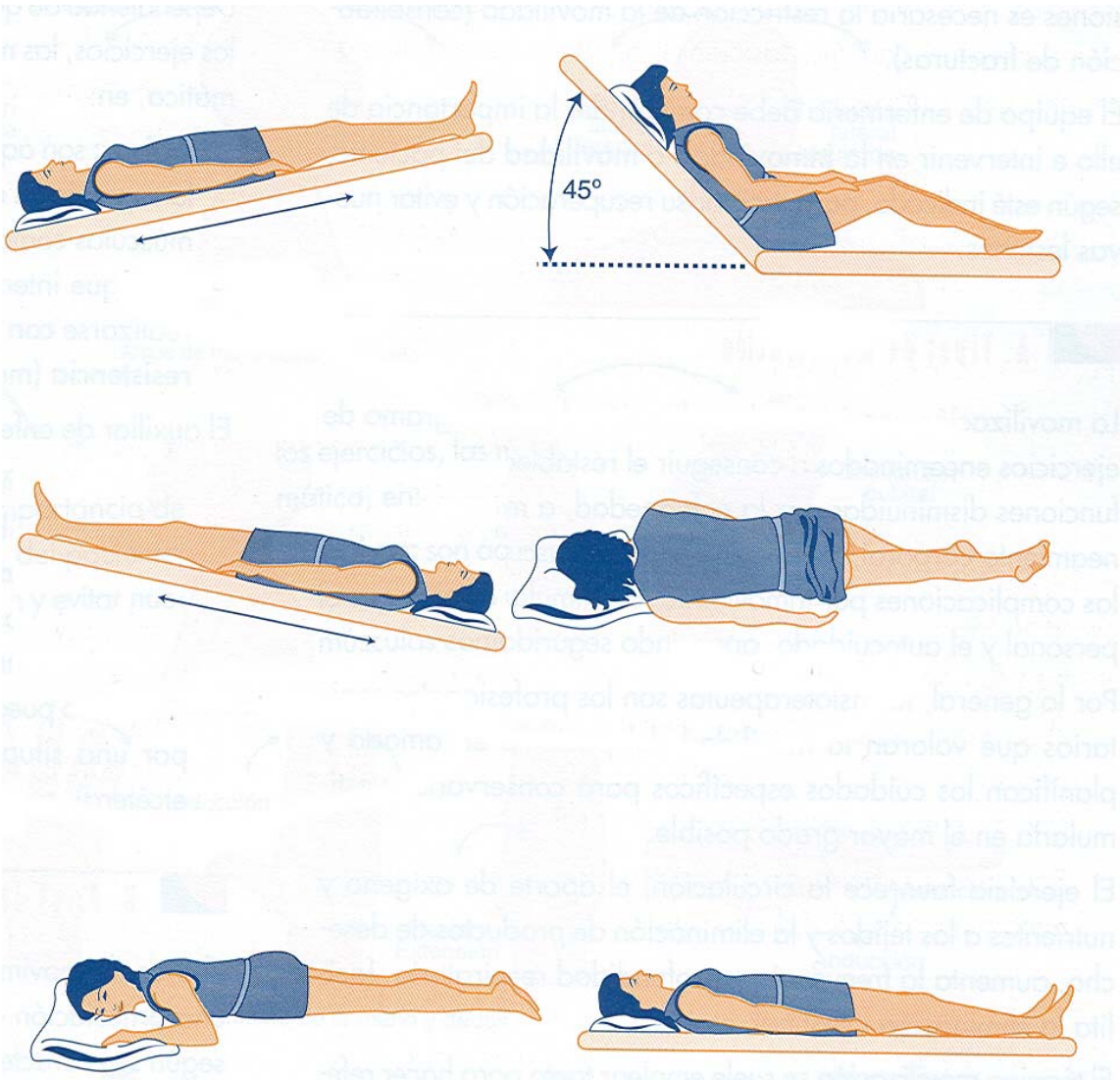
b) A la hora de arreglar la cama, ¿qué debes tener en cuenta?

37.- Rellena la siguiente tabla:

	Nombre	Se utiliza para….
		
		

38.- Identifica cada una de las siguientes posiciones corporales y explica en que situaciones utilizaremos cada una de ellas:



39.- Define alimentación y nutrición. Indica las diferencias entre ambos.

40.- Completa la siguiente tabla

Función	Nutrientes	Alimentos
Energética		
Estructural		
Reguladora		

41.- Colorea los alimentos de la pirámide según su función tal y como has visto en la rueda de alimentos



42.- Para repasar la anatomía del aparato digestivo haz clic en este enlace de la junta de Andalucía y realiza las actividades interactivas que te indican.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/ssvv/digestivo.htm

43.- Completa los test de los siguientes enlaces:
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/questionari71es.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/07digestiu/questionari72es.htm
http://www.aula2005.com/html/cn3eso/15endocri/testendocri152es.htm

44.- La siguiente secuencia describe los productos que se van formando desde que el alimento entre en el tubo digestivo:

Bolo ⇨ Quimo ⇨ Quilo ⇨ Heces

Indica en cada caso

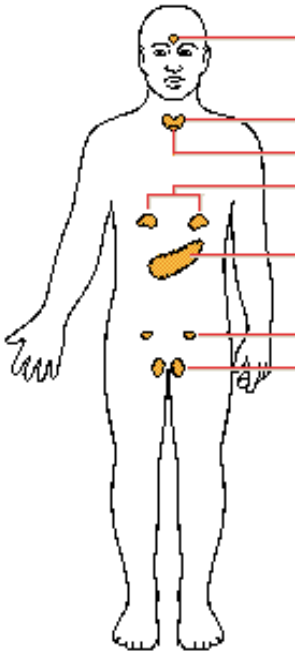
1. ¿dónde se producen?
2. ¿A consecuencia de qué proceso? Explícalos brevemente
3. ¿Hay algún otro producto que se produzca?

45.- Completa la siguiente tabla:

Hormona	Glándula secretora	Función
la adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropa o ACTH		
tirotropina (TSH)		
FSH		
hormona luteinizante (LH)		
somatotropina		
prolactina		
Endorfinas		

vasopresina		
oxitocina		
Adrenalina, epinefrina o noradrenalina		
glucoorticiodes		
tiroxina y la triyodotironina		
calcitonina		
parathormona		
estrógenos		
andrógenos		
insulina		
glucagon		

46.- Enumera las glándulas endocrinas de nuestro organismo situándolas en la imagen:



46.- ¿Que es la digestión? ¿Por qué es necesaria?

47.- ¿Cuales son los nutrientes básicos?

48.- -¿Como ha de ser la distribución de los nutrientes en la ingesta diaria?

49.- Describe, de forma completa y ordenada, el procedimiento de alimentación por SNG de forma manual.

50.- Explica brevemente el procedimiento de colocación del orinal tipo cuña en paciente sin movilidad.

51.- Completa las siguientes afirmaciones sobre prevención de infecciones.

a) Llamamos _____ a la penetración y desarrollo de gérmenes patógenos en el organismo, que desencadenan una _____. Es la irrupción de un agente extraño (virus, bacterias, hongos, etc.) dentro del organismo donde sobrevive y se multiplica.

b) Hay dos tipos de precauciones de aislamiento: de primer nivel, también llamadas precauciones _____; y de segundo nivel, también llamadas precauciones basadas en la vía de _____. Las principales vías son: infección transmitida por el _____, infección por gotitas e infección por _____ directo o indirecto.

c) El lavado de manos es la principal medida para evitar las infecciones _____ de origen exógeno (causada por microorganismos adquiridos

desde una fuente externa al paciente). Existen tres tipos de lavados de manos: higiénico o _____, antiséptico, asistencial y _____.